



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Bunga Rampai **PELAYANAN** **KELUARGA BERENCANA** *Dan Perencanaan Kehamilan Berkelanjutan*

Deffi Uprianti Bakri • Kursih Sulastriningsih • Ivana Devitasari
Nanin Juliana • Irma Seriana • Ika Putri Ramadhani
Lindawati

Editor: Amanda Via Maulinda



BUNGA RAMPAI: PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN PERENCANAAN KEHAMILAN BERKELANJUTAN

Penulis:

Bdn. Deffi Uprianti Bakri, S.ST., M.Keb.
Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih, S.Si.T., M.Kes.
Ivana Devitasari, S.ST., M.Tr.Keb.
Nanin Juliana, S.Kep., Ners., M.K.M.
Dr. Bdn. Irma Seriana, S.ST., M.Keb.
Bdn. Ika Putri Ramadhani, M.Biomed.
Lindawati, S.Tr.Keb., M.K.M.

Editor:

Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb., M.K.M.

Bunga Rampai: Pelayanan Keluarga Berencana Dan Perencanaan Kehamilan Berkelanjutan

Penulis:

Bdn. Deffi Uprianti Bakri, S.ST., M.Keb.
Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih, S.Si.T., M.Kes.
Ivana Devitasari, S.ST., M.Tr.Keb.
Nanin Juliana, S.Kep., Ners., M.K.M.
Dr. Bdn. Irma Seriana, S.ST., M.Keb.
Bdn. Ika Putri Ramadhani, M.Biomed.
Lindawati, S.Tr.Keb., M.K.M.

Editor: Amanda Via Maulinda, S.Tr.Keb., M.K.M.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-12-1

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga bunga rampai berjudul *Pelayanan Keluarga Berencana dan Perencanaan Kehamilan Berkelanjutan* dapat disusun dan disajikan kepada pembaca. Buku ini disusun sebagai upaya kontribusi akademik dan praktis dalam memperkaya wawasan serta memperkuat kompetensi tenaga kesehatan—khususnya bidan—dalam memberikan pelayanan keluarga berencana (KB) yang komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada kebutuhan perempuan serta keluarganya.

Keluarga berencana merupakan bagian integral dari kesehatan reproduksi yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Pelayanan KB tidak hanya berkaitan dengan pemilihan metode kontrasepsi, tetapi juga mencakup pemahaman siklus reproduksi, konseling yang tepat, pemantauan efek samping, tindak lanjut penggunaan kontrasepsi, hingga evaluasi keberhasilan pelayanan. Di sisi lain, perencanaan kehamilan yang berkelanjutan menuntut adanya pendekatan yang holistik—mempertimbangkan kondisi kesehatan, aspek psikologis, sosial, budaya, serta keterlibatan pasangan dan keluarga dalam pengambilan keputusan.

Bunga rampai ini disusun melalui rangkaian pembahasan yang saling terhubung. Chapter 1 menguraikan konsep dasar keluarga berencana dalam siklus reproduksi perempuan sebagai landasan pemahaman pelayanan KB. Chapter 2 membahas jenis-jenis kontrasepsi beserta indikasi penggunaannya guna membantu tenaga kesehatan memberikan pilihan yang tepat dan aman. Chapter 3 menekankan pentingnya konseling pemilihan kontrasepsi sesuai kebutuhan perempuan, termasuk prinsip informed choice dan pendekatan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, Chapter 4 mengulas efek samping, kontraindikasi, dan tindak lanjut penggunaan kontrasepsi sebagai bagian penting dalam menjaga kenyamanan dan keberlanjutan pemakaian metode.

Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, menjadi fokus pada Chapter 5 yang membahas pelayanan KB pascapersalinan dan interval, mengingat periode tersebut merupakan momen strategis untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dan menjaga jarak kelahiran yang ideal. Chapter 6 memperkuat perspektif layanan yang ramah keluarga dengan mengulas keterlibatan pasangan dan keluarga dalam pengambilan keputusan KB, sehingga keputusan yang diambil lebih suportif dan berkesinambungan. Terakhir, Chapter 7 membahas evaluasi keberhasilan pelayanan

keluarga berencana sebagai dasar perbaikan mutu layanan dan penguatan program di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini, baik penulis, penyunting, reviewer, maupun pihak-pihak yang mendukung proses penerbitan. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga bunga rampai ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi kesehatan, dan pemerhati kesehatan reproduksi, serta dapat mendukung terwujudnya pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada hak serta kebutuhan perempuan dan keluarga.

Juni, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA..... iii

DAFTAR ISI..... v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KELUARGA BERENCANA DALAM SIKLUS REPRODUKSI PEREMPUAN 1

- A. Pendahuluan..... 1
- B. Konsep Dasar Keluarga Berencana..... 2
- C. Kesehatan Reproduksi..... 5
- D. Konsep Dasar Keluarga Berencana Dalam Siklus Reproduksi Perempuan 8
- E. Simpulan 13

Referensi 14

Glosarium 16

CHAPTER 2 JENIS-JENIS ALAT KONTRASEPSI DAN INDIKASI BAGI PENGGUNANYA 19

- A. Pendahuluan..... 19
- B. Cara Memilih Kontrasepsi 23
- C. Indikasi Penggunaan Kontrasepsi..... 23
- D. Simpulan 23

Referensi 25

Glosarium 26

CHAPTER 3 KONSELING PEMILIHAN KONTRASEPSI SESUAI KEBUTUHAN PEREMPUAN 27

- A. Pendahuluan..... 27
- B. Konsep Dasar Konseling Kontrasepsi 28
- C. Hak Reproduksi dan Informed Choice 29
- D. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kontrasepsi 30
- E. Jenis-Jenis Metode Kontrasepsi 32
- F. Pendekatan Konseling dalam Pemilihan Kontrasepsi..... 35
- G. Konseling Berbasis Kebutuhan Perempuan 36
- H. Pengambilan Keputusan Bersama (Shared Decision Making)..... 38
- I. Efektivitas dan Keamanan Kontrasepsi 39
- J. Dokumentasi dan Tindak Lanjut Konseling 41

K. Tantangan dan Isu Terkini dalam Konseling Kontrasepsi	43
L. Simpulan	45
Referensi	47
Glosarium	50

CHAPTER 4 EFEK SAMPING, KONTRA INDIKASI, DAN TINDAK LANJUT PENGGUNAAN KONTRASEPSI..... 51

A. Pendahuluan.....	51
B. Efek Samping Kontrasepsi	52
C. Kontra Indikasi Kontrasepsi.....	55
D. Tindak lanjut Kontrasepsi.....	55
E. Kesimpulan	58
Referensi	60
Glosarium	61

CHAPTER 5 PERAN BIDAN DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) PASCAPERSALINAN DAN INTERVAL..... 62

A. Pendahuluan.....	62
B. Pelayanan KB Pascapersalinan sebagai Upaya Pencegahan Risiko Reproduksi.....	64
C. Pelayanan KB Masa Interval sebagai Strategi Perencanaan Keluarga	68
D. Peran Bidan dalam Pelayanan KB Pascapersalinan dan Masa Interval.....	71
E. Penguatan Peran Bidan dalam Pelayanan KB.....	80
F. Simpulan	82
Referensi	83
Glosarium	85

CHAPTER 6 KETERLIBATAN PASANGAN DAN KELUARGA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KB

A. Pendahuluan.....	86
B. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM BER-KB.....	87
Referensi	94

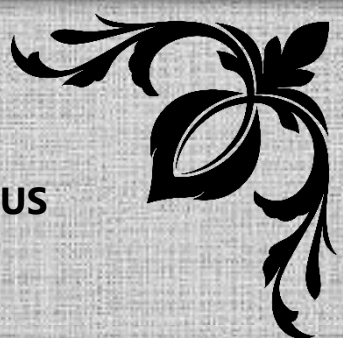
CHAPTER 7 EVALUASI KEBERHASILAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.. 96

A. Pendahuluan.....	96
B. Program Keluarga Berencana (KB).....	98
C. Tujuan Program Keluarga Berencana	100
D. Tingkat Keberhasilan dan Capaian Program Keluarga Berencana.....	103

E. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Program Keluarga Berencana	104
F. Tantangan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana	105
G. Hubungan Implementasi Program Keluarga Berencana dengan Penurunan Natalitas (Angka Kelahiran)	107
H. Kesimpulan	109
Referensi	111
PROFIL PENULIS	114



CHAPTER 1



KONSEP DASAR KELUARGA BERENCANA DALAM SIKLUS REPRODUKSI PEREMPUAN

Bdn. Deffi Uprianti Bakri, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dibutuhkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, khususnya dalam kesehatan reproduksi. Sebagai tenaga kesehatan yang memiliki posisi strategis bidan harus mempunyai kompetensi dalam hal kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari buku ajar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari kesehatan reproduksi dan keluarga berencana secara umum dan khusus. (Permatasari, et.al, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat (Cahyarini et al., 2021)

Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar (Hasanah et al., 2022). Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana) (Rahayu et al., 2022).

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan/ICPD (international Conference on Population and Development), di Kairo Mesir tahun 1994 diikuti 180 negara menyepakati perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi

dan penurunan fertilitas/keluarga berencana menjadi pendekatan yang berfokus pada kesehatan serta hak reproduksi (Permatasari, et.al, 2022).

Kesehatan perempuan merupakan elemen kunci dalam upaya mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat yang holistik. Sebagai penopang utama dalam keluarga dan komunitas, perempuan memiliki tanggung jawab yang signifikan, tidak hanya untuk menjaga kondisi kesehatannya sendiri tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan kesehatan anggota keluarganya. Meskipun demikian, perempuan sering menghadapi berbagai hambatan kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, budaya, dan ekonomi, dapat mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai kesehatan yang optimal (Mailintina, et.al, 2025)

B. Konsep Dasar Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program KB merupakan salah satu pelayanan preventif bagi kesehatan perempuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian (Suryaningsih & Sukriani, 2023).

Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua anak saja atau merupakan keluarga kecil. Terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera (Matahari et al., 2018).

Keluarga berencana adalah upaya untuk membangun keluarga yang baik dengan mendukung, melindungi, dan membantu orang dalam menikmati hak reproduksi serta menyediakan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal. Ini termasuk mengontrol jumlah, jarak, dan usia ideal untuk melahirkan anak, mengontrol kehamilan, dan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Fitrianto & Farhan, 2023).

Sesuai dengan keamanan medis, pasangan dapat menggunakan KB untuk menunda kelahiran anak pertama (post poning), menjarangkan anak (spacing), atau membatasi jumlah anak yang diinginkan (limiting). Program ini juga memungkinkan pasangan untuk mempertimbangkan kembalinya fase kesuburan (ferundity). Penyuluhan kesehatan adalah bagian penting dari perawatan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi karena selain membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang mereka inginkan, mereka juga membantu mereka menggunakannya lebih lama, yang membuat mereka lebih bahagia. Pada akhirnya, penyuluhan ini dapat membantu program KB berhasil (Wahyuningtyas et al., 2022).

Praktik kontrasepsi memengaruhi kesuburan dengan mengurangi kemungkinan pembuahan. Metode kontrasepsi sangat bervariasi dalam keefektifan teoretisnya dan dalam keefektifannya yang sebenarnya dalam penggunaan ("efektivitas penggunaan"). Metode modern seperti pil oral dan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) memiliki tingkat efektivitas penggunaan lebih dari 95 persen. Metode lama seperti kondom dan diafragma bisa lebih dari 90 persen efektif bila digunakan secara teratur dan benar, tetapi rata-rata efektivitas penggunaannya lebih rendah karena penggunaan yang tidak teratur atau salah. Efek pada kesuburan tindakan kontrasepsi dapat menjadi dramatis: jika fekundabilitas adalah 0,20 (20 persen peluang kehamilan per bulan paparan), maka metode efektif 95 persen akan mengurangi ini menjadi 0,01 (peluang 1 persen).

Akses ke layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB) sangat penting bagi kesehatan perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Meningkatkan akses ke layanan KB secara global dapat membantu mencegah kematian ibu dan mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan. Setiap tahun, sekitar 295.000 wanita meninggal akibat komplikasi selama kehamilan dan persalinan, hampir semuanya di negara berkembang. Diperkirakan juga sekitar sepertiga kematian ibu dapat dicegah setiap tahun jika wanita yang tidak ingin hamil memiliki akses dan menggunakan kontrasepsi yang efektif (KFF, 2021; Liu & Raftery, 2020).

Laporan Bank Dunia baru-baru ini menunjukkan bahwa akses ke layanan keluarga berencana yang komprehensif tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kehidupan perempuan, anak-anak dan keluarga, tetapi juga merupakan salah satu kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat transisi demografi di negara-negara yang terus-menerus memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. tingkat kesuburan. Percepatan ini akan menghasilkan struktur usia penduduk yang lebih menguntungkan, di mana jumlah penduduk usia kerja yang lebih besar, dan dengan kebijakan yang tepat, dapat menghasilkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang sangat dibutuhkan (Goodkind, Lollock, Choi, McDevitt, & West, 2018; Gragnolati, 2016).

2. Ruang Lingkup Keluarga Berencana

Lingkup Keluarga Berencana Secara umum, ruang lingkup program KB diantaranya antara lain sebagai berikut (Sunaryati et al., 2020).

- a. Keluarga berencana, meliputi pengaturan kelahiran melalui promosi, konseling, dan pelayanan kontrasepsi.
- b. Kesehatan reproduksi remaja, meliputi pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dan pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada remaja.
- c. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga, meliputi peningkatan ekonomi dan gizi keluarga, serta bina keluarga balita dan remaja.
- d. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, meliputi pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas keluarga melalui program parenting.
- e. Keserasian kebijakan kependudukan, meliputi sinkronisasi program KB dengan kebijakan kependudukan, dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
- f. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi Pelatihan dan pengembangan SDM pengelola program KB.
- g. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan dengan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program KB

3. Tujuan Keluarga Berencana

Tujuan Keluarga Berencana Program keluarga berencana merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui:

- a. Waktu, jarak dan jumlah kehamilan.
- b. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
- d. Mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Peranan KB sangat diperlukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, unsafe abortion dan komplikasi yang pada akhirnya dapat mencegah kematian ibu.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana (Kurnia & Rohmatin, 2022).

4. Manfaat Keluarga Berencana

Manfaat Keluarga Berencana :

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayi Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi.

Selain itu, program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

- b. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak Dengan program KB, suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya, jarak anak pertama dan kedua antara 3-5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI dengan maksimal, yaitu dari ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahun. Tidak hanya itu, anak juga jadi bisa mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya selama masa perkembangannya. Kedua hal ini tentu akan sangat berdampak positif untuknya.
- c. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan Suami dan istri yang tidak menjalankan program KB berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan.
- d. Mencegah penyakit menular seksual Meski dilakukan antar suami istri, hubungan seksual tidak terlepas dari risiko terjadinya penyakit menular seksual, seperti sifilis, gonore, hingga HIV/AIDS. Namun, hal ini bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi, seperti kondom
- e. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Kasus ini masih sering dijumpai di masyarakat, terutama pada kehamilan yang berisiko tinggi mengalami komplikasi, seperti pada wanita berusia lebih 35 tahun, wanita yang memiliki penyakit kronis tertentu, dan wanita yang baru saja melahirkan.
- f. Membentuk keluarga yang berkualitas Semua yang direncanakan dengan baik juga bisa berbuah baik. Dalam hal ini, merencanakan kehamilan dan jumlah anak bukan cuma masalah waktu, tapi juga soal ekonomi, pendidikan anak, dan pola asuh (Kurnia & Rohmatin, 2022).

C. Kesehatan Reproduksi

1. Pengertian

Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. (PP RI No.61, 2014)

Dalam Pasal 71 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan

sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

Menurut *World Health Organization* (WHO), Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya.

Kesehatan reproduksi merupakan konsep multidimensi yang mengacu pada definisi kesehatan secara umum dan dikembangkan dalam konteks hak asasi manusia dan pembangunan kesehatan (Committee et al., 2024; Katara, 2018).

Kesehatan reproduksi dapat dimaknai sebagai kondisi Sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang lengkap, tidak hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, dan semua aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Seorang individu yang sehat reproduksi memiliki kemampuan dan kehidupan seks yang memuaskan, aman, mampu bereproduksi dan memiliki kewenangan dalam memutuskan keinginan, harapan, dan waktu bereproduksi (Ghebreyesus & Narasimhan, 2024).

Kesehatan reproduksi termasuk komponen dari hak reproduksi yang mengacu pada hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan informasi, mampu mengakses metode perencanaan keluarga dan kontrasepsi; layanan kesehatan yang memadai selama masa kehamilan dan persalinan yang aman, dan memberikan pasangan peluang untuk bereproduksi dan memiliki keturunan yang sehat (Black et al., 2016).

Kesehatan reproduksi yaitu suatu kondisi sejahtera fisik, mental, sosial secara utuh, dan bukan sekedar bebas dari penyakit dan kecacatan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Definisi ini menekankan bahwa sehat reproduksi berkaitan dengan ketiadaan gangguan biologis, dan mencakup kesejahteraan dalam konteks kehidupan sehari-hari individu dan pasangan (Fund & Rights, 2014; World Health Organization (WHO), 2025). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kedisabilitas (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun, 2025).

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi terdiri dari sepuluh aspek meliputi:

- a. Upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup;
- b. Pelayanan pengaturan kehamilan;
- c. Pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan;
- d. Upaya kesehatan seksual;
- e. pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis atau korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan;
- f. Upaya Kesehatan reproduksi pada kondisi khusus;
- g. Partisipasi masyarakat;
- h. Pencatatan dan pelaporan;
- i. Pembinaan dan pengawasan; dan
- j. Pendanaan. Penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi tersebut dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, 2025).

Pendekatan siklus hidup (life-cycle people-centered approach) menjadi landasan penting dalam memahami kesehatan reproduksi. Pendekatan siklus hidup dimulai dengan konsep bahwa kesejahteraan dan kemampuan individu, khususnya kesehatannya bergantung pada proses kumulatif dan saling terkait dalam kehidupan (Mishra et al., 2010). Dalam konteks kesehatan individu tentunya seluruh proses tersebut membutuhkan akses ke perawatan kesehatan, kehidupan individu di lingkungan yang aman, dan akumulasi pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Fase-fase tertentu dalam kehidupan sangat penting untuk proses ini. Fase tersebut dimulai dari tahun-tahun awal kehidupan, dan kelangsungan hidup adalah kuncinya. Selanjutnya, fase pendidikan anak usia dini dan semua pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi secara bertahap akan membangun pola keterampilan sosial dan menjadi pondasi penting yang dibutuhkan untuk kehidupan yang optimal hingga usia lanjut (Fund, 2021).

Konsep pendekatan siklus hidup menunjukkan bahwa setiap rentang hidup individu terkait kemampuan, kesehatan, produktivitas dalam hal ekonomi bergantung pada pilihan yang dibuat pada tahap awal siklus hidup, dan setiap langkah dalam hidup saling terhubung dan mengarah ke langkah berikutnya. Pembangunan manusia, lingkungan yang mendukung, dan tersedianya layanan kesehatan reproduksi dan seksual, serta akses informasi terhadap peluang di sepanjang siklus hidup, merupakan kunci untuk menilai komitmen ICPD di Kairo yang menempatkan individu sebagai pusat pembangunan. Kemajuan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi atau infrastruktur, tetapi

dari sejauh mana hak setiap orang dihormati dan dipenuhi. Ketika hak individu dalam kesehatan reproduksi dan seksual terpenuhi, proses pembangunan akan memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat, baik secara bersama-sama maupun pada tingkat individu (Fund, 2021).

Pendekatan siklus hidup dalam kesehatan reproduksi dan seksual menekankan perencanaan dan pelaksanaan intervensi yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesehatan individu di setiap tahapan kehidupannya. Layanan kesehatan dirancang dengan model dan prosedur yang mempertimbangkan keterkaitan antar fase kehidupan. (Committee et al., 2024; Fund, 2021).

Upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi melalui pendekatan siklus hidup bertujuan untuk memberikan kontribusi penting terhadap kesehatan, termasuk akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi dan seksual, promosi kesehatan dan kelangsungan hidup anak, serta perencanaan keluarga (Fund, 2021).

Sejak Konferensi ICPD di Kairo, berbagai penelitian mendukung penggunaan pendekatan siklus hidup yang terintegrasi karena mampu menggambarkan kesinambungan kesehatan reproduksi serta keterkaitan antara berbagai faktor yang memengaruhinya (Ghebreyesus & Narasimhan, 2024; Mishra et al., 2010; Weerasinghe et al., 2025).

Berbagai studi menunjukkan bahwa kondisi kesehatan reproduksi seseorang saat ini sering kali berhubungan dengan pengalaman pada tahap kehidupan sebelumnya, mulai dari masa konsepsi, bayi dan anak-anak, remaja, usia reproduktif, masa pascareproduksi, hingga lanjut usia (Fund, 2021).

Selaras dengan hal tersebut, dokumen WHO *Health for All in Europe* juga menekankan bahwa setiap tahap kehidupan memiliki kebutuhan kesehatan dasar yang berbeda dan perlu dipenuhi secara berkesinambungan (Fund, 2021).

D. Konsep Dasar Keluarga Berencana Dalam Siklus Reproduksi Perempuan

Berdasarkan hasil Putu Gadis Arvia Puspa tahun 2025 keluarga berencana dan realitas reproduksi perempuan bali dalam menentukan hak kesehatan reproduksi dalam sistem masyarakat adat di bali temuan wawancara, perempuan bali melihat anjuran dari gubernur terkait dorongan melakukan program KB Bali empat anak demi melestarikan budaya (Putu, Made, Nyoman, ketut). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan KB Bali empat anak memperkuat beban reproduksi perempuan Bali baik secara biologis maupun sosial melalui pembagian kerja berbasis gender yang patriarki mulai dari kerja rumah tangga, kontrol atas tubuh

oleh suami, keluarga, maupun negara, serta pembebanan tanggung jawab kontrasepsi yang dominan hanya diperuntukkan pada perempuan. Kebijakan ini tidak memberikan ruang bagi otonomi tubuh dan pilihan reproduksi perempuan.

Oleh karena itu, pendekatan berperspektif perempuan dan keadilan reproduksi yang menempatkan perempuan sebagai subjek otonom sangat penting dihadirkan dalam setiap kebijakan. Penelitian ini masih terbatas pada spesifik beban reproduksi biologis terkait hak kesehatan reproduksi dalam hal ini tentang KB Bali empat anak dan alat kontrasepsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti lebih lanjut hak kontrasepsi dalam kaitannya dengan aksesibilitas, pengambilan keputusan bersama antara pasangan, keterlibatan laki-laki dalam tanggung jawab kontraseptif, serta dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan. Penelitian lanjutan juga perlu memperluas cakupan wilayah dan menggali pengalaman kelompok perempuan dari latar sosial ekonomi yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan lebih berdampak dalam membentuk kebijakan kesehatan yang inklusif dan setara gender (Arvia Puspa, 2025).

Kesehatan reproduksi menurut Kemenkes RI (2015) adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Keluarga Berencana (KB) Adalah perencanaan kehidupan masing-masing suami istri dalam melahirkan dan mendidik anak sebagaimana yang diinginkan. Kontrasepsi adalah upaya mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap. Kontrasepsi dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, secara mekanis, menggunakan obat/alat, atau dengan operasi. KB telah dirancang oleh pemerintah sejak tahun 1970 dengan berdirinya Badan Kordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tenaga kesehatan klinis meliputi dokter, bidan, dan perawat memiliki peran fundamental dalam memastikan terselenggaranya layanan Keluarga Berencana (KB) yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Pelayanan KB harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi yang memadai baik dari aspek pengetahuan, keterampilan klinis, dan kapasitas manajemen risiko, untuk menjamin keselamatan, efektivitas, dan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi. Uraian berikut menyajikan peran masing-masing kategori tenaga kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam berbagai sumber literatur (Kusumawardani, 2026).

Konsep Kesehatan Reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan (*life-cycle-approach*) atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur (*from womb to tomb*) atau biasa juga disebut dengan "*Continuum of care women cycle*". Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan hal ini disebabkan status

kesehatan perempuan semasa kanak-kanak dan remaja memengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi yaitu saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang dialami sepanjang hidup perempuan merupakan akar masalah yang mendasar yang menyebabkan buruknya kesehatan perempuan saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Tingkat pendidikan, kualitas dan kuantitas makanan, nilai dan sikap, sistem kesehatan yang tersedia dan bisa diakses, situasi ekonomi, serta kualitas hubungan seksualnya memengaruhi perempuan dalam menjalankan masa reproduksinya. (Everett S, 2022)

Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan kesehatan reproduksi dilakukan secara teknis dan berhubungan dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan. Supervisi teknis dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan pelayanan yang sudah diberikan dengan standar pelayanan yang berlaku, ketika ditemukan adanya perbedaan maka dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun rencana selanjutnya sehingga terjadi peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu

Praktik kontrasepsi memengaruhi kesuburan dengan mengurangi kemungkinan pembuahan. Metode kontrasepsi sangat bervariasi dalam keefektifan teoretisnya dan dalam keefektifannya yang sebenarnya dalam penggunaan ("efektivitas penggunaan"). Metode modern seperti pil oral dan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) memiliki tingkat efektivitas penggunaan lebih dari 95 persen. Metode lama seperti kondom dan diafragma bisa lebih dari 90 persen efektif bila digunakan secara teratur dan benar, tetapi rata-rata efektivitas penggunaannya lebih rendah karena penggunaan yang tidak teratur atau salah. Efek pada kesuburan tindakan kontrasepsi dapat menjadi dramatis: jika fekundabilitas adalah 0,20 (20 persen peluang kehamilan per bulan paparan), maka metode efektif 95 persen akan mengurangi ini menjadi 0,01 (peluang 1 persen).

Fase kehamilan dan persalinan merupakan momentum krusial dalam siklus reproduksi di mana intervensi Keluarga Berencana (KB) bertransformasi dari sekadar alat edukasi pra-nikah menjadi strategi perencanaan keselamatan ibu dan anak. Peran program KB pada periode ini diintegrasikan secara ketat ke dalam standar pelayanan perawatan masa kehamilan atau *Antenatal Care* (ANC) terpadu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, setiap tenaga kesehatan diwajibkan untuk memberikan konseling kontrasepsi sejak masa kehamilan trimester ketiga. Edukasi yang diberikan sejak dini ini bertujuan agar ibu hamil dan pasangan memiliki waktu yang cukup untuk memahami, memilih, dan memutuskan metode kontrasepsi yang akan langsung dipasang segera setelah proses melahirkan selesai.

Tujuan utama dari pemberian konseling KB pada fase ini adalah mempromosikan program KB Pascapersalinan (KBPP) guna memastikan perlindungan kontrasepsi langsung berjalan tanpa jeda berbahaya. Merujuk pada panduan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN (2022), pemanfaatan KBPP dalam waktu 42 hari setelah melahirkan sangat efektif dalam menekan angka kehamilan yang tidak direncanakan (*unintended pregnancy*). Dengan matangnya perencanaan metode kontrasepsi sejak sebelum persalinan, pasangan suami istri dapat menghindari kecemasan psikologis dan risiko medis akibat kehamilan yang terlalu dekat, sehingga proses persalinan dapat dihadapi dengan tenang dan berorientasi pada pemulihan kesehatan ibu secara total.

Memasuki fase pasca-persalinan dan menyusui, tubuh seorang perempuan mengalami transisi fisik serta hormonal yang besar sehingga membutuhkan waktu pemulihan yang cukup sebelum siap menempuh kehamilan berikutnya. Berdasarkan kajian klinis dalam *Journal of Health Sciences and Medical Research* (2025), jarak kehamilan yang terlalu dekat—kurang dari 24 bulan setelah persalinan sebelumnya—berkorelasi kuat dengan peningkatan risiko kematian ibu akibat perdarahan hebat, robekan rahim, serta anemia berat. Oleh karena itu, target utama pelayanan KB pada masa laktasi ini adalah penjarangan kehamilan (*spacing*) secara ketat demi memberikan kesempatan bagi organ reproduksi ibu untuk pulih sempurna sekaligus mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal.

Selama periode menyusui eksklusif, program KB menawarkan solusi medis berupa metode kontrasepsi yang aman dan tidak mengganggu produksi maupun kualitas air susu ibu (ASI). Mengacu pada buku saku *Pelayanan Kontrasepsi Berdasarkan Panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)* yang diadopsi oleh BKKBN (2023), pilihan kontrasepsi pada fase menyusui difokuskan pada metode non-hormonal atau hormonal berbasis progestin saja. Pilihan ideal yang sangat direkomendasikan meliputi Metode Amenore Laktasi (MAL) sebagai kontrasepsi alami sementara, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) pasca-plasenta, implan satu atau dua batang, serta suntikan progestin. Penerapan metode yang tepat ini memastikan bahwa hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan dan ASI lanjutan hingga dua tahun tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh kehamilan baru yang tidak terencana.

Masa di antara dua kehamilan merupakan fase di mana pasangan usia subur berada pada puncak masa reproduksi aktif, namun telah memiliki anak dan ingin mengatur penjarangan kelahiran berikutnya. Pada fase ini, program Keluarga Berencana (KB) berfokus pada pemeliharaan kesehatan reproduksi yang stabil untuk mendukung kesejahteraan ekonomi, psikologis, dan kualitas pengasuhan dalam keluarga. Berdasarkan studi epidemiologi yang dirilis dalam *Journal of Public Health*

and Clinical Sciences (JPHCS) (2025), pengaturan jarak kelahiran yang ideal antara 3 hingga 5 tahun terbukti secara signifikan menurunkan beban stres pengasuhan pada ibu dan mencegah penelantaran emosional pada anak usia dini. KB hadir sebagai instrumen manajemen keluarga agar setiap anak yang dilahirkan mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan gizi yang seimbang tanpa harus berkompetisi dengan kehadiran adik baru terlalu cepat.

Dalam aspek medis dan klinis, pelayanan KB pada masa usia subur aktif ini sangat mengarahkan pasangan untuk beralih ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) karena efektivitasnya yang sangat tinggi dan tingkat kegagalan yang sangat rendah. Merujuk pada Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2024), penggunaan MKJP seperti Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) dan implan sangat direkomendasikan bagi pasangan yang ingin menjarangkan kehamilan dalam jangka waktu 3 hingga 8 tahun. Pilihan ini dinilai lebih aman dan ekonomis dibandingkan metode non-MKJP seperti pil atau suntik yang membutuhkan kepatuhan tinggi dan kunjungan berulang ke fasilitas kesehatan, sehingga perempuan usia subur dapat tetap produktif di luar rumah tangga tanpa mencemaskan risiko kehamilan yang tidak direncanakan.

Fase klimakterium yang meliputi masa pre-menopause hingga menopause menandai akhir dari siklus reproduksi seorang perempuan, di mana fungsi organ ovarium mulai mengalami penurunan secara progresif. Pelayanan KB pada fase transisi kritis ini mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula bertujuan menjarangkan kehamilan (*spacing*) berubah total menjadi fase menghentikan atau membatasi kehamilan (*limitation*). Berdasarkan laporan kesehatan reproduksi dari Kementerian Kesehatan RI (2023), kehamilan yang terjadi pada perempuan berusia di atas 35 tahun dikategorikan sebagai kehamilan risiko tinggi (KRT) yang berbahaya. Kehamilan di usia senja ini memicu lonjakan angka morbiditas maternal akibat komplikasi berat seperti diabetes gestasional, stroke, perdarahan pasca-salin, hingga peningkatan risiko kelainan kromosom (seperti Down Syndrome) pada janin yang dikandung.

Oleh karena risiko medis yang sangat fatal tersebut, strategi utama program KB pada fase klimakterium difokuskan pada penggunaan kontrasepsi mantap atau metode non-hormonal jangka panjang yang aman bagi tubuh yang mulai menua. Menurut petunjuk teknis pelayanan kontrasepsi bagi wanita usia perwujudan akhir oleh BKKBN dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) (2026), metode yang paling disarankan adalah Metode Operasi Wanita (MOW/Tubektomi) bagi perempuan, atau Metode Operasi Pria (MOP/Vasektomi) bagi pasangannya jika kondisi kesehatan perempuan tidak memungkinkan untuk tindakan bedah. Jika pasangan menolak sterilisasi,

alternatif aman lainnya adalah pemasangan IUD tembaga non-hormonal, guna menghindari penggunaan kontrasepsi hormonal dosis tinggi yang dapat memperburuk risiko penyakit kardiovaskular dan pembekuan darah pada perempuan yang mendekati masa menopause.

E. Simpulan

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan pilar utama dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan melalui pendekatan sepanjang siklus kehidupan (*continuum of care*). Implementasi program ini telah mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula berfokus pada pengendalian populasi menjadi pendekatan terintegrasi yang berpusat pada pemenuhan hak-hak reproduksi, kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup perempuan secara holistik. Sebagai intervensi preventif, pelayanan KB yang berkualitas terbukti efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, serta meminimalkan berbagai komplikasi obstetri berbahaya. Pada akhirnya, keberhasilan manajemen KB ini secara signifikan berkontribusi langsung terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Dalam penerapannya di setiap fase reproduksi, strategi pelayanan KB disesuaikan secara dinamis mengikuti kebutuhan klinis dan psikologis perempuan. Fase transisi ini dimulai dari masa remaja dan pra-nikah yang berfokus pada aspek promotif-edukatif untuk mendorong Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta penundaan kehamilan pertama hingga organ reproduksi matang. Selanjutnya, pada fase kehamilan, persalinan, dan laktasi, fokus diarahkan pada program KB Pascapersalinan (KBPP) menggunakan metode yang aman bagi ibu menyusui agar hak bayi mendapatkan ASI eksklusif tidak terganggu. Pada masa usia subur aktif, pasangan diarahkan pada penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk menjaga jarak kelahiran yang ideal demi kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Hingga pada fase akhir yaitu klimakterium, KB bertindak sebagai pembatas kehamilan (*limitation*) guna melindungi perempuan dari risiko medis kehamilan usia tua yang fatal. Melalui keterpaduan pengelolaan di setiap fase tersebut, KB berhasil membangun ketahanan keluarga yang kuat serta mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih berkualitas.

Referensi

- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Permatasari, D. (2022). Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Sidabutar, E. (2020) 'Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Bencana', Humanitarian Programme Analyst UNFPA
- The Open University. (2022). Family Planning Module: 1. An Overview of Population and Family Planning: View as single page. Retrieved 17 February 2022, from [https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=136 &printable=1](https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=136&printable=1)
- World Health Organization, 2019. Keluarga berencana dan Macam- macam alat kontrasepsi
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Panduan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan pencegahan perkawinan anak*. BKKBN BKKBN 2021.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Buku saku pelayanan kontrasepsi berdasarkan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)*. BKKBN BKKBN 2023.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2024). *Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)*. BKKBN BKKBN 2024.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, & Kementerian Agama RI. (2023). Sinergitas bimbingan perkawinan (bimwin) calon pengantin dalam penurunan angka perkawinan anak dan stunting. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Keluarga*, 5(2), 112–125 BKKBN & Kemenag 2023.
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. (2026). *Pengembangan program generasi berencana (GenRe) dan aplikasi elsimil bagi remaja Indonesia*. DPPKB Official DPPKB 2026.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan*. Kementerian Kesehatan RI Kemenkes 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Strategi nasional kesehatan reproduksi dan pelayanan KB risiko tinggi*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes 2023.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, & Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). *Pedoman teknis pelayanan keluarga berencana pascapersalinan (KBPP) dalam upaya penurunan angka kematian ibu*. Kementerian Kesehatan RI Kemenkes & BKKBN 2022.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Lembaran Negara Republik Indonesia UU 52/2009.
- Sari, D. P., & Lestari, W. (2024). Dampak kehamilan usia dini terhadap risiko preeklampsia dan kelahiran prematur. *Journal of Student Scientific Research (JSSR)*, 2(1), 45–58 JSSR 2024.
- Utami, R., Susilowati, E., & Handayani, T. (2025). Analisis jarak kelahiran terhadap risiko morbiditas maternal dan keberhasilan menyusui eksklusif. *Journal of Health Sciences and Medical Research*, 4(3), 201–214 JHSMR 2025.
- Wahyuni, S. (2025). Hubungan pengaturan jarak kehamilan berbasis MKJP dengan tingkat stres pengasuhan dan kesejahteraan keluarga. *Journal of Public Health and Clinical Sciences (JPHCS)*, 7(1), 89–99 JPHCS 2025.

Glosarium

AKB (Angka Kematian Bayi): Indikator yang menunjukkan jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu.

AKI (Angka Kematian Ibu): Indikator yang menunjukkan jumlah kematian perempuan selama kehamilan, persalinan, dan nifas per 100.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu.

AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) / IUD (*Intrauterine Device*): Alat kontrasepsi modern berbentuk huruf T kecil yang dipasang di dalam rahim perempuan untuk mencegah pembuahan, dengan efektivitas penggunaan yang sangat tinggi.

ANC (*Antenatal Care*): Pelayanan pemeriksaan kesehatan terpadu berkala yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada perempuan selama masa kehamilannya.

Continuum of Care: Pendekatan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan sepanjang siklus hidup perempuan, mulai dari janin hingga usia lanjut.

Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil): Aplikasi skrining dan pendampingan kesehatan berbasis digital dari BKKBN yang wajib diisi oleh calon pengantin sebelum menikah untuk mendeteksi risiko stunting.

Fekundabilitas: Probabilitas atau peluang seorang perempuan untuk mengalami kehamilan dalam satu siklus menstruasi atau satu bulan paparan seksual tanpa kontrasepsi.

GenRe (Generasi Berencana): Program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui perencanaan pendidikan, karier, pernikahan, dan kesehatan reproduksi.

ICPD (*International Conference on Population and Development*): Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo (1994) yang mengubah arah program kependudukan dunia dari pengendalian populasi menjadi pemenuhan hak reproduksi.

KBPP (Keluarga Berencana Pascapersalinan): Pemanfaatan metode kontrasepsi yang dipasang segera setelah melahirkan hingga waktu 42 hari (6 minggu) pasca-persalinan.

KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi): Proses penyampaian pesan, pengetahuan, dan bimbingan yang dilakukan secara terencana untuk mengubah perilaku masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

Klimakterium: Fase transisi atau masa peralihan dalam kehidupan reproduksi perempuan yang meliputi pre-menopause hingga pasca-menopause, ditandai dengan penurunan fungsi ovarium.

KRT (Kehamilan Risiko Tinggi): Kondisi kehamilan yang memiliki kemungkinan lebih besar menyebabkan komplikasi medis, kesakitan, atau kematian pada ibu dan janin (misalnya hamil di atas usia 35 tahun).

Limiting (Pembatasan Kehamilan): Strategi penggunaan kontrasepsi untuk menghentikan kehamilan sama sekali karena pasangan telah mencapai jumlah anak yang diinginkan atau karena alasan medis.

MAL (Metode Amenore Laktasi): Metode kontrasepsi alami sementara yang mengandalkan pemberian ASI eksklusif secara penuh untuk menekan ovulasi pada ibu pasca-melahirkan.

MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang): Jenis kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dan masa perlindungan lama (antara 3 hingga 10 tahun), meliputi IUD, implan, serta sterilisasi (MOW/MOP).

MOW (Metode Operasi Wanita) / Tubektomi: Prosedur kontrasepsi mantap berupa pembedahan kecil untuk mengikat atau memotong saluran telur (tuba fallopii) agar tidak terjadi pembuahan.

Postponing (Penundaan Kehamilan): Strategi penggunaan kontrasepsi yang bertujuan menunda kehamilan anak pertama, biasanya disarankan bagi ibu berusia di bawah 20 tahun.

Preeklampsia: Gangguan kehamilan serius yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urine, sering terjadi pada kehamilan usia dini.

PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan): Upaya untuk meningkatkan usia pernikahan pertama guna mencapai kematangan fisik dan mental sebelum berkeluarga.

Spacing (Penjarangan Kehamilan): Pengaturan jarak antara kelahiran anak yang satu dengan kelahiran anak berikutnya demi kesehatan ibu dan anak (jarak ideal 3-5 tahun).

Unintended Pregnancy (Kehamilan Tidak Diinginkan): Kehamilan yang terjadi ketika pasangan sebenarnya tidak merencanakan atau tidak mengharapkan kehamilan pada waktu tersebut.

WUS (Wanita Usia Subur): Perempuan yang berada dalam periode usia reproduksi aktif, biasanya berkisar antara usia 15 hingga 49 tahun.

CHAPTER 2

JENIS-JENIS ALAT KONTRASEPSI DAN INDIKASI BAGI PENGGUNANYA

Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih, S.Si.T., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kontrasepsi merupakan salah satu upaya penting dalam program keluarga berencana (KB) yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran, mengatur jarak kehamilan, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Alat dan obat kontrasepsi digunakan oleh pasangan usia subur sebagai sarana untuk merencanakan jumlah anak sesuai dengan kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi keluarga. Berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 1 Tahun 2023, pelayanan keluarga berencana tidak hanya berfokus pada penyediaan alat kontrasepsi, tetapi juga mencakup kegiatan edukasi, promosi, penanganan efek samping, hingga perlindungan hak reproduksi pasangan usia subur.

Di Indonesia, metode kontrasepsi yang umum digunakan meliputi alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD), implan, pil KB, suntik KB, kondom, serta metode operasi wanita dan pria. Setiap metode memiliki karakteristik, efektivitas, keuntungan, serta efek samping yang berbeda sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun pasangan.

Penggunaan kontrasepsi di berbagai negara Asia menunjukkan angka yang cukup tinggi, khususnya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tingkat penggunaan kontrasepsi di beberapa negara Asia mencapai lebih dari 70%, dengan angka tertinggi terdapat di Cina sebesar 83%, sedangkan Afghanistan dan Timor Leste menunjukkan angka penggunaan yang relatif rendah, yaitu sekitar 29% (Putri et al., 2019). Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan, akses pelayanan kesehatan, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi penggunaan kontrasepsi.

Pemilihan metode kontrasepsi memerlukan pertimbangan yang matang karena berkaitan dengan kondisi kesehatan, usia, jumlah anak, serta kenyamanan pengguna. Kurangnya pengetahuan mengenai keluarga berencana masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pasangan usia subur ragu dalam memilih alat kontrasepsi. Tidak sedikit pasangan yang telah memiliki anak tetapi masih takut atau bingung menentukan metode yang sesuai. Oleh sebab itu, konseling yang

berkualitas sangat diperlukan agar calon akseptor mampu memahami manfaat, risiko, dan efektivitas setiap metode kontrasepsi (Yosefa, 2020).

Dalam pelaksanaan pelayanan KB, bidan memiliki peran strategis sebagai tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengetahuan dan kompetensi bidan sangat menentukan kualitas edukasi serta konseling yang diberikan kepada pasangan usia subur. Tingkat pendidikan dan kemampuan komunikasi bidan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan kontrasepsi yang aman dan efektif (Aditya et al., 2023).

1. Jenis-Jenis Kontrasepsi

Metode alat kontrasepsi dibedakan menjadi alat kontrasepsi hormonal dan alat kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi hormonal bekerja dengan memengaruhi sistem hormon reproduksi untuk mencegah terjadinya kehamilan, sedangkan kontrasepsi non-hormonal bekerja tanpa memengaruhi hormon tubuh. Selain itu, terdapat pula metode kontrasepsi permanen dan metode alami yang digunakan sesuai kebutuhan pasangan.

a. Kontrasepsi Hormonal

1) Pil Kb Kombinasi

Pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bekerja dengan menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks, serta mengubah kondisi endometrium sehingga implantasi sulit terjadi. Pil ini dikonsumsi setiap hari dan memiliki efektivitas tinggi apabila digunakan secara teratur. Efek samping yang dapat muncul antara lain perubahan pola menstruasi, mual, sakit kepala, nyeri payudara, perubahan berat badan, serta perubahan suasana hati. Meskipun demikian, sebagian besar efek samping bersifat sementara dan akan berkurang setelah beberapa bulan penggunaan.

2) Pil Hormon Progestin

Pil progestin atau minipil merupakan kontrasepsi hormonal yang hanya mengandung hormon progesteron. Metode ini cocok digunakan oleh ibu menyusui karena tidak memengaruhi produksi ASI. Cara kerjanya yaitu dengan mengentalkan lendir serviks, menghambat pergerakan sperma, dan mengubah lapisan endometrium.

Penggunaan pil progestin harus dilakukan secara disiplin setiap hari agar efektivitasnya tetap optimal.

3) Pil Kb Darurat (Emergency Contraceptive Pills)

Pil kontrasepsi darurat digunakan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan atau ketika terjadi kegagalan metode kontrasepsi, seperti kondom bocor atau lupa mengonsumsi pil KB. Penggunaan pil ini sebaiknya

dilakukan sesegera mungkin karena efektivitasnya akan menurun seiring bertambahnya waktu.

4) Kb Suntik Kombinasi

Suntik KB kombinasi diberikan setiap satu bulan sekali dan bekerja dengan mencegah ovulasi serta menghambat pertemuan sperma dan ovum. Metode ini banyak dipilih karena praktis dan tidak memerlukan konsumsi harian seperti pil KB. Namun demikian, pengguna dapat mengalami efek samping berupa perubahan pola haid, sakit kepala, dan peningkatan berat badan.

5) Suntikan Progestin

Suntikan progestin diberikan setiap tiga bulan sekali dan termasuk metode kontrasepsi jangka menengah yang cukup efektif. Selain mencegah ovulasi, metode ini juga menyebabkan lapisan rahim menjadi tipis sehingga implantasi tidak terjadi. Keunggulan suntik progestin antara lain mampu mengurangi risiko kanker endometrium dan anemia. Akan tetapi, kesuburan biasanya tidak langsung kembali setelah penghentian penggunaan.

6) Implan/Susuk KB

Implan merupakan alat kontrasepsi berbentuk batang kecil yang dipasang di bawah kulit lengan atas. Metode ini dapat bertahan selama 3–7 tahun tergantung jenisnya. Implan bekerja dengan melepaskan hormon progesteron secara perlahan untuk mencegah ovulasi. Implan memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dan cocok bagi perempuan yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang tanpa perlu mengingat penggunaan harian.

7) AKDR dengan Progestin

AKDR hormonal merupakan alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung hormon progestin. Alat ini bekerja dengan menghambat pergerakan sperma, mengubah kondisi endometrium, dan mencegah terjadinya pembuahan. Keunggulan metode ini yaitu efektivitasnya tinggi serta dapat mengurangi nyeri haid dan jumlah perdarahan menstruasi.

b. Kontrasepsi Non-Hormonal

1) Kondom

Kondom merupakan alat kontrasepsi berbahan lateks yang digunakan untuk mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi perempuan. Selain efektif mencegah kehamilan, kondom juga mampu melindungi pengguna dari penyakit menular seksual. Kondom mudah diperoleh dan tidak menimbulkan efek samping hormonal, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketepatan penggunaan.

2) AKDR/IUD

AKDR atau IUD adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sperma dan ovum. Metode ini memiliki efektivitas tinggi dan dapat digunakan dalam jangka panjang hingga lebih dari 10 tahun. IUD cocok digunakan oleh perempuan yang menginginkan metode praktis dan tidak perlu penggunaan rutin setiap hari.

3) Diafragma

Diafragma merupakan alat kontrasepsi berbentuk kubah yang dipasang di dalam vagina sebelum hubungan seksual. Alat ini berfungsi menutup serviks sehingga sperma tidak dapat masuk ke rahim. Meskipun tidak ada kandungan hormon, pengguna diafragma memerlukan keterampilan dan ukuran yang sesuai agar efektivitasnya lebih optimal.

4) Spermisida

Spermisida adalah bahan kimia berbentuk gel, krim, atau busa yang digunakan untuk membunuh sperma sebelum mencapai sel telur. Biasanya spermisida digunakan bersama metode kontrasepsi lain untuk meningkatkan efektivitas.

c. Kontrasepsi Permanen

1) Tubektomi

Tubektomi merupakan prosedur sterilisasi pada perempuan dengan cara memotong atau menutup tuba falopi sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sperma. Metode ini bersifat permanen dan umumnya dipilih oleh pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi.

2) Vasektomi

Vasektomi adalah prosedur sterilisasi pada pria dengan cara memutus saluran sperma (vas deferens). Metode ini tidak memengaruhi kemampuan seksual maupun hormon pria, tetapi bersifat permanen sehingga memerlukan pertimbangan matang sebelum dilakukan.

d. Metode Alami/Sederhana

1) Metode Amenore Laktasi (MAL)

Metode amenore laktasi memanfaatkan pemberian ASI eksklusif untuk menekan ovulasi. Metode ini efektif apabila ibu belum mengalami menstruasi, bayi berusia kurang dari enam bulan, dan pemberian ASI dilakukan secara eksklusif.

2) KB Kalender

Metode kalender dilakukan dengan menghitung masa subur perempuan sehingga pasangan dapat menghindari hubungan seksual pada periode tersebut.

3) Senggama Terputus

Metode senggama terputus dilakukan dengan menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi. Metode ini tidak memerlukan biaya, tetapi tingkat efektivitasnya relatif rendah dibandingkan metode kontrasepsi lainnya.

B. Cara Memilih Kontrasepsi

Pemilihan metode kontrasepsi perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan, usia, jumlah anak, efektivitas, efek samping, serta kenyamanan pengguna. Kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dan praktis digunakan. Sementara itu, pil dan suntik KB memerlukan kedisiplinan pengguna agar hasilnya optimal. Kondom menjadi pilihan yang baik karena selain mencegah kehamilan juga dapat melindungi dari penyakit menular seksual.²

C. Indikasi Penggunaan Kontrasepsi

Penggunaan kontrasepsi bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mengatur jarak kelahiran, serta membantu pasangan dalam merencanakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Indikasi penggunaan kontrasepsi meliputi :

1. Menjarangkan kehamilan
2. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
3. Mencegah risiko kehamilan pada usia terlalu muda atau terlalu tua
4. Digunakan pada kondisi kesehatan tertentu yang berisiko apabila terjadi kehamilan
5. Penggunaan pasca persalinan atau pasca keguguran
6. Serta kebutuhan kontrasepsi jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan jenis metode, kontrasepsi hormonal umumnya digunakan oleh perempuan usia reproduktif, sedangkan kontrasepsi permanen seperti tubektomi dan vasektomi ditujukan bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Kontrasepsi darurat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti hubungan seksual tanpa perlindungan atau kegagalan metode KB lainnya.

D. Simpulan

Kontrasepsi adalah alat kesehatan reproduksi yang krusial, dan pemilihan yang tepat didasarkan pada pengetahuan yang baik mengenai risiko dan manfaat masing-masing metode. Penggunaan alat kontrasepsi adalah komponen penting dalam program Keluarga Berencana (KB) yang terbukti efektif menjarangkan

kehamilan, mencegah kehamilan tidak diinginkan, serta menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk meminimalkan efek samping dan memaksimalkan kenyamanan pengguna. Tujuan Utamanya Sebagai sarana untuk mengatur jarak kelahiran (menjarangkan) dan merencanakan kehamilan yang sehat, yang berdampak positif pada kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak. Keamanan dan Efektivitas bagi Penggunaan metode KB hormonal dan non-hormonal dapat menekan angka kehamilan tidak diinginkan. Meskipun begitu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasangan, Penting untuk memberikan edukasi yang komprehensif mengenai jenis, kelebihan, dan efek samping alat kontrasepsi (terutama metode hormonal) agar pengguna tidak mengalami keraguan atau unmet need. Kesuksesan penggunaan kontrasepsi sering kali dipengaruhi oleh pemahaman yang baik dari kedua belah pihak (pasangan usia subur), yang ditandai dengan sikap positif untuk mencegah kehamilan berisiko. Penggunaan kontrasepsi juga berperan dalam mengurangi risiko penularan infeksi tertentu dan menjaga kualitas hidup pasangan secara keseluruhan.

Referensi

- Affandi, B., Adriaansz, G., Hanna, L. T., & Prawirohardjo, S. (2014). *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Edisi 3). Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- BKKBN. (2021). *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Hanafi, M. (2019). *Jenis-jenis Kontrasepsi dan Efek Sampingnya*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kumalasari, I. (2015). *Panduan Praktik Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Saifuddin, A. B. (2018). *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Setyoningsih, R. (2020). *Dasar-Dasar Kontrasepsi*. Denpasar: Poltekkes Denpasar.
- Sulistyawati, A. (2013). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medika

Glosarium

PUS	: Pasangan Usia Subur
<i>IUD</i>	: <i>Intrauterine Device</i>
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
KB	: Keluarga Berencana
<i>DMPA</i>	: <i>Depo Medroxyprogesterone Acetate</i>
AKDR	: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
MAL	: Metode Amenore Laktasi



CHAPTER 3



KONSELING PEMILIHAN KONTRASEPSI SESUAI KEBUTUHAN PEREMPUAN

Ivana Devitasari, S.ST., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan kualitas hidup keluarga. Penggunaan kontrasepsi yang tepat tidak hanya berfungsi untuk menunda atau mengatur kehamilan, tetapi juga berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga. Menurut World Health Organization (WHO), akses terhadap informasi dan layanan kontrasepsi yang berkualitas merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang harus dipenuhi bagi setiap individu, khususnya perempuan.

Pemilihan metode kontrasepsi bukanlah keputusan yang sederhana, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, usia, kebutuhan reproduksi, nilai budaya, serta preferensi pribadi. Oleh karena itu, konseling menjadi komponen penting dalam pelayanan keluarga berencana. Konseling kontrasepsi bertujuan untuk membantu perempuan dan pasangan dalam memahami pilihan metode yang tersedia, manfaat, risiko, serta efek samping yang mungkin timbul sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab (World Health Organization, 2018).

Pendekatan konseling yang berpusat pada klien (client-centered counseling) menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara tenaga kesehatan dan klien. Dalam pendekatan ini, perempuan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, kekhawatiran, dan harapannya terkait penggunaan kontrasepsi. Hal ini sejalan dengan prinsip informed choice, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami (United Nations Population Fund, 2020). Dengan demikian, konseling tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan perempuan dalam menentukan pilihan reproduksinya.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan konseling kontrasepsi, seperti keterbatasan waktu pelayanan, kurangnya keterampilan komunikasi tenaga kesehatan, serta adanya mitos dan

misinformasi di masyarakat. Selain itu, faktor sosial budaya dan peran pasangan juga seringkali memengaruhi keputusan perempuan dalam memilih metode kontrasepsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konseling yang komprehensif, sensitif terhadap budaya, serta berbasis kebutuhan individu agar pelayanan keluarga berencana dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep, prinsip, serta pendekatan konseling dalam pemilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada klien.

B. Konsep Dasar Konseling Kontrasepsi

Konseling kontrasepsi merupakan proses komunikasi interpersonal antara tenaga kesehatan dan klien yang bertujuan untuk membantu klien memahami berbagai pilihan metode kontrasepsi serta menentukan metode yang paling sesuai dengan kebutuhan, kondisi kesehatan, dan preferensi pribadinya. Konseling tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga melibatkan proses mendengarkan secara aktif, memberikan dukungan emosional, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Menurut World Health Organization, konseling yang efektif harus bersifat dua arah dan berfokus pada kebutuhan klien sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi (WHO, 2018).

Tujuan utama konseling kontrasepsi adalah untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami mengenai berbagai metode kontrasepsi, termasuk cara kerja, efektivitas, keuntungan, efek samping, serta kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Selain itu, konseling juga bertujuan untuk membantu klien memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi medis, rencana reproduksi, serta nilai dan keyakinan yang dimiliki. Konseling yang berkualitas terbukti dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi secara konsisten dan mengurangi angka drop out dalam program keluarga berencana (*United Nations Population Fund*, 2020).

Dalam pelaksanaannya, konseling kontrasepsi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu menghormati hak reproduksi klien, menjunjung tinggi kerahasiaan, serta menghindari sikap memaksa atau mengarahkan secara sepihak. Prinsip informed choice menjadi landasan utama, di mana setiap klien berhak memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan secara mandiri. Selain itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat client-centered, yaitu

menempatkan klien sebagai subjek utama dalam proses konseling, bukan sekadar penerima informasi (United Nations Population Fund, 2020).

Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam konseling kontrasepsi sangatlah penting. Bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping dalam proses pengambilan keputusan. Kompetensi yang diperlukan meliputi kemampuan komunikasi efektif, empati, serta pengetahuan yang memadai mengenai berbagai metode kontrasepsi. Selain itu, bidan juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik klien, termasuk faktor sosial, budaya, dan psikologis yang dapat memengaruhi pemilihan kontrasepsi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Untuk meningkatkan efektivitas konseling, berbagai pendekatan telah dikembangkan, salah satunya adalah model GATHER (Greet, Ask, Tell, Help, Explain, Return). Model ini membantu tenaga kesehatan dalam menyusun alur konseling yang sistematis, mulai dari membangun hubungan dengan klien hingga melakukan tindak lanjut. Dengan penerapan pendekatan yang tepat, diharapkan konseling kontrasepsi dapat berjalan secara optimal, meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta mendukung tercapainya kesehatan reproduksi yang lebih baik bagi perempuan.

C. Hak Reproduksi dan *Informed Choice*

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjamin setiap individu, khususnya perempuan, untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab terkait kehidupan reproduksinya. Hak ini mencakup kebebasan dalam menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, serta waktu memiliki anak, termasuk hak untuk memperoleh informasi dan akses terhadap metode kontrasepsi yang aman, efektif, dan terjangkau. Pemenuhan hak reproduksi terbukti berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (World Health Organization, 2018; United Nations Population Fund, 2020).

Dalam pelayanan keluarga berencana, penghormatan terhadap hak reproduksi diwujudkan melalui pemberian layanan yang berkualitas, tidak diskriminatif, serta menghargai otonomi klien. Setiap perempuan berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tanpa adanya paksaan dalam memilih metode kontrasepsi. Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menekankan pentingnya akses informasi, pilihan yang luas, serta kebebasan dalam pengambilan keputusan reproduksi (United Nations Population Fund, 2020; Hardee et al., 2014).

Konsep informed choice menjadi prinsip utama dalam konseling kontrasepsi, yaitu keputusan yang diambil oleh klien berdasarkan pemahaman yang memadai terhadap berbagai pilihan metode kontrasepsi. Informasi yang diberikan mencakup cara kerja, efektivitas, keuntungan, efek samping, serta risiko dari masing-masing metode. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan informasi komprehensif cenderung lebih puas terhadap metode yang dipilih dan memiliki tingkat keberlanjutan penggunaan kontrasepsi yang lebih tinggi (Dehlendorf et al., 2013; World Health Organization, 2018).

Selain informed choice, informed consent juga merupakan komponen penting dalam pelayanan kontrasepsi. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh klien setelah mendapatkan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan. Persetujuan ini harus diberikan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun. Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa klien memahami informasi yang diberikan sebelum mengambil keputusan, sehingga prinsip otonomi tetap terjaga (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; Solo et al., 2019).

Namun demikian, implementasi hak reproduksi dan informed choice masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor seperti rendahnya literasi kesehatan, adanya mitos terkait kontrasepsi, serta pengaruh sosial budaya dan relasi gender dapat membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan kontrasepsi. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan pasangan dan norma sosial seringkali menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan, yang dalam beberapa kasus dapat mengurangi otonomi perempuan (Castle et al., 2020). Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menerapkan pendekatan konseling yang sensitif budaya, komunikatif, dan berorientasi pada pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian, penerapan hak reproduksi dan informed choice dalam konseling kontrasepsi tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksinya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang tepat dan berkelanjutan, serta mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

D. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kontrasepsi

Pemilihan metode kontrasepsi merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individu, sosial, maupun pelayanan kesehatan. Setiap perempuan memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda, sehingga tidak ada satu metode kontrasepsi yang dapat

digunakan secara universal. Oleh karena itu, pemilihan kontrasepsi harus mempertimbangkan karakteristik klien secara menyeluruh agar metode yang dipilih efektif, aman, dan dapat digunakan secara berkelanjutan (Fitriani & Oktaviani, 2019).

Faktor individu menjadi salah satu determinan utama dalam pemilihan kontrasepsi. Usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta kondisi kesehatan berpengaruh terhadap jenis metode yang dipilih. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kontrasepsi sehingga lebih rasional dalam menentukan pilihan. Selain itu, kondisi kesehatan tertentu juga menjadi pertimbangan penting karena tidak semua metode kontrasepsi aman digunakan pada kondisi medis tertentu (Sari & Lestari, 2020).

Faktor reproduksi seperti jumlah anak (paritas), keinginan memiliki anak, serta jarak kehamilan yang direncanakan juga sangat memengaruhi pemilihan metode kontrasepsi. Perempuan yang telah memiliki jumlah anak yang cukup umumnya lebih memilih metode kontrasepsi jangka panjang atau permanen. Sebaliknya, perempuan yang masih ingin memiliki anak cenderung memilih metode kontrasepsi jangka pendek atau reversibel (Wulandari et al., 2018).

Selain faktor individu, faktor sosial dan budaya turut berperan dalam menentukan pilihan kontrasepsi. Dukungan pasangan, khususnya suami, menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penggunaan kontrasepsi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, keputusan penggunaan kontrasepsi sering kali dipengaruhi oleh peran suami dan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan dukungan suami memiliki kemungkinan lebih besar untuk menggunakan kontrasepsi secara konsisten (Handayani & Sulastri, 2017).

Tingkat pengetahuan dan persepsi terhadap kontrasepsi juga memengaruhi pemilihan metode. Mitos dan kesalahpahaman mengenai efek samping kontrasepsi masih banyak ditemukan di masyarakat, seperti anggapan bahwa kontrasepsi dapat menyebabkan kemandulan atau gangguan kesehatan lainnya. Hal ini dapat menghambat perempuan dalam memilih metode kontrasepsi yang efektif. Oleh karena itu, edukasi dan konseling yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (Rahmawati & Dewi, 2021).

Faktor pelayanan kesehatan juga menjadi aspek penting dalam pemilihan kontrasepsi. Ketersediaan metode kontrasepsi, kemudahan akses ke fasilitas kesehatan, biaya, serta kualitas pelayanan memengaruhi keputusan klien. Pelayanan yang ramah, informatif, dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan klien serta mendorong penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sebaliknya, keterbatasan akses dan kualitas layanan yang rendah dapat menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan keluarga berencana (Pratiwi et al., 2020).

Dengan demikian, pemilihan kontrasepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, mulai dari faktor individu, reproduksi, sosial budaya, hingga pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu melakukan pendekatan yang komprehensif dan individual dalam konseling kontrasepsi agar metode yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, kondisi, serta preferensi klien.

E. Jenis-Jenis Metode Kontrasepsi

Metode kontrasepsi merupakan cara atau alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan, baik secara sementara maupun permanen. Secara umum, metode kontrasepsi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu metode kontrasepsi jangka pendek, jangka panjang, permanen, dan metode alami. Pemilihan metode kontrasepsi harus mempertimbangkan efektivitas, keamanan, kenyamanan, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan perempuan (Affandi et al., 2012).

1. Metode Kontrasepsi Jangka Pendek

Metode kontrasepsi jangka pendek adalah metode yang penggunaannya memerlukan kepatuhan rutin dan dapat dihentikan sewaktu-waktu. Metode ini cocok bagi perempuan yang ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu relatif singkat.

a. Pil Kontrasepsi

Pil kontrasepsi merupakan metode hormonal yang mengandung estrogen dan/atau progesteron yang bekerja dengan menghambat ovulasi. Pil ini memiliki efektivitas tinggi jika digunakan secara teratur, namun memerlukan kepatuhan harian (Glasier et al., 2013).

b. Suntik Kontrasepsi

Metode suntik diberikan secara berkala (1 bulan atau 3 bulan) dan bekerja dengan mencegah ovulasi serta mengentalkan lendir serviks. Metode ini cukup populer di Indonesia karena praktis dan tidak memerlukan konsumsi harian (BKKBN, 2020).

c. Kondom

Kondom merupakan metode kontrasepsi non-hormonal yang berfungsi sebagai penghalang sperma agar tidak masuk ke dalam rahim. Selain mencegah kehamilan, kondom juga melindungi dari infeksi menular seksual (IMS) (Kemenkes RI, 2021).

2. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang adalah metode yang efektif digunakan dalam jangka waktu lama dan tidak memerlukan kepatuhan harian.

a. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD)

IUD adalah alat kecil yang dipasang di dalam rahim dan bekerja dengan mencegah pembuahan. IUD dapat digunakan selama 5–10 tahun tergantung jenisnya dan memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi (Winner et al., 2012).

b. Implant (Susuk KB)

Implant adalah alat kecil yang ditanam di bawah kulit lengan atas dan mengandung hormon progesteron. Metode ini efektif hingga 3–5 tahun dan bekerja dengan menghambat ovulasi (Affandi et al., 2012).

3. Metode Kontrasepsi Permanen

Metode ini ditujukan bagi individu atau pasangan yang tidak menginginkan kehamilan lagi.

a. Tubektomi (MOW)

Metode operasi pada perempuan dengan cara mengikat atau memotong tuba falopi sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma.

b. Vasektomi (MOP)

Metode operasi pada laki-laki dengan memotong atau mengikat vas deferens sehingga sperma tidak keluar bersama cairan semen (BKKBN, 2020).

Metode permanen memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi, namun tidak dapat dikembalikan seperti semula (irreversibel).

4. Metode Kontrasepsi Alami

Metode alami tidak menggunakan alat atau hormon, melainkan berdasarkan pemahaman terhadap siklus reproduksi perempuan.

a. Metode Kalender

Menghindari hubungan seksual pada masa subur berdasarkan perhitungan siklus menstruasi.

b. Metode Amenore Laktasi (MAL)

Mengandalkan pemberian ASI eksklusif sebagai cara menunda ovulasi pada ibu menyusui.

c. Metode Suhu Basal dan Lendir Serviks

Mengamati perubahan suhu tubuh dan lendir serviks untuk menentukan masa subur (Kemenkes RI, 2021).

5. Kelebihan dan Kekurangan Metode Kontrasepsi

Setiap metode kontrasepsi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode hormonal umumnya lebih efektif namun dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan menstruasi. Metode non-hormonal lebih aman dari sisi efek sistemik, namun memerlukan kedisiplinan dalam penggunaan. Sementara itu, metode jangka panjang menawarkan efektivitas tinggi dengan pemeliharaan minimal, tetapi memerlukan tindakan medis dalam pemasangan dan pelepasannya.

Tabel 3. 1 Perbandingan Metode Kontrasepsi

Metode	Jenis	Efektivitas	Kelebihan	Kekurangan	Cocok untuk
Pil KB	Hormonal (jangka pendek)	Tinggi ($\pm 91-99\%$)	Mudah digunakan, mengatur siklus haid	Harus diminum setiap hari, efek samping hormonal	Perempuan usia reproduksi yang disiplin
Suntik KB	Hormonal (jangka pendek)	Tinggi ($\pm 94-99\%$)	Praktis (1-3 bulan sekali), tidak perlu ingat harian	Gangguan haid, kenaikan berat badan	Perempuan yang ingin praktis
Kondom	Non-hormonal	Sedang ($\pm 82-98\%$)	Melindungi dari IMS, mudah didapat	Harus digunakan setiap hubungan	Pasangan aktif seksual, pencegahan IMS
IUD/AKDR	Non-hormonal / hormonal (MKJP)	Sangat tinggi ($>99\%$)	Jangka panjang (5-10 tahun), efektif	Perlu tenaga kesehatan untuk pemasangan	Perempuan ingin kontrasepsi jangka panjang
Implant	Hormonal (MKJP)	Sangat tinggi ($>99\%$)	Tahan 3-5 tahun, praktis	Perubahan pola haid	Perempuan yang ingin metode jangka panjang
Tubektomi	Permanen	Sangat tinggi ($>99\%$)	Sekali tindakan, permanen	Tidak dapat dikembalikan	Perempuan tidak ingin anak lagi
Vasektomi	Permanen	Sangat tinggi ($>99\%$)	Aman, prosedur sederhana	Permanen, perlu persetujuan	Laki-laki tidak ingin anak lagi
Metode Kalender	Alami	Rendah-sedang	Tanpa efek samping	Kurang akurat, butuh disiplin tinggi	Perempuan dengan siklus teratur
MAL	Alami	Tinggi (hingga 98%)	Tanpa biaya, alami	Terbatas hanya 6 bulan postpartum	Ibu menyusui eksklusif

Secara keseluruhan, tidak ada metode kontrasepsi yang paling sempurna untuk semua perempuan. Oleh karena itu, pemilihan metode harus didasarkan pada hasil konseling yang komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi kesehatan, serta preferensi klien.

F. Pendekatan Konseling dalam Pemilihan Kontrasepsi

Konseling dalam pemilihan kontrasepsi merupakan proses komunikasi yang sistematis dan berpusat pada klien (*client-centered care*), yang bertujuan membantu perempuan dalam memilih metode kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan, kondisi kesehatan, serta preferensinya. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif klien dalam pengambilan keputusan. Studi terbaru menunjukkan bahwa konseling yang berorientasi pada klien dan menghargai otonomi dapat meningkatkan kepuasan serta keberlanjutan penggunaan kontrasepsi (Manzer et al., 2024).

Salah satu pendekatan utama dalam konseling kontrasepsi adalah *shared decision-making (SDM)*, yaitu proses pengambilan keputusan bersama antara tenaga kesehatan dan klien. Dalam pendekatan ini, tenaga kesehatan memberikan informasi berbasis bukti mengenai pilihan kontrasepsi, sementara klien menyampaikan nilai, preferensi, dan tujuan reproduksinya. Pendekatan SDM terbukti membantu klien dalam membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi serta meningkatkan kualitas komunikasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi (Tucker Edmonds et al., 2022).

Selain SDM, pendekatan *client-centered counseling* juga menekankan pentingnya komunikasi interpersonal yang efektif. Konseling tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada hubungan antara tenaga kesehatan dan klien. Klien cenderung lebih puas ketika tenaga kesehatan mendengarkan secara aktif, memberikan informasi yang relevan, serta tidak memaksakan pilihan tertentu. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu direktif dapat menurunkan kepercayaan dan bahkan membuat klien menolak penggunaan kontrasepsi (Carvajal et al., 2023).

Pendekatan lain yang banyak digunakan adalah *Balanced Counseling Strategy (BCS)*, yaitu metode konseling terstruktur yang membantu klien membandingkan berbagai pilihan kontrasepsi secara sistematis. BCS menggunakan alat bantu seperti kartu metode dan diagram alur untuk mempermudah pemahaman klien. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi, terutama metode jangka panjang, karena membantu klien membuat keputusan secara lebih rasional dan terarah (Karra et al., 2024).

Seiring perkembangan teknologi, pendekatan konseling juga mulai memanfaatkan decision aids berbasis teknologi, seperti aplikasi atau media digital. Penggunaan alat bantu ini terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri, serta kualitas pengambilan keputusan klien terkait kontrasepsi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan penyampaian informasi yang lebih interaktif dan mudah dipahami (Goueth et al., 2022).

Kualitas konseling juga sangat ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu pertukaran informasi (information exchange) dan komunikasi interpersonal. Kedua aspek ini berperan penting dalam memastikan bahwa klien memahami pilihan yang tersedia serta merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas konseling yang baik berhubungan dengan meningkatnya penerimaan dan pemilihan metode kontrasepsi oleh klien (Acre et al., 2022).

Selain itu, pendekatan konseling harus sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Nilai budaya, norma sosial, serta pengaruh pasangan dapat memengaruhi keputusan klien dalam memilih kontrasepsi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mengembangkan pendekatan yang adaptif, tidak menghakimi, serta mampu membangun hubungan yang saling percaya dengan klien.

Dengan demikian, pendekatan konseling dalam pemilihan kontrasepsi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada proses komunikasi yang empatik, partisipatif, dan berbasis kebutuhan klien. Integrasi pendekatan seperti shared decision-making, client-centered counseling, dan penggunaan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta membantu perempuan dalam membuat keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

G. Konseling Berbasis Kebutuhan Perempuan

Konseling berbasis kebutuhan perempuan merupakan pendekatan dalam pelayanan keluarga berencana yang menempatkan perempuan sebagai pusat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini mempertimbangkan kondisi biologis, psikologis, sosial, serta tahap kehidupan reproduksi perempuan, sehingga metode kontrasepsi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan individu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip client-centered care yang menekankan pentingnya otonomi perempuan dalam menentukan pilihan kesehatan reproduksinya (Holt et al., 2020; Rahmawati & Dewi, 2021).

Kebutuhan kontrasepsi perempuan bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan fase kehidupan reproduksi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menyesuaikan pendekatan konseling dengan karakteristik klien. Konseling yang

tidak mempertimbangkan kebutuhan individu dapat menyebabkan ketidaksesuaian metode, rendahnya kepuasan, serta tingginya angka putus pakai kontrasepsi (Senderowicz, 2020; Fitriani & Oktaviani, 2019).

1. Konseling pada Remaja

Remaja merupakan kelompok yang memiliki kebutuhan khusus dalam pelayanan kontrasepsi. Konseling harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah remaja (youth-friendly), menjaga kerahasiaan, serta tidak menghakimi. Informasi yang diberikan mencakup pencegahan kehamilan dan infeksi menular seksual. Di Indonesia, stigma sosial dan keterbatasan akses layanan masih menjadi hambatan utama bagi remaja dalam memperoleh layanan kesehatan reproduksi (Chandra-Mouli et al., 2021; Sari & Lestari, 2020).

2. Konseling pada Pasangan Usia Subur (PUS)

Pada pasangan usia subur, konseling difokuskan pada perencanaan jumlah dan jarak kehamilan. Keterlibatan pasangan, khususnya suami, menjadi faktor penting dalam keberhasilan penggunaan kontrasepsi. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan suami berhubungan signifikan dengan penggunaan kontrasepsi secara konsisten (Blackstone et al., 2017; Handayani & Sulastri, 2017).

3. Konseling pada Ibu Postpartum dan Menyusui

Periode postpartum merupakan waktu strategis untuk memulai penggunaan kontrasepsi guna mencegah kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat. Konseling pada ibu menyusui perlu mempertimbangkan metode yang aman terhadap produksi ASI, seperti MAL, IUD, dan implant. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa edukasi sejak masa antenatal dapat meningkatkan kesiapan ibu dalam memilih kontrasepsi pasca persalinan (Cleland et al., 2019; Pratiwi et al., 2020).

4. Konseling pada Perempuan dengan Kondisi Khusus

Perempuan dengan kondisi medis tertentu, seperti hipertensi, diabetes, atau HIV, memerlukan konseling yang lebih spesifik. Pemilihan metode harus mempertimbangkan keamanan serta kontraindikasi medis. Tenaga kesehatan perlu menggunakan pendekatan berbasis bukti dan pedoman klinis untuk memastikan keselamatan klien (Curtis et al., 2016; Rahmawati & Dewi, 2021).

5. Konseling pada Perempuan Perimenopause

Perempuan pada masa perimenopause masih memiliki potensi untuk hamil, sehingga tetap membutuhkan kontrasepsi. Konseling pada kelompok ini perlu mempertimbangkan perubahan hormonal, risiko penyakit kronis, serta kebutuhan kesehatan jangka panjang. Selain itu, edukasi mengenai transisi

menuju menopause juga penting untuk meningkatkan kesiapan perempuan menghadapi perubahan tersebut (Kaunitz, 2020; Wulandari et al., 2018).

Pendekatan konseling berbasis kebutuhan perempuan menuntut tenaga kesehatan untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik klien dan menyesuaikan strategi komunikasi serta informasi yang diberikan. Konseling yang responsif terhadap kebutuhan individu terbukti meningkatkan kepuasan, kepatuhan, serta keberlanjutan penggunaan kontrasepsi.

H. Pengambilan Keputusan Bersama (*Shared Decision Making*)

Pengambilan keputusan bersama atau *Shared Decision Making* (SDM) merupakan pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan klien dalam menentukan pilihan terbaik terkait tindakan medis, termasuk pemilihan metode kontrasepsi. Dalam konteks keluarga berencana, SDM menempatkan perempuan sebagai subjek aktif yang memiliki hak untuk menentukan pilihan berdasarkan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Pendekatan ini menjadi bagian penting dari pelayanan yang berpusat pada klien (*client-centered care*) dan berbasis hak (*rights-based approach*) (Elwyn et al., 2012; Rahmawati & Dewi, 2021).

SDM melibatkan pertukaran informasi dua arah, di mana tenaga kesehatan memberikan informasi berbasis bukti mengenai pilihan kontrasepsi, sementara klien menyampaikan nilai, preferensi, serta tujuan reproduksinya. Proses ini membantu klien memahami berbagai alternatif yang tersedia serta konsekuensi dari setiap pilihan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SDM dalam konseling kontrasepsi dapat meningkatkan kepuasan klien, kualitas keputusan, serta keberlanjutan penggunaan metode kontrasepsi (Tucker Edmonds et al., 2022).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa tahapan dalam SDM. Pertama, tenaga kesehatan memperkenalkan bahwa terdapat pilihan yang dapat dipertimbangkan (*choice talk*). Kedua, memberikan penjelasan rinci mengenai pilihan yang tersedia (*option talk*), termasuk manfaat, risiko, dan efek samping. Ketiga, membantu klien dalam mempertimbangkan pilihan yang paling sesuai (*decision talk*). Tahapan ini membantu klien dalam mengambil keputusan secara rasional dan sesuai dengan kebutuhannya (Elwyn et al., 2012).

Penerapan SDM dalam konseling kontrasepsi memiliki berbagai manfaat. Selain meningkatkan kepuasan klien, SDM juga dapat mengurangi ketidaksesuaian antara metode yang dipilih dengan kebutuhan klien, serta menurunkan angka penghentian penggunaan kontrasepsi. Klien yang terlibat aktif dalam pengambilan

keputusan cenderung lebih memahami metode yang dipilih dan lebih berkomitmen dalam penggunaannya (Dehlendorf et al., 2017).

Namun demikian, penerapan SDM juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan waktu dalam pelayanan, kurangnya keterampilan komunikasi tenaga kesehatan, serta perbedaan tingkat literasi kesehatan klien dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan SDM. Selain itu, dalam beberapa konteks budaya, keputusan terkait kontrasepsi sering kali dipengaruhi oleh pasangan atau keluarga, sehingga dapat membatasi otonomi perempuan (Blackstone et al., 2017).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, tenaga kesehatan perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memanfaatkan alat bantu seperti decision aids untuk mempermudah pemahaman klien. Selain itu, penting untuk menciptakan suasana konseling yang nyaman, terbuka, dan tidak menghakimi agar klien merasa aman dalam menyampaikan kebutuhan dan preferensinya.

Dengan demikian, *Shared Decision Making* merupakan pendekatan yang sangat penting dalam konseling pemilihan kontrasepsi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksinya. Implementasi SDM yang optimal diharapkan dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang tepat, aman, dan berkelanjutan.

I. Efektivitas dan Keamanan Kontrasepsi

Efektivitas dan keamanan merupakan dua aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode kontrasepsi. Efektivitas mengacu pada kemampuan suatu metode dalam mencegah kehamilan, sedangkan keamanan berkaitan dengan risiko efek samping dan kesesuaian metode terhadap kondisi kesehatan pengguna. Pemahaman yang baik mengenai kedua aspek ini sangat penting dalam proses konseling agar klien dapat memilih metode kontrasepsi yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman sesuai dengan kondisi individu (Trussell, 2011; Sari & Lestari, 2020).

1. Efektivitas Metode Kontrasepsi

Efektivitas kontrasepsi biasanya dinyatakan dalam persentase keberhasilan dalam mencegah kehamilan selama satu tahun penggunaan. Terdapat dua istilah penting dalam menilai efektivitas, yaitu *perfect use* (penggunaan sempurna sesuai aturan) dan *typical use* (penggunaan sehari-hari yang mungkin tidak konsisten). Perbedaan ini penting karena sebagian besar pengguna berada pada

kategori typical use, sehingga tingkat kegagalan metode dapat lebih tinggi dibandingkan kondisi ideal (Trussell, 2011).

Metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implant memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi (>99%) karena tidak bergantung pada kepatuhan pengguna. Sementara itu, metode jangka pendek seperti pil dan kondom memiliki efektivitas yang lebih rendah pada typical use karena memerlukan kedisiplinan dalam penggunaan. Metode alami umumnya memiliki tingkat efektivitas yang lebih rendah dibandingkan metode modern, terutama jika tidak digunakan secara konsisten (Winner et al., 2012).

2. Keamanan dan Efek Samping Kontrasepsi

Keamanan kontrasepsi berkaitan dengan kemungkinan efek samping serta risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan metode tertentu. Efek samping yang umum terjadi pada metode hormonal antara lain gangguan pola menstruasi, kenaikan berat badan, sakit kepala, dan perubahan suasana hati. Meskipun demikian, sebagian besar efek samping bersifat ringan dan dapat berkurang seiring waktu (Curtis et al., 2016).

Pada metode non-hormonal seperti IUD tembaga, efek samping yang mungkin terjadi adalah peningkatan perdarahan menstruasi dan nyeri haid. Sementara itu, metode seperti kondom relatif aman dan tidak memiliki efek samping sistemik, namun efektivitasnya bergantung pada penggunaan yang benar dan konsisten. Penting bagi tenaga kesehatan untuk menjelaskan efek samping secara jujur agar klien tidak terkejut dan tetap melanjutkan penggunaan kontrasepsi (Dehlendorf et al., 2017).

3. Kontraindikasi Medis

Tidak semua metode kontrasepsi dapat digunakan oleh semua perempuan. Beberapa kondisi medis menjadi kontraindikasi terhadap penggunaan metode tertentu. Misalnya, perempuan dengan riwayat penyakit tromboemboli tidak dianjurkan menggunakan kontrasepsi hormonal kombinasi yang mengandung estrogen. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu melakukan skrining medis sebelum menentukan metode yang sesuai (Curtis et al., 2016).

Penggunaan pedoman seperti Medical Eligibility Criteria (MEC) sangat penting dalam menentukan keamanan penggunaan kontrasepsi pada kondisi medis tertentu. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan dalam meminimalkan risiko serta memastikan bahwa metode yang dipilih aman bagi klien.

4. Mitos dan Fakta tentang Kontrasepsi

Mitos dan kesalahpahaman tentang kontrasepsi masih banyak ditemukan di masyarakat dan dapat memengaruhi keputusan penggunaan. Beberapa mitos yang sering muncul antara lain kontrasepsi menyebabkan kemandulan, meningkatkan risiko kanker, atau berbahaya bagi kesehatan jangka panjang. Padahal, sebagian besar metode kontrasepsi modern telah terbukti aman dan efektif melalui berbagai penelitian ilmiah (Sedgh & Hussain, 2014; Rahmawati & Dewi, 2021).

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam meluruskan mitos tersebut melalui edukasi yang berbasis bukti. Informasi yang jelas dan akurat dapat meningkatkan kepercayaan klien serta mendorong penggunaan kontrasepsi yang tepat.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai efektivitas dan keamanan kontrasepsi sangat penting dalam membantu klien memilih metode yang sesuai. Kombinasi antara efektivitas tinggi dan keamanan yang baik akan meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana serta mendukung kesehatan reproduksi perempuan secara optimal.

J. Dokumentasi dan Tindak Lanjut Konseling

Dokumentasi dan tindak lanjut merupakan bagian penting dalam pelayanan konseling kontrasepsi yang berkualitas. Dokumentasi berfungsi sebagai catatan tertulis mengenai proses konseling, hasil pengkajian, serta keputusan yang diambil oleh klien. Sementara itu, tindak lanjut (follow-up) bertujuan untuk memantau keberlanjutan penggunaan kontrasepsi, mengevaluasi efek samping, serta memastikan bahwa metode yang dipilih tetap sesuai dengan kebutuhan klien. Kedua aspek ini sangat penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan keluarga berencana (Pratiwi et al., 2020; Dehlendorf et al., 2017).

1. Dokumentasi Konseling Kontrasepsi

Dokumentasi dalam konseling kontrasepsi harus dilakukan secara sistematis, lengkap, dan akurat. Informasi yang dicatat meliputi identitas klien, riwayat kesehatan, kebutuhan dan tujuan reproduksi, metode kontrasepsi yang dipilih, serta informasi yang telah diberikan selama konseling. Selain itu, penting juga untuk mencatat adanya persetujuan tindakan (informed consent) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak klien (Rahmawati & Dewi, 2021).

Dokumentasi yang baik memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, dasar evaluasi pelayanan, serta bukti hukum apabila diperlukan. Dalam praktik kebidanan, pencatatan yang lengkap dan jelas

juga dapat membantu dalam pemantauan kondisi klien secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan dalam melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar pelayanan (Handayani & Sulastri, 2017).

2. Prinsip Dokumentasi yang Baik

Agar dokumentasi dapat berfungsi secara optimal, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Akurat: data sesuai dengan kondisi klien
- b. Lengkap: mencakup seluruh aspek penting dalam konseling
- c. Jelas dan sistematis: mudah dipahami oleh tenaga kesehatan lain
- d. Tepat waktu: dilakukan segera setelah pelayanan diberikan
- e. Kerahasiaan: menjaga privasi klien

Penerapan prinsip ini penting untuk menjamin kualitas pelayanan serta keselamatan klien (Sari & Lestari, 2020).

3. Tindak Lanjut (*Follow-Up*) Konseling

Tindak lanjut merupakan bagian integral dari pelayanan kontrasepsi yang bertujuan untuk memastikan keberhasilan penggunaan metode yang dipilih. Follow-up dilakukan melalui kunjungan ulang atau komunikasi lanjutan untuk mengevaluasi kondisi klien, termasuk kepuasan penggunaan, kepatuhan, serta adanya efek samping yang dirasakan (Dehlendorf et al., 2017).

Pada tahap ini, tenaga kesehatan perlu memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan atau kendala yang dihadapi. Jika ditemukan masalah, seperti efek samping yang mengganggu atau ketidaksesuaian metode, maka tenaga kesehatan dapat memberikan solusi, termasuk mengganti metode kontrasepsi yang lebih sesuai. Pendekatan ini membantu mengurangi angka putus pakai kontrasepsi (drop out) (Pratiwi et al., 2020).

4. Waktu dan Bentuk Tindak Lanjut

Waktu tindak lanjut disesuaikan dengan jenis metode kontrasepsi yang digunakan. Misalnya:

- a. Pil: evaluasi dalam 1–3 bulan pertama
- b. Suntik: setiap jadwal suntikan berikutnya
- c. IUD/implant: kontrol setelah pemasangan dan secara berkala
- d. Metode alami: pemantauan rutin sesuai siklus

Tindak lanjut dapat dilakukan melalui kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan, kunjungan rumah, atau media komunikasi seperti telepon dan aplikasi digital. Pemanfaatan teknologi dalam tindak lanjut dapat meningkatkan akses dan kenyamanan klien (Acre et al., 2022).

5. Evaluasi dan Konseling Ulang

Evaluasi merupakan bagian dari tindak lanjut yang bertujuan untuk menilai keberhasilan penggunaan kontrasepsi serta kepuasan klien. Jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat melakukan konseling ulang untuk menyesuaikan metode dengan perubahan kondisi atau kebutuhan klien. Konseling ulang penting dilakukan terutama pada kondisi seperti perubahan status kesehatan, keinginan memiliki anak, atau munculnya efek samping tertentu.

Secara keseluruhan, dokumentasi dan tindak lanjut merupakan komponen penting dalam pelayanan konseling kontrasepsi yang berkesinambungan. Dokumentasi yang baik akan mendukung kualitas pelayanan, sementara tindak lanjut yang efektif akan meningkatkan kepuasan dan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi. Dengan demikian, kedua aspek ini berperan dalam meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana serta kesehatan reproduksi perempuan.

K. Tantangan dan Isu Terkini dalam Konseling Kontrasepsi

Perkembangan pelayanan kesehatan reproduksi menuntut adanya inovasi dan adaptasi dalam pelaksanaan konseling kontrasepsi. Meskipun program keluarga berencana telah berkembang pesat, berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya memberikan pelayanan konseling yang berkualitas. Tantangan tersebut mencakup aspek sosial budaya, perkembangan teknologi, perubahan pola kebutuhan masyarakat, hingga munculnya berbagai isu baru dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memahami isu-isu terkini agar mampu memberikan konseling yang responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan perempuan (Holt et al., 2020).

1. Misinformasi dan Mitos tentang Kontrasepsi

Salah satu tantangan utama dalam konseling kontrasepsi adalah masih tingginya penyebaran misinformasi dan mitos di masyarakat. Berbagai anggapan keliru, seperti kontrasepsi menyebabkan kemandulan, meningkatkan risiko kanker, atau mengganggu kesehatan reproduksi secara permanen, masih banyak ditemukan. Informasi yang tidak akurat ini sering kali berasal dari pengalaman pribadi yang tidak terverifikasi, media sosial, atau lingkungan sosial klien (Rahmawati & Dewi, 2021).

Misinformasi dapat menimbulkan ketakutan dan keraguan sehingga perempuan enggan menggunakan kontrasepsi modern. Dalam menghadapi kondisi ini, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi berbasis bukti ilmiah

serta mampu meluruskan persepsi yang keliru melalui komunikasi yang persuasif dan empatik.

2. Hambatan Sosial Budaya dan Gender

Norma sosial dan budaya masih menjadi faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan kontrasepsi. Dalam beberapa masyarakat, keputusan terkait kesehatan reproduksi perempuan sering kali dipengaruhi oleh pasangan atau keluarga besar. Ketimpangan relasi gender dapat membatasi otonomi perempuan dalam menentukan metode kontrasepsi yang diinginkan (Blackstone et al., 2017).

Selain itu, stigma terhadap penggunaan kontrasepsi pada kelompok tertentu, seperti remaja atau perempuan belum memiliki anak, masih menjadi tantangan dalam pelayanan. Tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki sensitivitas budaya dan kemampuan advokasi agar pelayanan kontrasepsi tetap menghormati hak reproduksi perempuan.

3. Rendahnya Literasi Kesehatan Reproduksi

Literasi kesehatan reproduksi yang rendah masih menjadi masalah di berbagai wilayah, terutama pada masyarakat dengan akses pendidikan dan informasi yang terbatas. Kurangnya pemahaman mengenai cara kerja kontrasepsi, efek samping, serta manfaat penggunaannya dapat menyebabkan pemilihan metode yang kurang tepat atau penghentian penggunaan secara dini (Fitriani & Oktaviani, 2019).

Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan untuk menggunakan bahasa yang sederhana, media edukasi yang mudah dipahami, serta pendekatan konseling yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan klien.

4. Pemanfaatan Teknologi dalam Konseling Kontrasepsi

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan, termasuk konseling kontrasepsi. Saat ini, layanan telehealth, aplikasi kesehatan reproduksi, dan media edukasi digital mulai banyak digunakan untuk mendukung konseling. Teknologi ini memungkinkan klien memperoleh informasi secara lebih fleksibel dan meningkatkan akses terhadap layanan, terutama di daerah terpencil (Goueth et al., 2022).

Namun demikian, penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan seperti validitas informasi, keamanan data pribadi, serta kesenjangan akses digital. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan berbasis bukti dan tetap menjaga kerahasiaan klien.

5. Perubahan Preferensi dan Kebutuhan Perempuan

Perempuan masa kini memiliki kebutuhan dan preferensi yang semakin beragam terkait kontrasepsi. Faktor seperti mobilitas tinggi, perencanaan karier, peningkatan pendidikan, serta kesadaran akan kesehatan reproduksi memengaruhi pilihan metode kontrasepsi. Banyak perempuan kini lebih memilih metode yang praktis, efektif, dan minim intervensi rutin, seperti kontrasepsi jangka panjang (implant dan IUD) (Winner et al., 2012).

Perubahan ini menuntut tenaga kesehatan untuk terus memperbarui pengetahuan serta mampu menyesuaikan pendekatan konseling dengan kebutuhan perempuan modern.

6. Tantangan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Kualitas konseling kontrasepsi sangat bergantung pada kompetensi tenaga kesehatan. Keterbatasan keterampilan komunikasi, kurangnya pembaruan pengetahuan, serta beban kerja yang tinggi dapat memengaruhi kualitas pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas konseling dan kepuasan klien (Acre et al., 2022).

Oleh karena itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, supervisi, dan evaluasi berkala sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pelayanan kontrasepsi saat ini.

Secara keseluruhan, tantangan dan isu terkini dalam konseling kontrasepsi menunjukkan bahwa pelayanan keluarga berencana tidak hanya berfokus pada aspek teknis pemilihan metode, tetapi juga harus responsif terhadap perubahan sosial, budaya, teknologi, dan kebutuhan perempuan. Tenaga kesehatan dituntut untuk terus beradaptasi agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, berorientasi pada hak reproduksi, dan mendukung pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan.

L. Simpulan

Konseling pemilihan kontrasepsi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan membantu perempuan menentukan metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan, kondisi kesehatan, serta preferensinya. Proses konseling tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga pada upaya membangun komunikasi yang efektif, empatik, dan berpusat pada klien. Dengan pendekatan yang tepat, konseling dapat meningkatkan pemahaman, kepuasan, serta keberlanjutan penggunaan kontrasepsi.

Pelaksanaan konseling kontrasepsi harus didasarkan pada prinsip hak reproduksi dan informed choice, di mana perempuan memiliki hak penuh untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan tidak bias sebelum mengambil keputusan. Berbagai faktor seperti usia, kondisi kesehatan, sosial budaya, tingkat pendidikan, serta dukungan pasangan turut memengaruhi pemilihan metode kontrasepsi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dalam proses konseling agar metode yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan individu.

Pemilihan metode kontrasepsi juga harus mempertimbangkan jenis metode, efektivitas, keamanan, serta kemungkinan efek samping dan kontraindikasi medis. Pendekatan konseling yang sistematis, seperti client-centered counseling dan shared decision making, terbukti dapat membantu klien dalam memahami pilihan yang tersedia serta mengambil keputusan secara rasional dan mandiri. Selain itu, konseling berbasis kebutuhan perempuan yang disesuaikan dengan tahap kehidupan reproduksi—mulai dari remaja hingga perimenopause—menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana.

Keberhasilan konseling tidak terlepas dari dokumentasi yang baik serta tindak lanjut yang berkesinambungan. Dokumentasi yang lengkap dan akurat mendukung kontinuitas pelayanan, sementara tindak lanjut memungkinkan tenaga kesehatan untuk memantau penggunaan kontrasepsi, mengatasi efek samping, serta melakukan penyesuaian metode jika diperlukan. Kedua aspek ini berperan penting dalam mencegah putus pakai kontrasepsi dan meningkatkan keberhasilan program keluarga berencana.

Di sisi lain, berbagai tantangan dan isu terkini, seperti misinformasi, hambatan sosial budaya, rendahnya literasi kesehatan, serta perkembangan teknologi, menuntut tenaga kesehatan untuk terus beradaptasi. Pemanfaatan teknologi digital dalam konseling serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan menjadi strategi penting dalam menghadapi dinamika tersebut. Dengan demikian, konseling pemilihan kontrasepsi yang berkualitas diharapkan mampu mendukung pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksinya serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- Acre, V. N., Dijkerman, S., Calhoun, L. M., Speizer, I. S., Poss, C., & Nyamato, E. (2022). The association of quality contraceptive counseling with method choice and uptake. *BMC Health Services Research*, 22, 1519. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08851-0>
- Affandi, B., Adriaansz, G., Gunardi, E. R., & Koesno, H. (2012). *Buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi*. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- BKKBN. (2020). *Pedoman pelayanan keluarga berencana*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Blackstone, S. R., Nwaozuru, U., & Iwelunmor, J. (2017). Factors influencing contraceptive use in sub-Saharan Africa: A systematic review. *International Quarterly of Community Health Education*, 37(2), 79–91.
- Carvajal, D. N., Bevilacqua, K. G., Caldwell, M. T., & Zambrana, R. E. (2023). Provider perspectives on patient-centered contraceptive counseling. *Contraception*, 119, 109921. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2022.109921>
- Castle, S., Askew, I., & Ndhlovu, L. (2020). Factors influencing contraceptive use dynamics in sub-Saharan Africa. *Studies in Family Planning*, 51(3), 201–218. <https://doi.org/10.1111/sifp.12124>
- Chandra-Mouli, V., McCarraher, D. R., Phillips, S. J., Williamson, N. E., & Hainsworth, G. (2021). Contraception for adolescents in low- and middle-income countries. *The Lancet*, 380(9837), 231–239.
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2019). Contraception and health. *The Lancet*, 380(9837), 149–156.
- Curtis, K. M., Tepper, N. K., Jatlaoui, T. C., et al. (2016). U.S. medical eligibility criteria for contraceptive use. *MMWR Recommendations and Reports*, 65(3), 1–103.
- Dehlendorf, C., Henderson, J. T., Vittinghoff, E., Grumbach, K., Levy, K., Schmittdiel, J., & Steinauer, J. (2013). Association of the quality of interpersonal care during family planning counseling with contraceptive use. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 208(6), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2013.01.001>
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., ... & Barry, M. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27(10), 1361–1367.
- Fitriani, Y., & Oktaviani, W. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(2), 123–130.

- Glasier, A., Gülmezoglu, A. M., Schmid, G. P., Moreno, C. G., & Van Look, P. F. A. (2013). Sexual and reproductive health: A matter of life and death. *The Lancet*, 368(9547), 1595–1607.
- Goueth, R. C., et al. (2022). Effects of technology-based contraceptive decision aids: A systematic review. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 227(5), 705–713.
- Handayani, S., & Sulastri, S. (2017). Hubungan dukungan suami dengan penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 45–52.
- Hardee, K., Kumar, J., Newman, K., Bakamjian, L., Harris, S., Rodríguez, M., & Brown, W. (2014). Voluntary, human rights-based family planning: A conceptual framework. *Studies in Family Planning*, 45(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2014.00373.x>
- Holt, K., Dehlendorf, C., Langer, A., & Kimport, K. (2020). Patient-centered contraceptive counseling: Evidence and future directions. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 32(5), 355–360.
- Karra, M., et al. (2024). User-centered approaches to contraceptive counseling. Working Paper.
- Kaunitz, A. M. (2020). Contraception in perimenopause. *Menopause*, 27(3), 316–322.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelayanan keluarga berencana. Kemenkes RI.
- Manzer, J. L., et al. (2024). Client perspectives on contraceptive care: A systematic review. *American Journal of Preventive Medicine*, 67(6), S22–S31. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2024.07.019>
- Pratiwi, D., Rahayu, S., & Utami, T. (2020). Akses pelayanan kesehatan dan pemilihan metode kontrasepsi di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(2), 89–98.
- Rahmawati, D., & Dewi, R. K. (2021). Pengaruh pengetahuan terhadap pemilihan metode kontrasepsi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 15(1), 34–41.
- Sari, M., & Lestari, P. (2020). Hubungan karakteristik individu dengan pemilihan metode kontrasepsi. *Jurnal Kesehatan*, 12(1), 56–63.
- Sedgh, G., & Hussain, R. (2014). Reasons for contraceptive nonuse among women having unmet need. *Studies in Family Planning*, 45(2), 151–169.
- Solo, J., Festin, M., & Kiarie, J. (2019). Strengthening contraceptive counseling: Opportunities and challenges. *Global Health: Science and Practice*, 7(2), 1–5. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-19-00128>
- Trussell, J. (2011). Contraceptive failure in the United States. *Contraception*, 83(5), 397–404.
- Tucker Edmonds, B., Hoffman, S. M., Laitano, T., McKenzie, F., Panoch, J., Litwiller, A.,

- & DiCorcia, M. J. (2022). Evaluating shared decision-making in postpartum contraceptive counseling. *Women's Health Reports*, 3(1), 1029–1036. <https://doi.org/10.1089/whr.2022.0067>
- United Nations Population Fund. (2020). Rights-based family planning: Framework for programming. UNFPA.
- Winner, B., Peipert, J. F., Zhao, Q., Buckel, C., Madden, T., Allsworth, J. E., & Secura, G. M. (2012). Effectiveness of long-acting reversible contraception. *New England Journal of Medicine*, 366(21), 1998–2007.
- World Health Organization. (2018). Family planning: A global handbook for providers (3rd ed.). WHO Press.
- World Health Organization. (2020). WHO recommendations on self-care interventions for health and well-being. WHO Press.
- Wulandari, A., Putri, D., & Hidayat, R. (2018). Paritas dan pemilihan metode kontrasepsi pada wanita usia subur. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 10(2), 101–108.

Glosarium

AKDR = Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
ASI = Air Susu Ibu
BCS = Balanced Counseling Strategy
GATHER = Greet, Ask, Tell, Help, Explain, Return
IMS = Infeksi Menular Seksual
IUD = Intrauterine Device
KB = Keluarga Berencana
KIE = Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
MAL = Metode Amenore Laktasi
MEC = Medical Eligibility Criteria
MKJP = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
PUS = Pasangan Usia Subur
SDM = Shared Decision Making
WUS = Wanita Usia Subur



CHAPTER 4



EFEK SAMPING, KONTRA INDIKASI, DAN TINDAK LANJUT PENGUNAAN KONTRASEPSI

Nanin Juliana, S.Kep., Ners., M.K.M.

A. Pendahuluan

Kontrasepsi adalah tindakan mencegah kehamilan. Ini bisa berupa alat, obat-obatan, prosedur, atau perilaku. Kontrasepsi memungkinkan wanita untuk mengendalikan kesehatan reproduksinya dan memberinya kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan keluarganya. Ulasan ini tidak akan membahas aborsi karena itu bukan cara untuk mencegah kehamilan. Metode kontrasepsi adalah kemajuan teknologi yang bertujuan untuk mengatasi biologi. Abad ke-20 telah menyaksikan kemajuan terbesar dalam kesehatan reproduksi wanita yang memperluas pilihan medis, alat, dan bahkan prosedur. Ulasan ini akan berfokus pada obat-obatan, alat, dan prosedur yang tersedia bagi pasangan untuk mencegah kehamilan. Ulasan ini tidak akan berfokus pada perilaku dan metode penghalang yang tersedia (Ismarwati, 2022)

Saat mempertimbangkan metode kontrasepsi, konseling harus mencakup efisiensi, keamanan, penerimaan, dan ketersediaan (termasuk aksesibilitas dan keterjangkauan). Memberikan informasi secara sukarela tentang pilihan metode kontrasepsi merupakan prinsip panduan yang penting, dan konseling kontrasepsi, jika dapat dilakukan, merupakan kontributor yang signifikan terhadap keberhasilan penggunaan metode kontrasepsi (Caecilia et al., 2020)

Pelayanan kontrasepsi yang diberikan meliputi kondom, pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implan, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim, pelayanan tubektomi, dan pelayanan vasektomi. KB Pasca persalinan (KBPP) adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode, alat atau obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari sampai dengan 6 minggu setelah melahirkan. Beberapa studi menunjukkan pelayanan KB (termasuk KBPP) yang efektif dapat mengurangi kematian ibu dengan cara mengurangi kehamilan dan mengurangi kelahiran risiko tinggi (Rohma Nur Fayakun, 2023)

Metode pengendalian kelahiran dirancang untuk mencegah pembuahan atau mengganggu atau membatalkan implantasi dan pertumbuhan. Pembuahan dapat

dicegah dengan mengganggu siklus menstruasi secara hormonal (pil KB), dengan menghalangi saluran secara fisik (metode penghalang atau sterilisasi), atau kurang berhasil, dengan pantang selama periode subur atau metode penarikan. Implantasi terganggu melalui penggunaan benda asing (alat kontrasepsi dalam rahim {IUD}) atau pengangkatan melalui pembedahan (salpingektomi atau vasektomi) (Rohma Nur Fayakun, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian Wenang dan Noviana (2018) didapatkan hasil bahwa terdapat adanya perbedaan perubahan siklus menstruasi pada akseptor KB suntik Depo medrosipiroeterogen asetat (DMPA). Hal tersebut dikarenakan suntik berisikan hormon progesteron dimana hormon progesteron tersebut dapat mengakibatkan gangguan menstruasi sedangkan amonerea yang tinggi dikarenakan karena hormon progesteron menekan LH sehingga menjadi lebih dangkal dan mengalami kemunduran sehingga kelenjar tersebut tidak aktif (Sagita et al., 2022)

Pemakaian alat KB berpengaruh pada masalah mestruasi, permasalahan ini berupa tidak mendapatkan mesntruasi sama sekali sehingga menstruasi banyak dan berlangsung lama. Dimana banyak sekali pengaduan dari para ibu yang banyak berkaitan dengan pemakaian alat kontrasepsi terhadap gangguan haid yang tidak teratur. Tetapi tidak seluruh ibu memiliki keluhan yang sama. Kemungkinan yang dapat terjadi dikarenakan hormon yang tidak sesuai dan imbang dan gangguan haid akan menjadi normal kembali setelah 1-3 bulan (Sagita et al., 2022)

Masalah gangguan menstruasi pada akseptor KB bermacam-macam. Akseptor KB suntik memiliki keluhan berupa gangguan menstruasi dengan gejala-gejala amnorea yaitu tidak mendapatkan menstruasi tiap bulannya ketika menjadi akseptor KB suntik dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut. Di samping itu spotting yaitu bercak perdarahan di luar menstruasi yang timbul selama akseptor KB menggunakan KB suntik. Akseptor KB juga mengeluhkan terjadinya metoragia yaitu perdarahan berlebih di luar haid (Di et al., 2021)

Solusi pada masalah gangguan menstruasi akibat penggunaan KB suntik hormonal adalah dengan cara memberikan promosi maca-macam metode KB selain KB Hormonal Yaitu Metode Kontrasepsi alamiah, Metode Barrier Pria, Kontrasepsi Barrier pada wanita, kontrasepsi hormon (Kaderia, 2025)

B. Efek Samping Kontrasepsi

Efek samping Kontrasepsi (hormonal/non-hormonal) umumnya meliputi gangguan siklus menstruasi (spotting, amenorea), peningkatan berat badan, sakit kepala, mual, nyeri payudara, serta perubahan mood. Kontrasepsi hormonal jangka

panjang juga berisiko meningkatkan tekanan darah, sementara IUD/AKDR berisiko menyebabkan infeksi atau ekspulsi.

Berikut adalah poin-poin efek samping berdasarkan jenis kontrasepsi dari berbagai sumber jurnal:

1. Kontrasepsi Hormonal (Pil, Suntik, Implan):

- a. Gangguan Menstruasi: Paling sering terjadi, seperti perdarahan bercak (*spotting*), menstruasi tidak teratur, hingga amenorea (tidak menstruasi).
- b. Perubahan Berat Badan: Kenaikan berat badan dilaporkan tinggi pada penggunaan pil, suntik, dan implan.
- c. Gejala Fisik: Sakit kepala, pusing, mual, nyeri payudara, dan munculnya jerawat.
- d. Efek Psikologis: Perubahan suasana hati (*mood swing*) hingga risiko depresi.
- e. Kesehatan: Risiko peningkatan tekanan darah (hipertensi) terutama pada penggunaan jangka panjang.

2. Kontrasepsi Non-Hormonal (IUD/AKDR):

Efek samping meliputi peningkatan jumlah darah haid (*menoragia*), nyeri perut saat haid (*dismenorea*), keputihan, atau posisi IUD bergeser/lepas (UNJA,)

Studi sistematis menyebutkan bahwa pada pengguna kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon estrogen dan progesteron atau hanya mengandung hormon progesterone saja memiliki peningkatan resiko terhadap kardiovaskuler. Dalam sebuah meta-analisis ditemukan hubungan positif antara lama penggunaan kontrasepsi oral dan resiko hipertensi dimana terjadinya resiko hipertensi akan meningkat sebesar 13% pada penggunaan kontrasepsi selama 5 tahun. Hasil yang sama juga dilaporkan wanita di Porto-Novu yang menggunakan kontrasepsi hormonal didapatkan 24% mengalami tekanan darah tinggi 1,5% hiperglikemia, 26,9 % kelebihan berat badan, 23,2 % mengalami obesitas dan 47,5 % mengalami obesitas perut.

Sebuah studi kuantitatif yang dilakukan di Brazil menyebutkan beberapa pengguna kontrasepsi hormonal dilaporkan memiliki penyakit kardiovaskular, hipertensi arteri sistemik (75%), stroke, dan diabetes mellitus (DM) yang perlu mendapat perhatian karena dapat mengancam kesehatan wanita (catur,2022)

Hasil penelitian juga memperlihatkan dimana pemakaian KB hormonal 5 kali menyebabkan peningkatan tekanan darah dimana nilai OR = 5,286 Hasil penelitian sebelumnya juga ada hubungan yang signifikan antara umur, lama pemakaian KB dan riwayat hipertensi dengan kejadian hipertensi pada akseptor KB hormonal (Absari, 2020). Selain itu durasi penggunaan KB suntik DMPA juga memiliki hubungan positif dengan peningkatan tekanan darah (hipertensi) dan berat badan, dimana risiko terjadinya hipertensi 1,733 lebih besar terjadi pada

akseptor KB suntik DMPA lebih dari 12 bulan dibanding akseptor yang menggunakan selama 6-12 bulan (Ismarwati, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah, Sarake (2013) menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program KB faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi antara lain efektifitas, keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, umur, pemberian informasi, dukungan suami serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar. Penelitian yang dilakukan oleh Moreau (2007), di Amerika serikat menyatakan banyak wanita yang berhenti menggunakan kontrasepsi dikarenakan faktor ketidakpuasan yang salah satunya adalah karena efek samping yang terjadi, dengan hasil 42% untuk ketidakpuasan terhadap metode hormonal jangka panjang dan ketidakpuasan kontrasepsi oral 29%. Penelitian Hall dkk pada tahun 2014 menyatakan bahwa alasan yang paling sering penghentian penggunaan Oral kontrasepsi adalah masalah akses/ cara mendapatkan nya (26%), adanya efek samping (25%), ketakutan terjadinya perubahan kesuburan (20%), dan sering lupa minum pil (13%) (Caecilia et al., 2020)

Hasil penelitian pada wanita di Thailand, menunjukkan adanya masalah kesehatan merupakan alasan mengapa mereka enggan menggunakan kontrasepsi, walaupun ingin mencegah kehamilan (Sothornwit J, 2020). Adanya banyak ESO pil KB yang terjadi, beresiko pada ketidakpatuhan akseptor dalam menggunakan kontrasepsi Pil KB. Kepatuhan didefinisikan sebagai sejauh mana

perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan. Jika akseptor patuh, maka ia akan minum pil tersebut setiap hari pada saat yang sama sesuai anjuran profesional kesehatan (Niven, 2002). Angka kegagalan pil KB menurut Hartanto (2010) yaitu pil oral kombinasi (POK) angka kegagalan teoritis 0,1% dan praktek 0,7-7%, Pil mini kurang efektif dalam mencegah kehamilan dibandingkan Pil oral – kombinasi, angka kegagalannya menurut teori 2,1% sedangkan praktek di lapangan 9,6%. Penelitian Khan 2001 di Bangladesh menunjukkan bahwa dari 1403 wanita yang diwawancarai, 43% menghentikan penggunaan kontrasepsi oral, dan 53% dari yang berhenti, menyatakan bahwa alasannya adalah ESO. Sedangkan Westhoff dkk. (2007), menyatakan bahwa penghentian penggunaan kontrasepsi oral pada penelitiannya, bukan disebabkan karena efek sampingnya, melainkan pada kesulitan mendapatkan pil KB dan cara menggunakannya dengan benar. Fokus pada efek samping pil KB, akan menyebabkan perhatian pada pelayanan kesehatan bisa menjadi kurang optimal.

C. Kontra Indikasi Kontrasepsi

Kontra indikasi kontrasepsi adalah kondisi medis yang membuat metode KB tertentu tidak aman atau tidak disarankan secara umum, kehamilan yang diketahui atau dicurigai, perdarahan vagina yang belum jelas penyebabnya, kanker payudara, gangguan hati berat, dan penyakit kardiovaskuler adalah kontraindikasi berdasarkan jenis kontrasepsi :

1. Kontrasepsi hormonal (pil, suntik, implan)
 - a. Mutlak : hamil, kanker payudara/organ reproduksi, kanker hati, merokok (>35 tahun), hipertensi berat, riwayat stroke/serangan jantung.
 - b. Relatif : diabetes, migrain dengan aura, gangguan kantung empedu
2. IUD (Intrauterine Device/AKDR)
 - a. Sedang hamil atau dicurigai hamil
 - b. Infeksi panggul(PID) atau infeksi menular seksual aktif
 - c. Kelainan struktur rahim (malformasi kongenital) atau tumor rahim
 - d. Perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya
 - e. Alergi tembaga (untuk IUD tembaga)
3. Kontrasepsi Darurat (Pil Plan B)
Kehamilan yang sudah terkonfirmasi
4. Kondom
Alergi terhadap bahan lateks
5. Kontrasepsi mantap
Kehamilan, infeksi sistemik atau infeksi pelvik akut , serta adanya perdarahan pasca persalinan atau pasca keguguran yang belum teratasi.

Kontra indikasi Kontrasepsi Pada Kondisi Khusus :

1. Penyakit rematik/Lupus (SLE) : penggunaan kontrasepsi hormonal harus hati-hati karena dapat memicu komplikasi .
2. Kanker ginekologi : wanita dengan riwayat kanker ginekologi memerlukan bimbingan khusus karena kontraindikasi terkait estrogen
3. Penting untuk selalu menggunakan WHO MEC Wheel For Contraceptive Eligibility sebagai acuan klinis utama untuk menentukan keamanan metode kontrasepsi bagi individu (Sari & Purnamaningrum, n.d.)

D. Tindak lanjut Kontrasepsi

Tindak lanjut keluarga berencana (KB) adalah serangkaian kegiatan sistemik untuk memastikan efektivitas penggunaan kontrasepsi, meliputi konseling lanjutan, pemantauan efek samping, evaluasi kepuasan akseptor, hingga penyuluhan

berkelanjutan. Ini bertujuan menjaga kesehatan reproduksi, mengatur jarak kelahiran, dan meningkatkan kepesertaan KB aktif

Berikut adalah poin-poin utama dalam tindak lanjut program KB :

1. Pemantauan akseptor (Follow-up) tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan berkala, terutama untuk metode jangka panjang seperti implan atau IUD, guna menganalisis efek samping seperti perubahan siklus haid, pusing atau berat badan.
2. Penyuluhan dan konseling lanjutan : memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai metode yang dipilih. Cara mengatasi keluhan ringan serta memastikan kepatuhan mengenai penggunaan (terutama pil suntik)
3. Evaluasi pelayanan : mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dan kesesuaian dengan tujuan kesehatan reproduksi akseptor (misalnya menjarangkan atau menghentikan kehamilan).
4. Koordinasi lintas sektor : melibatkan pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKB) dan petugas lapangan untuk menyisir calon akseptor KB baru dan memperbarui data akseptor yang ada
5. KB pasca Persalinan (KBPP) : tindak lanjut khusus pada ibu nifas agar langsung menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang cepat setelah melahirkan (Di et al., 2021)

Salah satu metode yang dianjurkan dalam program KB adalah kontrasepsi jangka panjang (MJKP) yang meliputi implan dan IUD. Penggunaan MKJP ini terbukti efektif dalam menekan angka kelahiran karena memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan masa penggunaan yang lebih lama dibandingkan dengan kontrasepsi sementara lainnya.(Kaderia, 2025)

Meskipun demikian rendahnya tingkat penggunaan MJKP di Indonesia masih menjadi masalah, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kedua alat kontrasepsi ini, oleh karena itu penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat khususnya wanita usia subur (WUS) menjadi sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran manfaat MJKP. (Kaderia, 2025)

Jenis dan informasi metode kontrasepsi yang ditemui akseptor adalah unsur pokok dalam menilai kualitas pelayanan, pelayanan kontrasepsi yang berkualitas akan memberikan wawasan terhadap akseptor pada berbagai kemungkinan metode yang dapat dipilih secara luas, termasuk efek samping, kontra indikasi dan kapan alat-alat tersebut dapat dipakai. Persepsi akseptor masih sangat rendah tingkat penerimaan informasi yang diberikan oleh petugas KB dengan rerata tertimbang sebanyak 1,978. Meskipun tidak semua akseptor menerima informasi secara lengkap dan bahkan ada yang mengatakan tidak pernah mendengar apapun ada beberapa akseptor yang mendapat informasi tentang alat kontrasepsi mengatakan sudah cukup jelas, dan dapat mengerti informasi-informasi yang disampaikan, meskipun

informasi tentang efek samping sangat sedikit. Umumnya mereka masih belum paham tentang efek samping untuk masing-masing alat kontrasepsi (Budiman, 2008)

Satu hal yang tidak bisa dilupakan dalam mengambil keputusan dalam memilih kontrasepsi yaitu konseling yang merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Dengan melakukan konseling berarti petugas membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya klien merasa lebih puas, konseling yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Konseling akan mempengaruhi interaksi antara petugas dan klien dengan cara meningkatkan hubungan kepercayaan yang sudah ada. Konseling merupakan proses yang berjalan dan menyatu dengan semua aspek pelayanan KB dan bukan hanya informasi yang diberikan dan dibicarakan pada satu kesempatan yakni pada saat pemberian pelayanan, teknik konseling yang baik, informasi yang memadai harus diterapkan dan dibicarakan secara interaktif sepanjang kunjungan klien dengan cara yang sesuai dengan budaya yang ada. (Heyrani, Hendrayulita, n.d.)

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan mutu ketrampilan bidan dalam berkomunikasi dan konseling harus terus dilatih dan diupdate. Komunikasi dan konseling yang berkualitas akan menjamin klien memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai pilihannya. Konseling yang baik dapat membuat klien merasa puas, disamping itu juga akan membantu klien lebih lestari dalam menggunakan kontrasepsinya. Proses konseling yang berkualitas akan memastikan tujuan konseling dapat tercapai antara bidan dan akseptor KB seperti untuk mendapatkan keputusan yang rasional dan sesuai dalam penggunaan kontrasepsi. Dengan tujuan konseling secara spesifik sebagai berikut

1. Memahami diri secara baik
2. Mengarahkan perkembangan diri sesuai dengan potensinya
3. Lebih realistis dalam melihat diri dan masalah yang dihadapi, klien mampu melihat masalah secara kreatif dan produktif, memiliki taraf aktualisasi diri sesuai dengan potensi yang dimiliki, terhindar dari gejala kecemasan, dan salah penyesuaian diri, mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan serta memperoleh kebahagiaan (Heyrani, Hendrayulita, n.d.)

E. Kesimpulan

Kontrasepsi adalah tindakan mencegah kehamilan. Ini bisa berupa alat, obat-obatan, prosedur, atau perilaku. Kontrasepsi memungkinkan wanita untuk mengendalikan kesehatan reproduksinya dan memberinya kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan keluarganya. Ulasan ini tidak akan membahas aborsi karena itu bukan cara untuk mencegah kehamilan. Metode kontrasepsi adalah kemajuan teknologi yang bertujuan untuk mengatasi biologi. Abad ke-20 telah menyaksikan kemajuan terbesar dalam kesehatan reproduksi wanita yang memperluas pilihan medis, alat, dan bahkan prosedur. Ulasan ini akan berfokus pada obat-obatan, alat, dan prosedur yang tersedia bagi pasangan untuk mencegah kehamilan. Ulasan ini tidak akan berfokus pada perilaku dan metode penghalang yang tersedia (Imantika, 2018)

dalam pelaksanaan program KB faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi antara lain efektifitas, keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, umur, pemberian informasi, dukungan suami serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar. Penelitian yang dilakukan oleh Moreau (2007), di Amerika serikat menyatakan banyak wanita yang berhenti menggunakan kontrasepsi dikarenakan faktor ketidakpuasan yang salah satunya adalah karena efek samping yang terjadi, dengan hasil 42% untuk ketidakpuasan terhadap metode hormonal jangka panjang dan ketidakpuasan kontrasepsi oral 29%. Penelitian Hall dkk pada tahun 2014 menyatakan bahwa alasan yang paling sering penghentian penggunaan Oral kontrasepsi adalah masalah akses/ cara mendapatkan nya (26%), adanya efek samping (25%), ketakutan terjadinya perubahan kesuburan (20%), dan sering lupa minum pil (13%).

Salah satu metode yang dianjurkan dalam program KB adalah kontrasepsi jangka panjang (MJKP) yang meliputi implan dan IUD. Penggunaan MKJP ini terbukti efektif dalam menekan angka kelahiran karena memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan masa penggunaan yang lebih lama dibandingkan dengan kontrasepsi sementara lainnya.(Kaderia, 2025)

Meskipun demikian rendahnya tingkat penggunaan MJKP di Indonesia masih menjadi masalah, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kedua alat kontrasepsi ini, oleh karena itu penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat khususnya wanita usia subur (WUS) menjadi sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran manfaat MJKP. (Kaderia, 2025)

Jenis dan informasi metode kontrasepsi yang ditemui akseptor adalah unsur pokok dalam menilai kualitas pelayanan, pelayanan kontrasepsi yang berkualitas akan memberikan wawasan terhadap akseptor pada berbagai kemungkinan metode

yang dapat dipilih secara luas, termasuk efek samping, kontra indikasi dan kapan alat-alat tersebut dapat dipakai. Persepsi akseptor masih sangat rendah tingkat penerimaan informasi yang diberikan oleh petugas KB dengan rerata tertimbang sebanyak 1,978. Meskipun tidak semua akseptor menerima informasi secara lengkap dan bahkan ada yang mengatakan tidak pernah mendengar apapun ada beberapa akseptor yang mendapat informasi tentang alat kontrasepsi mengatakan sudah cukup jelas, dan dapat mengerti informasi-informasi yang disampaikan, meskipun informasi tentang efek samping sangat sedikit. Umumnya mereka masih belum paham tentang efek samping untuk masing-masing alat kontrasepsi (Budiman, 2008)

Referensi

- Budiman. (2008). *Kualitas pelayanan keluarga berencana di kecamatan unaaha kabupaten konawe*.
- Caecilia, M., Setiawati, N., Prasetyaningrum, E., Alit, D., Tinggi, S., Farmasi, I., & Pharmasi, Y. (2020). *EFEK SAMPING PIL KB PADA AKSEPTOR DI KELURAHAN MANYARAN KOTA SEMARANG*. 4(2), 175–184.
- Di, M., Anik, B. P. M., & Sidodadi, D. (2021). *HUBUNGAN PEMAKAIAN KB SUNTIK 3 BULAN DENGAN PERUBAHAN SIKLUS MENSTRUASI DI BPM ANIK DESA SIDODADI The Correlation Between Use of 3-Month Injectable Family Planning and Changes in The Menstrual Cycle at Anik Independent Midwife Practice, Sidodadi Village*. 126–132.
- Heyrani, Hendrayulita, A. (n.d.). *KUALITAS KONSELING BIDAN TERHADAP INDIKASI KONTRADIKASI DI KOTA KENDARI.pdf*.
- Imantika, E. (2018). *Penyuluhan Mengenai Indikasi dan Kotraindikasi Pemasangan Kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) Wanita Usia Subur Pada Program Mobil Layanan KB Kecamatan Panjang BKKBN Kota Bandar Lampung*. 33–36.
- Ismarwati, C. S. (2022). *EFEK PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP TEKANAN DARAH SCOPING REVIEW*. 13(2), 131–153.
- Kaderia, H. (2025). *Penyuluhan dan Pelayanan KB Gratis (Implan-IUD) di Wilayah Puskesmas Poleang Barat sebagai Upaya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk*. 2(10), 4556–4561.
- Rohma Nur Fayakun, S. (2023). *HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU NIFAS TERHADAP PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI PASCASALIN DI PUSKESMAS SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG*. 05(1), 1–14.
- Sagita, L., Rudini, D., Keperawatan, P. S., Kedokteran, F., & Jambi, U. (2022). *Gambaran Efek Samping Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Kota Jambi kontrasepsi*. 1.
- Sari, S. W., & Purnamaningrum, Y. E. (n.d.). *Gambaran efek samping kontrasepsi suntik pada akseptor kb suntik*. 30–34.

Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur

KBPP = Keluarga Berencana Pasca Persalinan

AKDR = Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

IUD = Intra Uterine Device

POK = Pil Oral Kombinasi

DMPA = Depo medrosipiroeterogen asetat

DM = Diabetes Melitus

MKJP = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

CHAPTER 5

PERAN BIDAN DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) PASCAPERSALINAN DAN INTERVAL

Dr. Bdn. Irma Seriana, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan keluarga melalui pengaturan kehamilan sesuai kebutuhan. Keluarga Berencana penting untuk meningkatkan kesehatan reproduksi wanita sehingga dapat menurunkan kesakitan dan kematian ibu akibat kehamilan yang tidak direncanakan. Program KB berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian ibu, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi risiko komplikasi obstetri serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga (Permen Kedukbangga, 2025). *World Health Organization* menyebutkan bahwa akses universal terhadap pelayanan kontrasepsi merupakan bagian esensial dari pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas (WHO, 2025).

Secara global, masih terdapat jutaan perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan ber-KB tetapi belum terpenuhi (*unmet need*). Kondisi ini meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan, abortus tidak aman, kehamilan risiko tinggi dan persalinan dengan komplikasi. Di negara berkembang, keterbatasan akses informasi, hambatan budaya, kurangnya dukungan pasangan, serta ketidakmerataan tenaga kesehatan menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan pelayanan kontrasepsi. Oleh karena itu, penguatan layanan KB yang mudah diakses, aman dan berkesinambungan menjadi prioritas pembangunan kesehatan reproduksi (UNFPA, 2024).

Salah satu periode penting dalam pelayanan KB adalah masa pascapersalinan. Masa ini merupakan waktu penting karena sebagian besar perempuan melakukan kontak dengan fasilitas kesehatan saat persalinan dan masa nifas, sehingga peluang pemberian konseling dan pelayanan kontrasepsi menjadi lebih besar. Selain itu, kesuburan perempuan dapat kembali sebelum menstruasi pertama, terutama bila tidak menyusui eksklusif. Hal ini menyebabkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan meningkat apabila kontrasepsi tidak segera dimulai. Jarak kehamilan yang terlalu dekat, khususnya kurang dari 24 bulan setelah persalinan dapat

meningkatkan risiko anemia, perdarahan, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah dan kematian neonatal (WHO, 2025).

Selain itu, pelayanan KB pada masa interval juga memegang peranan penting dalam sistem kesehatan reproduksi. KB interval adalah pelayanan kontrasepsi yang diberikan pada perempuan di luar masa kehamilan dan nifas, baik untuk menunda kehamilan pertama, menjarangkan kelahiran berikutnya, maupun mengakhiri kesuburan sesuai rencana keluarga. Pelayanan ini memberikan kesempatan kepada pasangan usia subur untuk memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan, usia, jumlah anak, kebutuhan serta rencana reproduksi jangka panjang (Cleland et al., 2022; Lucia & Jeffrey, 2026).

Di Indonesia, program KB masih menghadapi berbagai tantangan seperti masih tingginya penggunaan kontrasepsi jangka pendek, tingginya angka putus pakai (*drop out*), kesenjangan akses di wilayah terpencil serta rendahnya keterlibatan suami dalam pengambilan keputusan reproduksi. Selain itu, masih ditemukan persepsi negatif dan mitos terkait efek samping kontrasepsi yang menyebabkan keraguan masyarakat dalam menggunakan metode KB modern. Kondisi tersebut menuntut tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi yang tepat dan pelayanan yang berpusat pada kebutuhan klien (BKKBN, 2024).

Bidan merupakan tenaga kesehatan terdepan yang mendampingi perempuan sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan kesehatan reproduksi. Kedekatan bidan dengan perempuan dan keluarga menjadikan profesi ini memiliki peluang besar dalam meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi. Bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan klinis, tetapi juga sebagai edukator, konselor, advokat, fasilitator pengambilan keputusan dan penghubung sistem rujukan (ICM, 2024).

Peran bidan dalam KB juga sejalan dengan pendekatan *continuity of care* yaitu pelayanan berkesinambungan sepanjang siklus reproduksi perempuan. Melalui pendekatan ini, bidan dapat mengintegrasikan pelayanan antenatal care, persalinan, nifas dan KB dalam satu rangkaian pelayanan komprehensif. Pendekatan tersebut terbukti meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan klien serta efektivitas program kesehatan ibu dan anak (ICM, 2024). Dengan demikian, peran bidan dalam pelayanan KB pascapersalinan dan masa interval sangat penting. Pemahaman yang komprehensif mengenai peran tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi bidan dalam menurunkan kehamilan berisiko, meningkatkan cakupan kontrasepsi modern serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional dan global.

B. Pelayanan KB Pascapersalinan sebagai Upaya Pencegahan Risiko Reproduksi

Pelayanan KB pascapersalinan merupakan salah satu strategi penting dalam kesehatan reproduksi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan setelah persalinan serta mengatur jarak kelahiran yang aman. Periode setelah melahirkan sering kali menjadi fase transisi yang membutuhkan perhatian khusus karena perempuan mengalami perubahan fisiologis, psikologis, sosial serta penyesuaian peran sebagai ibu. Pada masa ini, kebutuhan terhadap pelayanan kontrasepsi menjadi sangat penting agar ibu dapat memulihkan kondisi kesehatannya sebelum memasuki kehamilan berikutnya (WHO, 2025).

1. Definisi KB Pascapersalinan

KB pascapersalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan melalui penggunaan metode kontrasepsi yang diberikan segera setelah persalinan sampai dengan 12 bulan pertama. Pelayanan ini dapat dimulai dalam waktu 48 jam setelah persalinan, selama masa nifas, maupun pada kunjungan lanjutan setelah ibu kembali ke fasilitas kesehatan. Tujuan utama KB pascapersalinan adalah mencegah kehamilan terlalu cepat, mengurangi risiko komplikasi maternal dan neonatal serta mendukung keberhasilan menyusui dan pemulihan kesehatan ibu (WHO, 2024). Menurut Kemenkes RI (2021), kontrasepsi pascapersalinan adalah metode kontrasepsi yang diberikan sebagai upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat/obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai kurun waktu 42 hari/6 minggu setelah melahirkan dengan tujuan mengatur jarak kehamilan/kelahiran dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat (Kemenkes RI, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2025), KB pascapersalinan yang selanjutnya disebut KBPP adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari dengan tujuan mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat.

Periode pascapersalinan langsung (dalam 48 jam setelah melahirkan) merupakan waktu yang ideal untuk KB, karena pasti tidak hamil, sangat termotivasi untuk memulai metode kontrasepsi pada saat tersebut dan setelah pulang disibukkan merawat bayinya sehingga lupa untuk KB. Perluasan pelayanan KB sampai 12 bulan pertama pascapersalinan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi perempuan yang berubah selama periode tersebut antara lain

perubahan status menyusui dapat memicu kebutuhan untuk memulai metode KB (Kemenkes RI, 2021).

Pelayanan KB pascapersalinan merupakan bagian dari *continuum of maternal care* yang terintegrasi dengan pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan kesehatan bayi baru lahir. Oleh karena itu, konseling mengenai pilihan kontrasepsi sebaiknya sudah diberikan sejak masa kehamilan agar ibu dan keluarga dapat menentukan metode yang sesuai sebelum persalinan (ICM, 2024).

2. Waktu Ideal Pemberian KB Pascapersalinan

Waktu pemberian kontrasepsi setelah persalinan harus mempertimbangkan kondisi ibu, status menyusui, jenis persalinan dan metode kontrasepsi yang dipilih. Secara umum, kontrasepsi dapat diberikan pada beberapa fase berikut:

a. Segera setelah persalinan (0–48 jam)

Metode seperti AKDR pasca plasenta, implan, kondom dan metode operasi wanita dapat diberikan bila tidak ada kontraindikasi.

b. Masa nifas dini (48 jam–6 minggu)

Pada fase ini, metode progestin dapat mulai dipertimbangkan, terutama bagi ibu menyusui, dengan memperhatikan pedoman kelayakan medis penggunaan kontrasepsi.

c. Setelah 6 minggu postpartum

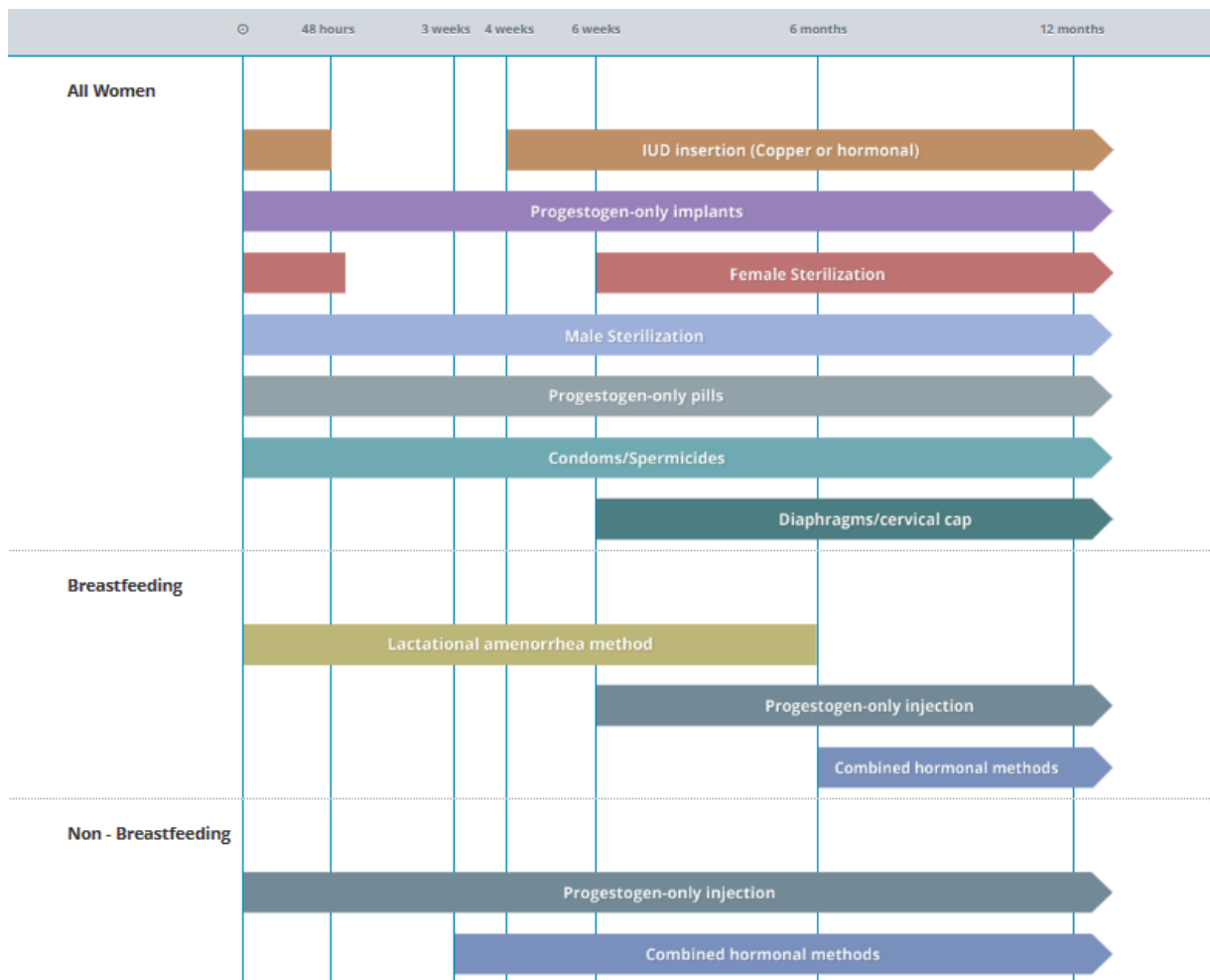
Hampir seluruh metode kontrasepsi dapat digunakan, termasuk kontrasepsi hormonal kombinasi pada ibu yang tidak menyusui atau dengan pertimbangan klinis tertentu.

d. Setelah 6 bulan postpartum

Bila ibu tidak lagi memenuhi syarat menggunakan kontrasepsi Metode Amenorea Laktasi (MAL), kontrasepsi modern lain harus segera digunakan (WHO, 2025).

Pada pemberian kontrasepsi pascapersalinan, waktu pemberian yang tepat sangat penting karena ovulasi dapat terjadi sebelum menstruasi pertama, terutama pada ibu yang tidak menyusui eksklusif. Banyak perempuan menganggap belum subur karena belum haid, padahal kehamilan dapat terjadi tanpa disadari.

WHO telah mengembangkan Kompendium KB pascapersalinan, platform berbasis web (<http://srhr.org/postpartumfp>) yang mudah digunakan untuk penyedia layanan, manajer program dan pembuat kebijakan. Waktu memulai kontrasepsi pasca persalinan tergantung dari status menyusui.



Gambar 5. 1 The Postpartum Family Planning Compendium (WHO, 2025)

3. Risiko Kehamilan Terlalu Cepat setelah Persalinan

Kehamilan dengan jarak terlalu dekat setelah persalinan, khususnya kurang dari 24 bulan dapat meningkatkan berbagai risiko reproduksi. Pada ibu, kehamilan yang terlalu cepat dapat menyebabkan anemia, kelelahan kronis, gangguan pemulihan organ reproduksi, perdarahan antepartum maupun postpartum serta meningkatnya risiko komplikasi obstetri pada kehamilan berikutnya. Sementara pada bayi, jarak kehamilan yang pendek berhubungan dengan kejadian prematuritas, bayi berat lahir rendah, gangguan tumbuh kembang dan meningkatnya kematian neonatal. Selain dampak fisik, kehamilan terlalu cepat juga dapat meningkatkan beban psikososial ibu, terutama bila ibu masih beradaptasi dengan peran pengasuhan bayi sebelumnya. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu dan stabilitas ekonomi keluarga (Cleland et al., 2022 ; Lucia & Jeffrey, 2026).

4. KB Pascapersalinan terhadap Penurunan AKI dan Stunting

Saat ini kematian ibu di dunia juga masih sangat tinggi, setiap hari di tahun 2023, lebih dari 700 wanita meninggal karena penyebab yang dapat dicegah terkait kehamilan dan persalinan dan setiap 2 menit terjadi kematian ibu. Pelayanan oleh tenaga kesehatan terampil sebelum, selama dan setelah persalinan dapat menyelamatkan nyawa wanita dan bayi baru lahir. Sebagian besar komplikasi ini berkembang selama kehamilan dan sebagian besar dapat dicegah atau diobati, diantaranya adalah melalui penggunaan kontrasepsi pascapersalinan sesuai dengan kebutuhan ibu. Komplikasi utama yang menyebabkan sekitar 75% dari semua kematian ibu adalah pendarahan hebat (biasanya pendarahan setelah melahirkan), infeksi (biasanya setelah melahirkan), tekanan darah tinggi selama kehamilan (preeklampsia dan eklampsia), komplikasi akibat persalinan dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2025).

Pelayanan KB pascapersalinan memiliki kontribusi nyata terhadap penurunan kematian ibu. Pencegahan kehamilan yang terlalu sering, terlalu dekat, terlalu muda dan terlalu tua, kontrasepsi membantu menurunkan paparan perempuan terhadap risiko kehamilan berulang dan komplikasi obstetri. Pengaturan kehamilan juga memberi waktu bagi ibu untuk memperbaiki status gizi, memulihkan anemia dan menyiapkan kehamilan berikutnya secara optimal (UNFPA, 2024).

Selain itu, KB pascapersalinan juga berhubungan erat dengan pencegahan stunting. Jarak kelahiran yang ideal memungkinkan orang tua memberikan perhatian, nutrisi dan stimulasi yang lebih baik kepada anak. Bayi yang lahir dari kehamilan dengan interval terlalu pendek lebih rentan lahir prematur atau berat badan lahir rendah yang merupakan faktor risiko utama stunting. Dengan demikian, penguatan pelayanan KB pascapersalinan mendukung intervensi 1.000 hari pertama kehidupan secara tidak langsung (Deby dkk, 2024; Kemenkes RI, 2024).

5. Cakupan Pelayanan KB Pascapersalinan di Indonesia

Di Indonesia, pelayanan KB pascapersalinan menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mendorong integrasi pelayanan KB dengan pelayanan persalinan dan nifas di rumah sakit, puskesmas, klinik dan praktik mandiri bidan. Saat ini, sudah ada Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan yang

menjadi rujukan dalam memberikan Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan di berbagai tingkat layanan kesehatan.

Meskipun cakupan akseptor KB pascapersalinan menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih ditemukan berupa rendahnya konseling antenatal, kurangnya kesiapan pengambilan keputusan pasangan, ketakutan terhadap efek samping serta keterbatasan tenaga terlatih dalam pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang seperti AKDR dan implan. Selain itu, kesenjangan wilayah perkotaan dan pedesaan juga masih memengaruhi akses layanan (BKKBN, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas bidan sebagai ujung tombak pelayanan maternal dan reproduksi sangat diperlukan agar pelayanan KB pascapersalinan dapat menjangkau lebih banyak perempuan secara berkualitas, aman dan berkelanjutan.

C. Pelayanan KB Masa Interval sebagai Strategi Perencanaan Keluarga

Pelayanan KB masa interval merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan reproduksi karena memberikan kesempatan kepada pasangan usia subur (PUS) untuk merencanakan kehamilan secara sadar, aman dan sesuai kondisi keluarga. Berbeda dengan KB pascapersalinan yang diberikan segera setelah persalinan, KB masa interval dilakukan di luar masa kehamilan dan nifas, ketika perempuan berada dalam kondisi reproduksi yang relatif stabil. Pelayanan ini menjadi strategi utama dalam pengaturan jumlah anak, pengaturan jarak kehamilan serta pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan (WHO, 2025).

Penggunaan KB masa interval sangat penting dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas. Dengan kemampuan merencanakan waktu kehamilan, pasangan dapat mempersiapkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi sebelum memiliki anak berikutnya. Selain itu, pelayanan ini juga mendukung pemenuhan hak reproduksi perempuan untuk menentukan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan secara bertanggung jawab (UNFPA, 2024).

1. Definisi KB Masa Interval

KB masa interval adalah pelayanan kontrasepsi yang diberikan kepada perempuan atau pasangan usia subur di luar masa kehamilan, persalinan, maupun nifas dengan tujuan menunda kehamilan pertama, menjarangkan kelahiran berikutnya atau mengakhiri kesuburan sesuai kebutuhan keluarga. Istilah “interval” merujuk pada jarak waktu antar kehamilan, sehingga penggunaan kontrasepsi pada masa ini bertujuan mengatur interval kehamilan agar tetap aman bagi ibu dan anak (WHO, 2024). Pelayanan KB masa interval mencakup asuhan pra pelayanan, pelayanan kontrasepsi dan pasca pelayanan

kontrasepsi. Pelayanan ini dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan praktik mandiri bidan (Kemenkes RI, 2021).

2. Sasaran Pelayanan KB Interval

Sasaran utama pelayanan KB interval adalah pasangan usia subur yang membutuhkan pengaturan fertilitas sesuai rencana kehidupan reproduksi mereka. Kelompok sasaran tersebut meliputi:

- Pasangan yang ingin menunda kehamilan pertama, seperti pasangan baru menikah yang ingin mempersiapkan pendidikan, ekonomi atau kesehatan sebelum memiliki anak.
- Pasangan yang ingin mengatur jarak kehamilan. Pengaturan jarak kelahiran penting untuk memberikan waktu pemulihan kesehatan ibu dan optimalisasi tumbuh kembang anak sebelumnya.
- Pasangan yang telah memiliki jumlah anak ideal. Kelompok ini memerlukan metode kontrasepsi jangka panjang atau permanen.
- Perempuan dengan kondisi medis tertentu seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung atau kondisi lain yang memerlukan perencanaan kehamilan lebih ketat.
- Perempuan usia >35 tahun atau usia reproduksi risiko tinggi. Pada kelompok ini, kehamilan perlu direncanakan dengan cermat karena risiko obstetri cenderung meningkat (Kemenkes RI, 2021).

Dengan demikian, pelayanan KB interval bersifat individual dan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing klien.

Tabel 5. 1 Prioritas Pilihan Metode Kontrasepsi (Kemenkes RI, 2021)

Urutan Prioritas	Fase Menunda Kehamilan	Fase Menjarangkan Kehamilan (anak < 2)	Fase Tidak Hamil Lagi (anak > 3)
1	Pil	AKDR	Metode Operasi
2	AKDR	Suntik	AKDR
3	Kondom	Mini pil	Implan
4	Implan	Pil	Suntik
5	Suntik	Implan	Kondom
6	AKDR	Kondom	Pil

3. Manfaat Mengatur Jarak Kehamilan

Penjarangan kehamilan merupakan tujuan utama dari pelayanan KB interval. Jarak kehamilan yang ideal yaitu minimal 24 bulan setelah persalinan sebelumnya, memberikan banyak manfaat bagi ibu, bayi dan keluarga. Bagi ibu, jarak kelahiran yang cukup memungkinkan tubuh memulihkan cadangan nutrisi, memperbaiki

kondisi anemia serta menurunkan risiko komplikasi obstetri pada kehamilan berikutnya. Risiko perdarahan, persalinan prematur dan kematian maternal juga lebih rendah pada perempuan dengan interval kehamilan yang adekuat (Cleland et al., 2022). Bagi bayi dan anak, pengaturan jarak kehamilan memberikan kesempatan memperoleh ASI eksklusif, perhatian orang tua, stimulasi perkembangan serta pemenuhan gizi yang lebih optimal. Anak yang lahir dengan jarak terlalu dekat lebih rentan mengalami berat badan lahir rendah, prematuritas, infeksi, dan gangguan pertumbuhan termasuk stunting (UNFPA, 2024). Selain manfaat kesehatan, pengaturan jarak kehamilan juga berdampak positif pada kondisi psikososial dan ekonomi keluarga. Orang tua memiliki waktu lebih baik dalam pengasuhan anak, stabilitas emosional keluarga meningkat dan perencanaan ekonomi rumah tangga menjadi lebih teratur (BKKBN, 2024).

4. Faktor Pemilihan Metode Kontrasepsi pada Masa Interval

Pemilihan metode kontrasepsi pada masa interval harus didasarkan pada prinsip *client-centered care* yaitu menempatkan kebutuhan dan preferensi klien sebagai fokus utama pelayanan. Beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- a. Usia dan paritas
- b. Perempuan muda yang belum memiliki anak mungkin memilih metode reversibel, sedangkan pasangan dengan jumlah anak cukup dapat mempertimbangkan metode jangka panjang.
- c. Kondisi kesehatan
- d. Riwayat hipertensi, diabetes, tromboemboli, migrain atau penyakit jantung akan memengaruhi keamanan penggunaan metode hormonal tertentu.
- e. Keinginan memiliki anak di masa depan
Bila masih menginginkan kehamilan, metode reversibel seperti pil, suntik, implan atau AKDR menjadi pilihan.
- f. Efektivitas metode
Klien perlu mendapatkan informasi tentang tingkat keberhasilan masing-masing metode kontrasepsi.
- g. Efek samping dan kenyamanan penggunaan
Toleransi terhadap perubahan pola haid, kenaikan berat badan atau kebutuhan kunjungan ulang perlu dibahas dalam konseling.
- h. Dukungan pasangan dan budaya.
Keputusan kontrasepsi sering dipengaruhi pasangan, keluarga, maupun norma sosial setempat.
- i. Akses dan biaya layanan

Ketersediaan metode dan kemudahan memperoleh layanan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan penggunaan (WHO, 2024).

Bidan berperan sangat penting dalam membantu klien memahami seluruh pilihan tersebut melalui konseling yang objektif dan berbasis bukti sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan pasangan. Pelayanan KB masa interval merupakan strategi efektif dalam perencanaan keluarga karena memungkinkan pasangan merencanakan kehamilan secara sehat, aman dan bertanggung jawab. Melalui pengaturan kehamilan yang ideal serta pemilihan metode kontrasepsi yang tepat, pelayanan ini berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan keluarga serta penurunan risiko reproduksi.

D. Peran Bidan dalam Pelayanan KB Pascapersalinan dan Masa Interval

Bidan memiliki posisi yang sangat penting dalam pelayanan KB karena menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan perempuan, pasangan dan keluarga sepanjang siklus reproduksi. Selain memberikan pelayanan klinis, bidan berperan penting sebagai edukator dan konselor yang membantu klien memahami kebutuhan reproduksinya, memilih metode kontrasepsi yang tepat, serta menggunakan kontrasepsi secara aman dan berkelanjutan. Peran edukatif ini sangat penting karena keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat kontrasepsi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, pemahaman klien dan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan (ICM, 2024). Bidan sebagai konselor bertugas memberikan informasi yang objektif, berbasis bukti dan sesuai kondisi individu. Konseling yang baik terbukti meningkatkan penerimaan kontrasepsi, kepatuhan penggunaan serta menurunkan angka putus pakai (*drop out*) kontrasepsi. Oleh karena itu, peran bidan sebagai edukator dan konselor harus dilakukan secara sistematis sejak masa kehamilan, pascapersalinan, maupun pada masa interval (Ahmed et al., 2025).

Menurut Permenkes RI No.2 Tahun 2025 tentang upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi, menyebutkan bahwa pelayanan pengaturan kehamilan bertujuan membantu pasangan usia subur dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk hamil, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak, serta kondisi kesehatannya. Pelayanan pengaturan kehamilan dilaksanakan melalui penyelenggaraan program keluarga berencana, termasuk melalui pelayanan kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi dilakukan terhadap kelompok usia subur yang terdiri atas pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Setiap usia subur berhak memperoleh informasi tentang pelayanan kontrasepsi, memperoleh

akses ke pelayanan kontrasepsi dan memilih metode kontrasepsi untuk dirinya tanpa paksaan. Metode kontrasepsi dilakukan sesuai pilihan pasangan usia subur dengan mempertimbangkan usia, jumlah persalinan, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama. Pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Pelayanan tersebut diberikan kepada pasangan usia subur dengan tujuan menunda kehamilan pada pasangan muda, yang istrinya belum berusia 20 (dua puluh) tahun atau pasangan yang memiliki masalah kesehatan, mengatur jarak kehamilan pada klien yang berusia antara 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada semua pasangan dan pada pasangan dengan istri yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun. Selain itu, pemberian pelayanan kontrasepsi harus dilakukan sesuai standar oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan prapelayanan kontrasepsi, tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi, termasuk pelayanan kontrasepsi darurat dan kegiatan pascapelayanan kontrasepsi.

Bidan mempunyai peran penting dalam pelayanan kontrasepsi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan meliputi prapelayanan dan tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi dan pascapelayanan. Kegiatan prapelayanan kontrasepsi dilakukan untuk menyiapkan klien dalam memilih metode kontrasepsi. Bentuk kegiatan prapelayanan kontrasepsi meliputi pemberian komunikasi, informasi dan edukasi tentang perencanaan kehamilan untuk menunda, menjarangkan/membatasi kelahiran dan pemilihan metode kontrasepsi yang tepat, pemberian konseling tentang pilihan metode, efek samping dan penanganan efek samping dengan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan, penapisan kelayakan medis untuk memastikan pilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan kondisi kesehatan klien dan persetujuan tindakan. Kegiatan berikutnya adalah tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi diberikan sesuai dengan pilihan klien dengan salah satu metode kontrasepsi yang masa pelaksanaan pelayanannya dapat dilakukan pada masa interval dan pascapersalinan. Kegiatan selanjutnya adalah pascapelayanan kontrasepsi meliputi pemantauan dan penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi dan pemberian konseling, pelayanan medis, dan/atau rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dijelaskan bahwa pelaksanaan prapelayanan KB pascapersalinan

di fasilitas pelayanan meliputi konseling yang diberikan sedini mungkin sejak pemeriksaan pertama pada kehamilan dan sebaiknya keputusan penggunaan kontrasepsi sudah diambil sebelum persalinan, konseling dengan menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK), penapisan kelayakan medis dengan menggunakan roda kriteria kelayakan medis kontrasepsi untuk memastikan pilihan metode kontrasepsi, persetujuan pilihan kontrasepsi dan persetujuan tindakan medis.

Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi diberikan kepada ibu pascapersalinan dan pasangannya setelah mendapatkan konseling dan memberikan persetujuan tindakan medis. Dalam hal ibu pascapersalinan dan pasangannya belum menentukan pilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan, tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan memberikan KIE dan Konseling untuk menggunakan kontrasepsi berupa pil progestin dan/atau kondom. Pelaksanaan KIE dan Konseling dapat dilaksanakan secara berulang sampai dengan 42 (empat puluh dua) pascapersalinan. Pelaksanaan pascapelayanan KBPP berupa pemantauan dan penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan kontrasepsi dan pemberian konseling layanan medis dan/atau rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut peran bidan dalam pelayanan KB pascapersalinan dan masa interval adalah :

1. Kegiatan Pra Pelayanan Kontrasepsi

a. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

Bidan berperan memberikan KIE pada ibu pascapersalinan, KIE difokuskan pada perencanaan kehamilan berikutnya dan pemahaman tentang kembalinya kesuburan setelah melahirkan. Bidan memberikan informasi bahwa ovulasi dapat terjadi sebelum menstruasi pertama, menyusui tidak selalu mencegah kehamilan kecuali memenuhi syarat MAL dan jarak kehamilan ideal minimal 2 tahun. Edukasi juga mencakup pilihan kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui (AKDR, implan, progestin-only) dan waktu mulai penggunaan kontrasepsi (segera setelah persalinan, masa nifas atau kunjungan ulang). Pendekatan KIE dilakukan sejak antenatal care (ANC), diperkuat saat persalinan dan dimantapkan pada masa nifas.

Pada masa interval, KIE lebih luas dan fleksibel karena klien tidak berada dalam kondisi postpartum. Fokus edukasi meliputi perencanaan jumlah dan jarak anak sesuai kondisi keluarga, pilihan metode kontrasepsi lengkap (jangka pendek, panjang, permanen), efektivitas dan cara penggunaan masing-masing metode. Pada fase ini, bidan juga menyesuaikan edukasi dengan usia klien, paritas dan rencana fertilitas jangka panjang (Kemenkes RI, 2021).

b. Pemberian Konseling dengan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)

Bidan berperan dalam memberikan konseling pada calon peserta KB. Konseling dilakukan untuk memberikan berbagai masukan dalam metode kontrasepsi dan hal-hal yang dianggap perlu untuk diperhatikan dalam metode kontrasepsi yang menjadi pilihan klien berdasarkan tujuan reproduksinya. Tindakan konseling ini disebut sebagai *informed choice*. *Informed choice* berarti klien mendapatkan informasi lengkap, jujur dan seimbang mengenai seluruh pilihan metode kontrasepsi sehingga dapat menentukan keputusan sesuai nilai, kebutuhan dan preferensinya.

Pada KB Pascapersalinan konseling bersifat lebih terarah dan kontekstual, dengan mempertimbangkan status menyusui, kondisi nifas dan kelelahan dan kondisi psikologis ibu. Bidan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan (ABPK) untuk membantu klien memahami pilihan metode, menyesuaikan metode dengan kondisi laktasi, menjelaskan efek samping seperti amenorea atau spotting. Konseling dilakukan secara bertahap sejak ANC (perencanaan), postpartum (penguatan keputusan) dan nifas (implementasi metode). Pelayanan ANC merupakan waktu yang ideal untuk memulai konseling KB. Pada masa kehamilan, perempuan dan pasangan umumnya lebih terbuka dalam mendiskusikan rencana masa depan keluarga, termasuk jumlah anak dan jarak kehamilan berikutnya. Oleh karena itu, bidan perlu mengintegrasikan konseling KB dalam setiap kunjungan ANC, terutama pada trimester akhir. Materi konseling pada masa ANC meliputi manfaat pengaturan jarak kehamilan, risiko kehamilan terlalu dekat setelah persalinan, pilihan kontrasepsi pascapersalinan, keamanan metode bagi ibu menyusui serta rencana penggunaan kontrasepsi setelah melahirkan. Konseling dini memungkinkan pasangan memiliki waktu untuk mempertimbangkan pilihan secara matang sehingga keputusan tidak dilakukan secara terburu-buru setelah persalinan (Kate et al, 2024; WHO, 2024). Selain itu, bidan perlu menilai kebutuhan individual klien, termasuk usia, jumlah anak, kondisi kesehatan, pengalaman penggunaan kontrasepsi sebelumnya, dan dukungan pasangan. Pendekatan personal ini penting agar rencana kontrasepsi sesuai dengan kondisi nyata klien (Kemenkes RI, 2021).

Selain itu, masa pascapersalinan dan nifas merupakan momentum penting untuk memperkuat kembali konseling yang telah diberikan saat kehamilan. Pada fase ini, ibu telah memasuki peran baru sebagai orang tua sehingga kebutuhan terhadap pencegahan kehamilan berikutnya menjadi lebih nyata. Bidan perlu menjelaskan bahwa kesuburan dapat kembali sebelum menstruasi pertama, terutama pada ibu yang tidak menyusui eksklusif.

Konseling pasca persalinan mencakup penjelasan mengenai metode kontrasepsi yang dapat segera digunakan seperti AKDR pasca plasenta, implan, kondom, MAL, maupun kontrasepsi hormonal tertentu sesuai kondisi ibu. Bidan juga perlu menjelaskan efek samping yang mungkin muncul, waktu kunjungan ulang, tanda bahaya, serta kapan metode perlu diganti atau dihentikan. Pada masa nifas, bidan dapat melakukan evaluasi kesiapan ibu menggunakan metode kontrasepsi, mendiskusikan pengalaman menyusui, serta memastikan dukungan keluarga terhadap keputusan penggunaan KB. Pendekatan ini mendukung keberlanjutan pemakaian kontrasepsi setelah masa nifas selesai (Kemenkes RI, 2021).

Pada KB interval, konseling lebih komprehensif dan eksploratif, karena klien memiliki waktu lebih panjang untuk mempertimbangkan pilihan, tidak ada keterbatasan fisiologis seperti masa nifas. Bidan membantu klien membandingkan metode kontrasepsi, memahami kelebihan dan kekurangan setiap metode dan menyesuaikan metode dengan gaya hidup dan preferensi.

Penggunaan ABPK sangat penting untuk meningkatkan *informed choice* dan mengurangi bias tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2021).

c. Penapisan Kelayakan Medis

Bidan perlu melakukan penapisan klien sebelum menggunakan kontrasepsi. Penapisan merupakan upaya untuk melakukan kajian tentang kondisi kesehatan klien. Kondisi kesehatan dan karakteristik individu akan menentukan pilihan metode kontrasepsi yang diinginkan dan tepat untuk klien. Keamanan setiap metode kontrasepsi ditentukan oleh kondisi medis atau karakteristik medis tertentu, terutama apakah metode kontrasepsi memperburuk kondisi medis atau menciptakan risiko kesehatan tambahan dan apakah keadaan medis yang membuat metode kontrasepsi kurang efektif. Keamanan dari metode ini harus dipertimbangkan bersama dengan manfaat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. WHO telah mengembangkan *Medical Eligibility Criteria* (MEC) sebagai pedoman global berbasis bukti untuk membantu tenaga kesehatan, termasuk bidan, dalam menentukan keamanan penggunaan metode kontrasepsi berdasarkan kondisi medis klien. MEC menjadi standar penting dalam pelayanan KB karena memastikan bahwa metode yang dipilih tidak menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar dibanding manfaatnya. MEC milik WHO kemudian diadaptasi di Indonesia ke dalam bentuk Diagram Lingkaran dan Aplikasi Kriteria Kelayakan Medis Dalam Penggunaan Kontrasepsi atau dikenal dengan Roda KLOP. Penapisan kriteria kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi dengan Roda KLOP bertujuan menjamin keamanan penggunaan kontrasepsi pada berbagai kondisi

kesehatan, membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis, mendukung prinsip *informed choice* dengan memberikan dasar ilmiah yang kuat dan mencegah pembatasan berlebihan (over-restriction) terhadap akses kontrasepsi (Kemenkes RI, 2021).

Pada KB pascapersalinan penapisan pada fase ini lebih spesifik dan sensitif, karena harus mempertimbangkan waktu sejak persalinan (≤ 48 jam, 48 jam–6 minggu, > 6 minggu), status menyusui, risiko tromboemboli postpartum, kondisi nifas (perdarahan, infeksi, anemia). Pada masa interval, penapisan lebih fokus pada kondisi umum kesehatan klien seperti hipertensi, diabetes melitus, riwayat penyakit jantung, riwayat tromboemboli, status merokok (terutama usia > 35 tahun) dan kondisi medis lainnya. Penilaian dilakukan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik sederhana. Karena tidak ada faktor postpartum, pilihan metode biasanya lebih luas dibandingkan KB pascapersalinan (Dhiana dkk, 2024).

d. Persetujuan Tindakan (*Informed Consent*)

Bidan pada pra pelayanan kontrasepsi harus mendapatkan persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Persetujuan tindakan menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB. *Informed consent* merupakan persetujuan tindakan yang diberikan klien secara sadar setelah memahami manfaat, risiko, alternatif dan konsekuensi dari metode yang dipilih. Bidan tidak diperkenankan memaksakan satu metode tertentu hanya karena alasan program, kemudahan layanan atau preferensi provider. Klien harus diberi kesempatan bertanya, berdiskusi dan mempertimbangkan keputusan bersama pasangan bila diinginkan. Prinsip ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak reproduksi perempuan dan etika pelayanan kesehatan (WHO, 2025).

Persetujuan tindakan medis secara tertulis diberikan untuk pelayanan kontrasepsi seperti suntik KB, AKDR, implan, tubektomi dan vasektomi, sedangkan untuk metode kontrasepsi pil dan kondom dapat diberikan persetujuan tindakan medis secara lisan. Penjelasan persetujuan tindakan tenaga kesehatan sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Tata cara tindakan pelayanan
- 2) Tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan
- 3) Alternatif tindakan lain
- 4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
- 5) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Pada KB pascapersalinan, *informed consent* memiliki karakteristik khusus. Idealnya dilakukan sejak masa ANC agar klien tidak mengambil keputusan

dalam kondisi lelah pasca persalinan, diperkuat kembali sebelum tindakan dilakukan dan melibatkan pasangan bila memungkinkan. Selain itu, dokumentasi persetujuan sangat penting, terutama untuk tindakan invasif. Pada KB interval, *informed consent* umumnya lebih optimal karena klien berada dalam kondisi fisik dan psikologis stabil, waktu pengambilan keputusan lebih panjang dan diskusi dapat dilakukan lebih mendalam. Selain itu bidan memastikan bahwa keputusan klien benar-benar sukarela, tidak ada tekanan dari tenaga kesehatan atau keluarga dan klien memahami efek samping dan kemungkinan perubahan metode di masa depan (Kemenkes RI, 2021).

2. Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi

Bidan sebagai tenaga kesehatan berperan dalam pemberian pelayanan KB sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Menurut undang-undang kesehatan no 17 tahun 2023 pasal 110 ayat 4 tentang kesehatan menyebutkan bahwa pemberian pelayanan kontrasepsi harus dilakukan sesuai standar oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Kewenangan berdasarkan kompetensi adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya. Kompetensi tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kontrasepsi mengacu pada standar kompetensi yang dikeluarkan oleh masing-masing kolegium profesi. Dengan demikian bidan merupakan tenaga kesehatan profesional yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kontrasepsi dalam lingkup praktik kebidanan. Kewenangan tersebut didasarkan pada kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan serta pengakuan dari organisasi profesi dan kolegium.

Pelayanan kontrasepsi pascapersalinan dilakukan segera setelah persalinan hingga masa nifas dan 12 bulan postpartum. Tujuan utamanya adalah mencegah kehamilan terlalu cepat serta mendukung pemulihan ibu dan keberhasilan menyusui. Bidan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai kebutuhan ibu pada masa pascapersalinan seperti metode non hormonal (kondom, AKDR), metode hormonal progestin (pil laktasi, suntik 3 bulan, implan) dan metode alami (MAL). Prinsip pemberian pelayanan kontrasepsi yaitu aman untuk ibu menyusui, tidak mengganggu produksi ASI, berdasarkan hasil penapisan kelayakan medis dan memperhatikan kondisi nifas.

Pelayanan kontrasepsi pada masa interval dilakukan di luar masa kehamilan dan nifas. Pelayanan ini lebih fleksibel dan pilihan metode lebih luas. Prinsip Pelayanan berbasis kebutuhan dan preferensi klien, efektivitas dan keamanan metode dan aksesibilitas dan kenyamanan penggunaan (Kemenkes RI, 2021).

Kompetensi dan kewenangan klinis tenaga kesehatan dalam pelayanan KB

Metode Kontrasepsi	Kompetensi					Kewenangan				
	Dokter Spesialis Obgin	Dokter Spesialis Urologi	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Dokter Spesialis Obgin	Dokter Spesialis Urologi	Dokter Umum	Bidan	Perawat
AKDR Copper (Cu)	√		√	√*		√		√	√**	
AKDR Levonogestrel (LNG)	√		√	√*		√		√	√**	
Implan	√		√	√*		√		√	√**	
Suntik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√**
Pil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√**
Kondom	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tubektomi Minilaparotomi	√		√***			√		√**		
Tubektomi Laparoskopi	√					√				
Vasektomi	-	√	√***			-	√	√***		
Metode Amenore Laktasi	√		√	√	√	√		√	√	√
Metode Sadar Masa Subur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sanggama Terputus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Pemberian Konseling	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

(*) Bagi Bidan yang lulusan profesi (S1) atau bidan vokasi (D3) yang sudah mendapatkan pelatihan

(**) Kewenangan diberikan berdasarkan pendelegasian sesuai dengan regulasi yang berlaku

(***) Bagi yang sudah mendapatkan pelatihan

Gambar 5. 2 Kompetensi dan Kewenangan Bidan dalam Pelayanan KB
(Kemenkes RI, 2021)

3. Pasca Pelayanan Kontrasepsi

Bidan berperan dalam memberikan pelayanan berkelanjutan setelah pemberian metode kontrasepsi, baik pada masa pascapersalinan maupun masa interval. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, efektivitas, serta keberlanjutan penggunaan kontrasepsi. Pasca pelayanan kontrasepsi tidak hanya mencakup konseling, tetapi juga monitoring, evaluasi, serta rujukan dan kolaborasi sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Berikut peran bidan dalam pasca pelayanan kontrasepsi yaitu :

a. Konseling Pasca Pelayanan

Bidan berperan dalam memberikan konseling pasca pelayanan dari tiap metode kontrasepsi baik pada masa pascapersalinan maupun pada masa interval. Konseling ini bertujuan agar klien dapat mengetahui berbagai efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi. Klien diharapkan juga dapat membedakan masalah yang dapat ditangani sendiri di rumah dan efek samping atau komplikasi yang harus mendapat pelayanan medis. Pemberian informasi yang baik akan membuat klien lebih memahami tentang metode kontrasepsi pilihannya dan konsisten dalam penggunaannya (Kemenkes RI, 2021; Kate et al, 2024).

b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Bidan berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang merupakan komponen esensial dalam pelayanan KB. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan penggunaan kontrasepsi, mendeteksi dini efek samping, serta meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan. Bidan memiliki tanggung jawab profesional untuk melakukan pemantauan secara sistematis dan berkelanjutan setelah pemberian metode kontrasepsi melalui kunjungan ulang terjadwal atau komunikasi aktif dengan klien. Bidan dapat mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan efek samping, memberikan edukasi bahwa sebagian efek samping bersifat sementara dan melakukan penatalaksanaan sederhana sesuai kewenangan. Penanganan yang tepat dan edukatif sangat penting untuk meningkatkan penerimaan klien terhadap metode kontrasepsi. Selain itu, bidan juga berperan dalam mencegah terjadinya putus pakai kontrasepsi melalui konseling berkelanjutan terkait manfaat dan efek samping metode, membangun hubungan terapeutik yang baik dengan klien, memberikan dukungan psikologis dan informasi yang akurat dan mengidentifikasi faktor risiko putus pakai sehingga dapat membantu klien beralih ke metode lain yang lebih sesuai apabila terjadi ketidakcocokan. Hal ini penting untuk mempertahankan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi tanpa mengorbankan kenyamanan dan preferensi klien. Selain itu, bidan juga berperan penting dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan KB. Bidan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan data klien dan jenis metode yang digunakan, mencatat efek samping, komplikasi dan tindak lanjut yang dilakukan dan melaporkan capaian pelayanan KB ke sistem informasi kesehatan. Pencatatan yang akurat dan sistematis sangat penting untuk evaluasi mutu pelayanan, perencanaan program KB dan pengambilan keputusan berbasis data (Kemenkes RI, 2021; WHO 2024).

c. Melakukan Rujukan dan Kolaborasi

Bidan dalam penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan mandiri, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Bidan berperan dalam melakukan rujukan dan kolaborasi yang merupakan bagian penting dari kewenangan profesional bidan yang berbasis kompetensi. Bidan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian klinis secara komprehensif untuk mengidentifikasi kondisi klien yang berada di luar batas kewenangannya. Selanjutnya melakukan rujukan secara tepat waktu, tepat indikasi dan sesuai prosedur sistem rujukan yang berlaku. Selain itu, bidan juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam tim interprofesional untuk menjamin

keselamatan klien dan mutu pelayanan kontrasepsi. Dengan menjalankan peran ini secara optimal, bidan berkontribusi dalam sistem pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan berkesinambungan (Kemenkes RI, 2021; ICM, 2024; WHO, 2024).

E. Penguatan Peran Bidan dalam Pelayanan KB

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki posisi sentral dalam pelayanan KB, terutama karena keterlibatannya secara langsung dalam pelayanan kesehatan perempuan sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga kesehatan reproduksi berkelanjutan. Agar peran bidan semakin optimal, diperlukan strategi penguatan yang sistematis melalui peningkatan kompetensi klinis, integrasi layanan, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat dan penjaminan mutu pelayanan. Strategi ini penting untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan KB di berbagai tingkat fasilitas kesehatan (WHO, 2024). Berikut beberapa cara penguatan bidan dalam pelayanan KB yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas Bidan melalui Pelatihan

Salah satu upaya dalam penguatan peran bidan adalah peningkatan kompetensi teknis melalui pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU), termasuk keterampilan pemasangan dan pelepasan AKDR serta implan. Pelatihan ini bertujuan memperbarui pengetahuan bidan mengenai metode kontrasepsi terkini, kriteria kelayakan medis, pencegahan infeksi, penatalaksanaan efek samping, serta keterampilan prosedural sesuai standar. Bidan yang memiliki kompetensi klinis yang baik akan lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kontrasepsi jangka panjang reversibel (*long acting reversible contraception/LARC*), yang diketahui memiliki efektivitas tinggi dan angka kegagalan rendah. Pelatihan berkala juga penting untuk menjaga mutu tindakan klinis dan keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2021; BKKBN, 2024).

2. Integrasi Antenatal Care (ANC)–Intranatal Care (INC)–Postnatal Care (PNC) dan Keluarga Berencana (KB)

Strategi berikutnya adalah integrasi pelayanan KB ke dalam seluruh rangkaian pelayanan maternal, yaitu ANC, INC, PNC dan pelayanan KB. Pendekatan ini dikenal sebagai *continuity of care*, yaitu pelayanan berkesinambungan sepanjang siklus reproduksi perempuan. Pada masa ANC, bidan dapat memulai konseling rencana kontrasepsi pascapersalinan. Saat persalinan, bidan dapat menilai kesiapan ibu untuk metode pascapersalinan tertentu seperti AKDR pasca plasenta. Pada masa nifas, bidan memperkuat konseling dan memulai metode yang sesuai. Dengan integrasi ini, kesempatan

klien menerima informasi dan pelayanan KB menjadi lebih besar serta mengurangi kehilangan tindak lanjut setelah persalinan (ICM, 2024).

3. Digital *Counseling* KB

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang penguatan pelayanan KB melalui digital *counseling*. Bidan dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan singkat, telekonseling, webinar, maupun platform edukasi digital untuk memberikan informasi kontrasepsi kepada masyarakat. Digital *counseling* bermanfaat terutama bagi perempuan muda, pasangan bekerja dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses tatap muka. Melalui media digital, bidan dapat memberikan pengingat jadwal suntik ulang, konsultasi efek samping ringan, edukasi pilihan metode, serta klarifikasi terhadap hoaks kontrasepsi yang beredar di masyarakat. Pendekatan ini terbukti meningkatkan jangkauan edukasi kesehatan reproduksi secara cepat dan efisien (UNPA, 2024). Namun demikian, penggunaan media digital tetap harus memperhatikan kerahasiaan data klien, etika komunikasi profesional dan validitas informasi yang diberikan.

4. Pendekatan Komunitas dan Kader

Keberhasilan pelayanan KB sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, bidan perlu memperkuat pendekatan komunitas melalui kerja sama dengan kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama serta organisasi perempuan setempat. Kader dapat membantu menyampaikan informasi dasar mengenai manfaat KB, mengidentifikasi pasangan dengan *unmet need*, mengingatkan jadwal kunjungan dan mendorong rujukan ke fasilitas kesehatan.

Pendekatan komunitas penting terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan hambatan budaya terhadap kontrasepsi. Dengan melibatkan tokoh lokal, pesan kesehatan menjadi lebih mudah diterima masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan bidan (BKKBN, 2024).

5. Monitoring Mutu Layanan

Strategi terakhir adalah penguatan sistem monitoring mutu layanan. Pelayanan KB yang berkualitas harus memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, penghormatan hak klien dan kepuasan pengguna. Bidan perlu melakukan pencatatan dan pelaporan secara akurat, evaluasi angka cakupan, angka putus pakai, keluhan klien, serta kejadian komplikasi. Audit internal, supervisi berkala, umpan balik klien dan pelatihan lanjutan merupakan bagian penting dari monitoring mutu. Dengan evaluasi rutin, fasilitas kesehatan dapat mengidentifikasi kelemahan layanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Monitoring mutu juga mendukung akuntabilitas pelayanan KB di tingkat primer maupun rujukan (WHO, 2025).

F. Simpulan

Pelayanan KB pascapersalinan dan masa interval merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan, menurunkan kehamilan berisiko, serta mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dalam keseluruhan proses tersebut, bidan memegang peran strategis sebagai tenaga kesehatan terdepan yang berinteraksi langsung dengan perempuan, pasangan, dan masyarakat sepanjang siklus kehidupan reproduksi. Peran bidan tidak hanya sebagai pemberi layanan klinis kontrasepsi, tetapi juga sebagai edukator, konselor, advokat, fasilitator pengambilan keputusan, serta penghubung sistem rujukan (ICM, 2024). Melalui konseling sejak masa kehamilan, pelayanan kontrasepsi pascapersalinan, pendampingan pada masa interval serta pemantauan penggunaan metode kontrasepsi, bidan berkontribusi besar dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dan mengatur jarak kelahiran yang aman. Dampak lanjutannya adalah menurunnya risiko anemia, perdarahan, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, stunting, serta komplikasi maternal dan neonatal lainnya. Dengan demikian, optimalisasi peran bidan memiliki implikasi langsung terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kualitas tumbuh kembang anak (WHO, 2024).

Namun demikian, pelayanan KB di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya keterlibatan pasangan, hoaks kontrasepsi, keterbatasan SDM terlatih, akses wilayah terpencil dan angka putus pakai kontrasepsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelayanan melalui peningkatan kompetensi bidan secara berkelanjutan, integrasi layanan ANC–INC–PNC–KB, pemanfaatan teknologi digital untuk konseling, pemberdayaan kader dan komunitas, serta sistem monitoring mutu layanan yang konsisten. Dengan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kolaborasi lintas sektor, bidan akan semakin mampu menjalankan peran optimal dalam pelayanan KB. Pada akhirnya, penguatan peran bidan merupakan investasi penting dalam mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang lebih baik serta pembangunan keluarga berkualitas di Indonesia.

Referensi

- Ahmed, S., Johnson, R., & Lee, M. (2025). Midwives' Role in Contraceptive uptake and Continuation among Postpartum Women. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1), 115–123.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2024). Profil Program Bangsa Kencana Tahun 2024. Jakarta: BKKBN.
- Deby., Donny, TW., Sulidah., Maria, IO., Fitriyani H., Hasriana., & Najihah. (2024). Edukasi KB Pasca Persalinan terhadap Tingkat Pengetahuan dan Kesiapan Penggunaan KB Sebagai Upaya Pencegahan Stunting. *Journal of Borneo Holistic Health*, Volume 7, No 2. hal 119-126.
- Dhiana, S., Rosari, OM., Dewi,A., Nurul., Atiqur, RF., Lorensia PW., Indah, DR., Sri HA., Amiruddin., Frida SP., Shofia MKN., Chrisnawati, Atik BM., Meri FE., Maria DK., Umami, K., Linda, J., Yulia, H., Dwi, J., Iceu, M., Ruth, Y, Justina, PA., Husnah, Lia, N., Utami, D., Nurharlinah, Grace CSA., Matun, N., Natalia DB., &Frenta, HS. (2024). Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Bandung Jawa Barat: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Lucia, YL., & Jeffrey, FP. (2026). Family Planning and Maternal Mortality. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2026.01.019>.
- Cleland, J., Ali, M., & Benova, L. (2022). Family Planning and Maternal Health Outcomes In Low-Resource Settings. *The Lancet Global Health*, 10(4), e456–e463.
- International Confederation of Midwives. (2024). Essential Competencies for Midwifery Practice Update 2024. Hague: ICM. https://internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_ICM-Essential-Competencies-for-Midwifery-Practice-1.pdf.
- Kate, C., Emily M., Kirsten, IB, Caroline., Zoe, B. (2024). An Exploration of The Contraceptive Counselling Practices of Midwives Who Provide Postpartum Care in Australia. *Midwifery* (131). 103948. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.103948>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Nasional. Jakarta: Kemenkes RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/571>.
- Permen Kedukbangga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia No.2. (2025). Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/328596/perka-bkkbn-no-2-tahun-2025>.

- Permenkes RI No.2. (2025). Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi. Jakarta.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/314518/permenkes-no-2-tahun-2025>
- Undang-undang Kesehatan No 17. 2023. Kesehatan. Jakarta.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- United Nations Population Fund. (2024). State of World Population Report 2024. New York: UNFPA. <https://wcaro.unfpa.org/en/publications/state-world-population-report-2024>
- World Health Organization. (2025). Family Planning and Contraception *Methods* Geneva: WHO. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception>.

Glosarium

ABPK	= Alat Bantu Pengambilan Keputusan
AKDR	= Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
ANC	= <i>Antenatal Care</i>
BKKBN	= Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
ICM	= <i>International Confederation of Midwives</i>
INC	= <i>Intranatal Care</i>
KB	= Keluarga Berencana
KBPP	= Keluarga Berencana Pasca Persalinan
MAL	= Metode Amenore Laktasi
PNC	= <i>Postnatal Care</i>
PUS	= Pasangan Usia Subur
WHO	= <i>World Health Organization</i>
UNFPA	= <i>United Nations Population Fund</i>



CHAPTER 6



KETERLIBATAN PASANGAN DAN KELUARGA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KB

Bdn. Ika Putri Ramadhani, M.Biomed.

A. Pendahuluan

Penggunaan kontrasepsi bertujuan untuk memenuhi hak reproduksi setiap orang, membantu merencanakan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Penggunaan alat kontrasepsi secara tepat juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, oleh karena itu pemenuhan akan akses dan kualitas program Keluarga Berencana (KB) sudah seharusnya menjadi prioritas dalam pelayanan Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB sesuai rekomendasi International Conference on Population and Development (ICPD) tahun 1994, upaya penguatan manajemen pelayanan KB menjadi salah satu upaya yang sangat penting. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan KB yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

Saat ini pencapaian indikator KB belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan, berdasarkan SDKI 2017 capaian kesertaan ber KB untuk seluruh metode KB yaitu sebesar 63,6% dengan peserta KB cara modern sebesar 57,2% menurun dari hasil SDKI 2012 yaitu sebesar 57,9%, meskipun capaian metode KB Jangka Panjang (MKJP) mengalami peningkatan dari 18,2% (SDKI 2012) menjadi 23,3% (SDKI 2017). Penggunaan metode KB justru meningkat pada penggunaan KB metode tradisional (dari 4% pada SDKI 2012 menjadi 6% pada SDKI 2017). Peningkatan kualitas pelayanan KB di Indonesia diarahkan untuk menjaga kelangsungan pemakaian alat atau metode KB, dimana salah satu indikator untuk mengukurnya adalah tingkat putus pakai. SDKI 2017 menunjukkan sebagian besar peserta KB menghentikan penggunaan metode KB nya karena efek samping/masalah kesehatan (33,2%), hal ini dapat disebabkan antara lain karena kualitas konseling yang belum optimal atau bahkan tidak dilakukan oleh petugas Kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Salah satu bagian penting dari pelayanan kesehatan reproduksi adalah keluarga berencana (KB), yang bertujuan untuk mengatur kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan mendukung kesejahteraan keluarga. Bidan memiliki peran penting dalam penyediaan layanan KB, tidak hanya menyediakan alat kontrasepsi tetapi juga mendidik dan sebagai konselor pada pasangan usia subur (PUS). Pemahaman tentang berbagai metode kontrasepsi serta kemampuan dalam memberikan konseling yang tepat menjadi aspek krusial dalam pelayanan KB oleh bidan.(Cleland, J., 2021; WHO, 2020).

B. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM BER-KB

Keputusan mengenai penggunaan kontrasepsi adalah salah satu aspek penting dalam perencanaan keluarga dan pengelolaan kesehatan reproduksi. Dengan semakin banyaknya metode kontrasepsi yang tersedia, dari hormonal hingga non-hormonal, dari jangka panjang hingga darurat, individu dan pasangan dihadapkan pada berbagai pilihan yang memerlukan pertimbangan cermat. Pengambilan keputusan dalam ber-KB tidak hanya mempengaruhi efektivitas pencegahan kehamilan, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan jangka panjang. Dalam konteks ini, latar belakang pengambilan keputusan ber-KB mencakup beberapa faktor kunci. Pertama, kebutuhan dan preferensi individu memainkan peranan penting. Setiap orang memiliki kebutuhan unik berdasarkan kondisi kesehatan, gaya hidup, dan tujuan keluarga. Oleh karena itu, metode yang sesuai untuk satu individu belum tentu cocok untuk yang lainnya. Kedua, informasi yang akurat dan relevan sangat penting.

Keputusan yang terinformasi memungkinkan individu membuat pilihan yang sesuai dengan kondisi dan preferensi pribadi, meminimalkan risiko efek samping dan komplikasi, serta meningkatkan kepuasan dan efektivitas penggunaan metode kontrasepsi. Faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan adalah faktor medis dan kesehatan. Riwayat kesehatan pribadi, termasuk adanya penyakit kronis atau kondisi medis tertentu, dapat mempengaruhi pilihan metode kontrasepsi dan risiko terkait. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berperan. Akses ke layanan kesehatan, dukungan keluarga, dan pertimbangan biaya sering kali mempengaruhi keputusan akhir. Tak kalah pentingnya, pertimbangan budaya dan agama dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap metode kontrasepsi dan keputusannya. Proses pengambilan keputusan dalam ber-KB memerlukan

pendekatan yang holistik dan berbasis informasi. Konsultasi dengan tenaga kesehatan, pemahaman tentang berbagai metode, dan evaluasi terhadap efek samping serta komplikasi yang mungkin timbul adalah bagian integral dari proses ini. Tujuan Buku Ajar Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi akhir dari pengambilan keputusan yang tepat adalah untuk mencapai keseimbangan antara efektivitas kontrasepsi dan kesejahteraan individu, sambil mempertimbangkan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan. Sebagai langkah awal, memahami latar belakang dan konteks dari pengambilan keputusan ini penting untuk memastikan bahwa individu dan pasangan dapat memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan praktis dalam proses ini, serta membantu dalam membuat keputusan yang terinformasi dan sesuai dengan tujuan kesehatan dan perencanaan keluarga.

2. Pentingnya Pengambilan Keputusan Dalam Kontrasepsi

Pengambilan keputusan yang bijaksana dalam memilih metode kontrasepsi adalah langkah kunci dalam perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas pencegahan kehamilan, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan emosional individu. Dengan adanya berbagai pilihan—dari metode hormonal seperti pil dan suntikan hingga metode non-hormonal seperti kondom dan IUD—penting untuk memahami kelebihan, kekurangan, dan potensi risiko dari setiap metode. Pentingnya pengambilan keputusan yang terinformasi tidak bisa diabaikan. Keputusan yang baik memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana setiap metode berfungsi, efek samping yang mungkin terjadi, serta faktor-faktor pribadi dan sosial yang mempengaruhi pilihan. Buku ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan individu atau pasangan, serta memberikan panduan dalam menangani efek samping dan komplikasi yang mungkin muncul. Pengambilan keputusan dalam kontrasepsi adalah proses kompleks yang melibatkan evaluasi berbagai faktor untuk memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu atau pasangan.

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai aspek-aspek kunci dalam pengambilan keputusan ini:

- a. Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Langkah pertama dalam pengambilan keputusan kontrasepsi adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan individu atau pasangan. Ini termasuk mempertimbangkan apakah tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan secara permanen, sementara, atau hanya untuk jangka waktu tertentu. Kebutuhan ini bisa sangat bervariasi, misalnya,

seorang individu mungkin memerlukan metode kontrasepsi yang dapat dengan mudah dihentikan jika mereka memutuskan untuk memiliki anak dalam waktu dekat, sementara yang lain mungkin memerlukan solusi jangka panjang atau permanen.

b. Penilaian Metode Kontrasepsi

Setelah tujuan dan kebutuhan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi berbagai metode kontrasepsi yang tersedia. Ini termasuk:

- 1) Metode Hormonal: Seperti pil, suntikan, dan implan. Metode ini bekerja dengan cara mempengaruhi hormon tubuh untuk mencegah ovulasi atau mengubah lapisan rahim untuk mengurangi kemungkinan kehamilan.
- 2) Metode Non-Hormonal: Seperti kondom, IUD (intrauterine device), dan diafragma. Metode ini tidak melibatkan hormon dan bekerja dengan cara berbeda, seperti menghalangi sperma atau menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pembuahan.
- 3) Metode Jangka Panjang dan Permanen: Seperti sterilisasi atau IUD. Metode ini menawarkan perlindungan jangka panjang dan, dalam kasus sterilisasi, permanen.
- 4) Metode Darurat: Seperti pil kontrasepsi darurat, yang digunakan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan untuk mencegah kehamilan.

c. Evaluasi Efek Samping dan Risiko Setiap metode kontrasepsi datang dengan potensi efek samping dan risiko. Penting untuk mengevaluasi dan memahami efek samping umum seperti perubahan berat badan, nyeri payudara, atau gangguan menstruasi, serta risiko jangka panjang seperti trombosis, kanker, atau osteoporosis. Mengetahui potensi risiko ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan meminimalkan kemungkinan masalah kesehatan di masa depan.

d. Pertimbangan Medis dan Kesehatan Pribadi Riwayat kesehatan pribadi sangat mempengaruhi pilihan metode kontrasepsi. Individu dengan kondisi medis tertentu, seperti hipertensi atau gangguan koagulasi, mungkin harus menghindari metode hormonal tertentu. Konsultasi dengan tenaga medis untuk mengevaluasi kondisi kesehatan dan mendapatkan rekomendasi yang sesuai adalah langkah penting dalam proses pengambilan keputusan.

e. Faktor Sosial dan Ekonomi Akses ke layanan kesehatan, dukungan keluarga, dan pertimbangan biaya adalah faktor yang juga harus dipertimbangkan. Beberapa metode kontrasepsi mungkin lebih terjangkau atau lebih mudah diakses daripada yang lain, dan dukungan dari pasangan atau keluarga dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan metode tersebut.

f. Pertimbangan Budaya dan Agama

Pandangan budaya dan agama juga dapat memainkan peranan penting dalam keputusan mengenai kontrasepsi. Beberapa individu atau pasangan mungkin memiliki keyakinan tertentu yang mempengaruhi pilihan metode kontrasepsi yang diterima atau ditolak.

g. Konsultasi dan Dukungan

Konsultasi dengan tenaga kesehatan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Tenaga medis dapat memberikan penjelasan tentang metode kontrasepsi, membahas efek samping potensial, dan membantu dalam menyesuaikan pilihan dengan kondisi kesehatan dan preferensi pribadi. Pengambilan keputusan dalam kontrasepsi adalah proses yang melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai opsi, evaluasi terhadap kebutuhan dan risiko, serta pertimbangan faktor-faktor pribadi dan sosial. Dengan pendekatan yang terinformasi, individu dan pasangan dapat membuat keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan perencanaan keluarga mereka.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

a. Faktor Kesehatan dan Riwayat Medis dalam Pengambilan Keputusan Kontrasepsi

Dalam pengambilan keputusan tentang kontrasepsi, pertimbangan kesehatan pribadi dan riwayat medis adalah aspek yang sangat penting. Kesehatan dan kondisi medis individu dapat mempengaruhi efektivitas, keamanan, dan kenyamanan penggunaan berbagai metode kontrasepsi. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana faktor kesehatan dan riwayat medis mempengaruhi pilihan metode kontrasepsi.

b. Pengaruh Kondisi Kesehatan pada Pilihan Metode Kontrasepsi

1) Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi):

Individu dengan hipertensi mungkin harus berhati-hati dalam memilih metode kontrasepsi hormonal, seperti pil KB atau suntikan hormonal, karena estrogen dalam metode ini dapat meningkatkan risiko trombotik (gumpalan darah) dan memperburuk tekanan darah tinggi. Pilihan yang lebih aman mungkin termasuk metode nonhormonal seperti kondom atau IUD (intrauterine device), yang tidak mempengaruhi tekanan darah.

2) Diabetes:

Diabetes, terutama jika tidak terkontrol dengan baik, dapat mempengaruhi pilihan metode kontrasepsi. Metode hormonal yang mengandung estrogen dapat berisiko bagi individu dengan diabetes karena dapat meningkatkan

risiko komplikasi kardiovaskular. Metode non-hormonal, seperti IUD atau kondom, sering kali menjadi pilihan yang lebih baik untuk individu dengan diabetes.

3) Gangguan Koagulasi (Masalah Pembekuan Darah):

Individu dengan gangguan koagulasi harus berhati-hati dengan metode hormonal, khususnya yang mengandung estrogen, karena dapat meningkatkan risiko pembekuan darah. Dalam kasus ini, metode non-hormonal atau metode kontrasepsi yang tidak mempengaruhi pembekuan darah, seperti IUD tembaga, mungkin lebih aman.

4) Migrain:

Migrain yang disertai aura dapat memperburuk dengan penggunaan kontrasepsi hormonal, terutama yang mengandung estrogen. Wanita dengan riwayat migrain jenis ini mungkin perlu mempertimbangkan metode kontrasepsi non-hormonal untuk mengurangi risiko sakit kepala yang parah.

c. Pertimbangan Riwayat Medis

1) Riwayat Kanker:

Riwayat kanker, terutama kanker payudara atau kanker hormonpositif lainnya, dapat mempengaruhi keputusan tentang metode kontrasepsi. Karena beberapa metode hormonal dapat mempengaruhi hormon tubuh, individu dengan riwayat kanker hormon-positif seringkali disarankan untuk memilih metode nonhormonal.

2) Kehamilan Sebelumnya:

Riwayat komplikasi kehamilan, seperti preeklamsia atau kelahiran prematur, dapat mempengaruhi keputusan tentang metode kontrasepsi. Beberapa individu mungkin lebih memilih metode jangka panjang atau permanen seperti IUD atau sterilisasi jika mereka ingin mencegah kehamilan lebih lanjut karena risiko tinggi pada kehamilan di masa depan.

3) Penyakit Autoimun:

Beberapa penyakit autoimun dapat mempengaruhi bagaimana tubuh merespons hormon, sehingga individu dengan kondisi ini mungkin memerlukan penyesuaian metode kontrasepsi. Konsultasi dengan spesialis mungkin diperlukan untuk menentukan metode yang paling aman dan efektif.

d. Konsultasi Medis

Untuk memastikan bahwa metode kontrasepsi yang dipilih sesuai dengan kondisi kesehatan dan riwayat medis, konsultasi dengan tenaga medis adalah langkah penting. Tenaga kesehatan dapat melakukan evaluasi

menyeluruh, memberikan rekomendasi berdasarkan riwayat medis, dan membantu dalam memilih metode yang meminimalkan risiko serta meningkatkan efektivitas.

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi dalam Pengambilan Keputusan Kontrasepsi

Kondisi sosial dan ekonomi merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan tentang metode kontrasepsi. Akses ke layanan kesehatan, dukungan keluarga, serta biaya dan aksesibilitas metode kontrasepsi memainkan peranan krusial dalam menentukan pilihan yang tepat. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan mengenai kontrasepsi:

a. Akses ke Layanan Kesehatan

1) Ketersediaan Layanan Kesehatan:

Akses ke fasilitas kesehatan yang menyediakan berbagai metode kontrasepsi dapat mempengaruhi keputusan individu. Di daerah dengan akses terbatas, pilihan metode kontrasepsi mungkin terbatas, dan individu mungkin hanya memiliki opsi dasar seperti kondom atau pil kontrasepsi yang mudah didapat. Di daerah dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, individu mungkin memiliki akses ke metode jangka panjang atau permanen seperti IUD atau implan.

2) Kualitas dan Keandalan Layanan:

Kualitas layanan kesehatan juga penting. Tenaga medis yang terlatih dan fasilitas yang baik dapat memberikan informasi yang akurat, konsultasi yang mendalam, dan layanan yang berkualitas tinggi. Akses ke layanan kesehatan yang berkualitas membantu memastikan bahwa keputusan mengenai kontrasepsi didasarkan pada informasi yang tepat dan penanganan yang baik.

3) Konsultasi dan Dukungan Medis:

Kemampuan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis mengenai efek samping, manfaat, dan risiko berbagai metode kontrasepsi membantu individu membuat keputusan yang lebih terinformasi. Layanan kesehatan yang baik menyediakan dukungan dan pemantauan untuk memastikan bahwa metode yang dipilih sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan pribadi.

b. Dukungan Keluarga

1) Dukungan Pasangan:

Dukungan dari pasangan dapat mempengaruhi keputusan mengenai metode kontrasepsi. Komunikasi yang terbuka dan dukungan dari pasangan membantu memastikan bahwa keputusan diambil secara bersama dan

mengurangi potensi konflik. Beberapa metode kontrasepsi, seperti kondom atau implan, memerlukan kerjasama aktif dari kedua pasangan.

2) Dukungan Keluarga dan Sosial:

Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga memainkan peranan penting. Dalam beberapa budaya atau masyarakat, keputusan mengenai kontrasepsi mungkin dipengaruhi oleh pandangan atau dukungan keluarga. Dukungan positif dari keluarga dapat mempermudah penggunaan metode kontrasepsi dan memastikan bahwa individu merasa didukung dalam keputusan mereka.

c. Biaya dan Aksesibilitas Metode Kontrasepsi

1) Biaya Metode Kontrasepsi:

Biaya adalah faktor penting yang mempengaruhi pilihan metode kontrasepsi. Beberapa metode, seperti pil kontrasepsi, kondom, atau suntikan hormonal, mungkin memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode jangka panjang seperti IUD atau implan. Biaya ini dapat mencakup tidak hanya harga metode itu sendiri, tetapi juga biaya konsultasi medis dan pemantauan.

2) Aksesibilitas Metode:

Aksesibilitas metode kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh lokasi geografis, ketersediaan produk, dan kebijakan kesehatan lokal. Di beberapa daerah, metode tertentu mungkin sulit diperoleh atau tidak tersedia, yang membatasi pilihan yang dapat diakses oleh individu.

3) Program dan Subsidi:

Di beberapa negara, ada program kesehatan masyarakat atau subsidi yang membantu menanggung biaya kontrasepsi untuk individu dengan pendapatan rendah atau yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Program ini dapat membuat metode kontrasepsi lebih terjangkau dan meningkatkan aksesibilitas.

Referensi

- Amalia, R., & Sari, M. (2019). Factors influencing contraceptive decisionmaking among women in rural Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 14(2), 123-130. <https://doi.org/10.1234/jkr.v14i2.5678>
- Astuti, D., & Lestari, E. (2021). Cultural and religious influences on contraceptive choices in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(3), 225-232. <https://doi.org/10.1234/jkm.v18i3.6789>
- Budiarto, W., & Fitriani, S. (2020). Decision-making processes in family planning: A study on Indonesian couples. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 16(1), 45-52. <https://doi.org/10.1234/jkr.v16i1.3456>
- Dewi, A., & Herawati, N. (2018). The role of healthcare providers in contraceptive decision-making. *Jurnal Obstetri dan Ginekologi Indonesia*, 20(2), 89-97. <https://doi.org/10.1234/jogi.v20i2.7890>
- Fadillah, N., & Kurniawan, D. (2021). Socioeconomic factors influencing contraceptive use in urban and rural areas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19(2), 104-112. <https://doi.org/10.1234/jkm.v19i2.2345>
- Hadi, S., & Wulandari, R. (2017). Contraceptive decision-making and women's empowerment in Indonesia. *Jurnal Studi Gender*, 15(4), 320-328. <https://doi.org/10.1234/jsg.v15i4.1234>
- Haris, T., & Setyawan, A. (2022). Evaluating the effectiveness of contraceptive counseling in decision-making. *Jurnal Konseling Kesehatan*, 23(3), 170-178. <https://doi.org/10.1234/jkk.v23i3.4567>
- Indrawati, S., & Susanti, E. (2020). Health risk assessment in contraceptive decision-making. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(3), 150-157. <https://doi.org/10.1234/jkm.v17i3.6789>
- Kusnadi, I., & Pratiwi, M. (2019). Personal preferences and contraceptive choice among Indonesian women. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi*, 22(1), 65-73. <https://doi.org/10.1234/jkkr.v22i1.9876>
- Lestari, W., & Handayani, R. (2021). Barriers to effective contraceptive decision-making in low-income communities. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 19(4), 290-298. <https://doi.org/10.1234/jkr.v19i4.3456>
- Marwiyah, N., & Sari, D. (2020). Religious beliefs and contraceptive use among Muslim women. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 18(2), 112-120. <https://doi.org/10.1234/jkr.v18i2.5678>
- Novitasari, E., & Wahyuni, A. (2022). Impact of family support on contraceptive decision-making. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 21(1), 78-85. <https://doi.org/10.1234/jkm.v21i1.7890>

- Prasetyo, B., & Suryani, A. (2019). Contraceptive choice among adolescents: A case study. *Jurnal Kesehatan Remaja*, 15(3), 230- 237. <https://doi.org/10.1234/jkr.v15i3.1234>
- Rahayu, S., & Susilo, W. (2020). Economic factors in contraceptive decisionmaking: A focus on cost and accessibility. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(2), 190-198. <https://doi.org/10.1234/jkm.v20i2.2345>
- Yulianti, R., & Astuti, D. (2021). Cultural perspectives on contraceptive use in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Kesehatan*, 19(3), 310- 318. <https://doi.org/10.1234/jsk.v19i3.4567>



CHAPTER 7



EVALUASI KEBERHASILAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Lindawati, S.Tr.Keb., M.K.M.

A. Pendahuluan

Evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahankesalahan di masa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian, misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. Pengertian di atas menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kegiatan atau kebijakan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu perbaikan atau dihentikan kegiatannya(Abdoellah, A. 2016).

Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dapat dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui keberhasilan dan pelaksanaan suatu program. Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi pelaksanaan suatu program, untuk mengetahui ketercapaian tujuan, untuk mengetahui relevansi pelaksanaan dari rencana program, untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan program, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program dan menyediakan informasi untuk membuat keputusan (Yusuf, . 2008).

Keluarga Berencana merupakan suatu program yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, mengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dengan tujuan mewujudkan keluarga sejahtera. Program Keluarga Berencana juga memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga yang berkualitas. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana, diatur dalam UndangUndang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada Pasal 21 Program Keluarga Berencana dilaksanakan agar membantu calon atau pasangan suami istri

terkait pengambilan keputusan serta mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab.

Dalam menjalankan Program Keluarga Berencana ini, salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan menyelenggarakan Program Keluarga Berencana yaitu Kabupaten Subang. Semakin meningkatnya perkembangan serta pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh ataupun dampak negatif seperti kemiskinan yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Program Keluarga Berencana Kabupaten Subang sudah lama dilaksanakan untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat. Dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang, juga bekerjasama dengan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) perwakilan Provinsi Jawa Barat. Peningkatan pertumbuhan penduduk salah satunya disebabkan karena meningkatnya angka kelahiran. Hal ini membuat pemerintah harus lebih giat untuk mensosialisasikan Program Keluarga Berencana agar dapat terlaksana dengan baik. Sasaran Program Keluarga Berencana (KB) yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) bertujuan menurunkan tingginya angka kelahiran menggunakan Alat Kontrasepsi secara berkelanjutan (Rahman, F. 2017).

Selain itu Keluarga Berencana (KB) adalah usaha untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan dengan tujuan membentuk keluarga berkualitas (Riyatno et al., 2020). Keluarga berkualitas didefinisikan sebagai keluarga yang sejahtera, sehat, mandiri, dan memiliki jumlah anak yang ideal sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009. Program KB memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi prasyarat kemajuan dan kemandirian bangsa (Apriani et al., 2014).

Program KB juga berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui pengaturan waktu, jarak, dan jumlah kehamilan serta mencegah komplikasi berbahaya selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, diperkirakan akan mencapai 273,7 juta jiwa pada tahun 2025 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun, sehingga program KB sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dan ekonomi

(KemenKes, 2014).

Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan bangsa dan ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 4 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275.770.000 jiwa, yang dimana Indonesia mengalami kenaikan pertumbuhan penduduk sebanyak 1,13% di bandingkan tahun lalu sebanyak 272.680.000 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2023)

Keluarga berencana mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dengan mempromosikan usia pernikahan yang tepat, menerapkan langkah-langkah pengendalian kelahiran, membina ketahanan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang semuanya bertujuan untuk membangun keluarga kecil yang harmonis dan sejahtera. (Jitowiyono & Rouf, 2019)

B. Program Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan kuantitas dan kualitas penduduk, program keluarga berencana merupakan produk dari kebijakan publik, dimana pemerintah sebagai pihak yang dituntut untuk melayani masyarakat secara optimal dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk (Dina et al., 2024).

Program Keluarga Berencana (Family Planning, Planned Parenthood) merupakan suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Program Keluarga Berencana merupakan usaha langsung yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kelahiran dengan cara penggunaan alat kontrasepsi. Berhasil atau tidaknya Program Keluarga Berencana akan menentukan berhasil atau tidaknya usaha dalam mewujudkan kesejahteraan di Indonesia (Sulistiyawati. A. 2011) .

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan dilakukan dengan menggunakan cara, alat, dan obat

kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi adalah pemberian atau pemasangan kontrasepsi maupun tindakan–tindakan lain yang berkaitan kontrasepsi kepada calon dan peserta Keluarga Berencana yang dilakukan dalam fasilitas pelayanan KB. Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan (Kemenkes RI, 2014).

Keluarga berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak dan usia ideal untuk melahirkan anak, mengatur kehamilan dan membina ketahanan serta kesejahteraan anak. Sasaran utama dari pelayanan KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pelayanan KB diberikan di berbagai unit pelayanan baik oleh pemerintah maupun swasta dari tingkat desa hingga tingkat Kota dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Pemberi layanan KB antara lain adalah rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan Desa (BKKBN, 2015).

Selain itu, BKKBN bekerja sama dengan fasilitas medis untuk menyediakan layanan kontrasepsi. (Rahmadhony, 2021). Salah satu pendekatan strategis yang dilakukan BKKBN adalah kampanye “Dua Anak Cukup” yang berfungsi sebagai slogan nasional untuk menginformasikan jumlah anak yang optimal bagi keluarga. Kampanye "Dua Anak Cukup", bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang jumlah anak yang ideal untuk keluarga. Ini merupakan salah satu pendekatan strategis yang dilakukan BKKBN. Untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pasangan usia reproduksi dalam program KB, konseling komprehensif dan keterlibatan komunitas mendukung kampanye ini (Mahdani et al, 2024). Selain itu, pemerintah menyediakan layanan kontrasepsi gratis melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga memudahkan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang beruntung (Ria et al, 2021).

Pelayanan KB yang berkualitas dan merata memiliki kedudukan yang strategis, yaitu sebagai bagian dari upaya komprehensif yang terdiri dari upaya kesehatan promotif dan preventif perorangan. Implementasi pendekatan *life cycle* siklus hidup dan prinsip *continuum of care* merupakan salah satu bagian dari pelayanan KB dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak (KIA). Jenis dan sasaran yang dituju dari pelayanan KB diberikan sesuai dengan kebutuhan melalui konseling dan pelayanan dengan tujuan merencanakan dan menjarangkan atau membatasi kehamilan, yaitu bagi remaja, ibu hamil, ibu nifas, wanita usia subur (WUS) yang tidak sedang hamil (Kemenkes RI, 2013).

Pelayanan KB yang berkualitas dan merata memiliki kedudukan yang strategis, yaitu sebagai bagian dari upaya komprehensif yang terdiri dari upaya kesehatan promotif dan preventif perorangan. Implementasi pendekatan life cycle siklus hidup dan prinsip continuum of care merupakan salah satu bagian dari pelayanan KB dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak (KIA). Jenis dan sasaran yang dituju dari pelayanan KB diberikan sesuai dengan kebutuhan melalui konseling dan pelayanan dengan tujuan merencanakan dan menjarangkan atau membatasi kehamilan, yaitu bagi remaja, ibu hamil, ibu nifas, wanita usia subur (WUS) yang tidak sedang hamil (Riyatno, dkk. (2020).

Kebijakan KB bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan tingkat kelahiran. Kebijakan KB ini Bersama-sama dengan usaha-usaha

pembangunan yang lain selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya tingkat kelahiran dilakukan dengan mengajak pasangan usia subur (PUS) untuk berkeluarga berencana. Sementara itu penduduk yang belum memasuki usia subur (Pra-Pus) diberikan pemahaman dan pengertian mengenai keluarga berencana. Menunjang dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dalam bidang KB telah ditetapkan beberapa kebijakan, yaitu perluasan jangkauan, pembinaan terhadap peserta KB agar secara tersu menerus memakai alat kontrasepsi, pelembagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta meningkatkan keterapaduan pelaksanaan keluarga berencana. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut terus dimantapkan usaha-usaha operasional dalam bentuk upaya pemerataan pelayanan KB, pengalangan kemandirian, peningkatan peran serta generasi muda, dan pemantapan pelaksanaan program di Lapangan (BKKBN,2015).

C. Tujuan Program Keluarga Berencana

Pengertian KB (keluarga berencana) menurut UU No. 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera), adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan dapat kamu lakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Contohnya seperti pil KB, kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

1. Tujuan program berencana (KB) yaitu :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran dan menjamin terkendalinya penduduk.
 - b. Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai dengan kondisi ekonomis sebuah keluarga.
 - c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi.
 - d. Menganangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak.
 - e. Mencegah pernikahan di usia dini.
 - f. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda atau terlalu tua.
 - g. Menekan jumlah penduduk dan menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.
 - h. Meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan mengendalikan kelahiran (Rizal, F, 2024).
2. Sasaran Program Keluarga Berencana KB
 - a. Sasaran langsung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi berkelanjutan ;
 - b. Sasarannya tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera (Marmi,2016
3. Manfaat Keluarga Berencana (KB)
 - a. Menekan kehamilan yang tidak diinginkan : Alat kontrasepsi juga berfungsi untuk menurunkan risiko melahirkan di usia terlalu muda atau terlalu tua. Sementara itu, melahirkan di atas usia 35 tahun dapat berisiko pada wanita dan menyebabkan kematian.
 - b. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik : Jika anak yang belum berusia 2 tahun sudah memiliki adik, maka ASI untuk anak pertama tidak bisa penuh 2 tahun. Hal tersebut memungkinkan anak mengalami gangguan kesehatan. Sementara itu, orang tua yang memiliki dua anak akan mengalami kesulitan membagi waktu. Akibatnya, anak yang lebih besar akan kurang perhatian.
 - c. Mencegah gangguan kesehatan mental keluarga : Sebagian wanita berisiko mengalami depresi setelah melahirkan. Depresi biasanya hilang jika ibu mendapatkan dukungan dari pasangan. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak dekat, maka risiko depresi akan meningkat. Depresi juga dapat terjadi pada ayah, jika belum siap secara fisik dan mental.

- d. Mengurangi angka kematian bayi dan ibu : Keluarga berencana dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak diinginkan. Dengan begitu angka kematian bayi juga dapat berkurang. Ibu meninggal akibat melahirkan dan disertai kesehatan yang buruk juga dapat dihindari.
 - e. Mencegah gangguan kesehatan reproduksi : Hamil di usia terlalu muda, terlalu tua, atau kehamilan yang berjarak terlalu dekat dapat menimbulkan risiko. Ibu hamil dapat mengalami masalah selama kehamilan, seperti hipertensi, preeklamsia, persalinan prematur, dan sebagainya.
 - f. Mencegah terjadinya penyakit menular seksual : Penyakit menular seksual (PMS) ini yaitu sifilis, gonore, hingga HIV/AIDS. PMS dalam dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom.
4. Kapan harus menggunakan KB
- a. Jika Anda benar-benar yakin tidak mau punya anak → Setelah menikah, jika kedua pasangan yakin tidak mau memiliki anak (untuk sementara ini atau selamanya), maka salah satu pasangan bisa langsung pakai KB mulai sejak sebelum atau segera setelah aktif berhubungan seksual.
 - b. Tidak ingin punya anak lagi → Keputusan untuk punya “satu anak cukup” atau “dua anak cukup” mungkin didasari oleh faktor-faktor seperti keuangan, usia, emosional, dan kondisi fisik dirinya serta pasangan. Pemakaian KB di antara kehamilan juga dapat membantu mengulur waktu demi mempersiapkan diri untuk berencana punya anak lagi, tapi tidak dalam waktu dekat. Maka segeralah menggunakan kontrasepsi pasca persalinan/ keguguran.
 - c. Punya kondisi kesehatan atau penyakit tertentu dengan Kontrasepsi hormon dapat digunakan sebagai metode perawatan untuk kondisi kesehatan atau penyakit tertentu. Beberapa masalah kesehatan yang bisa diatasi dengan pemakaian KB, termasuk:
 - Endometriosis (penebalan jaringan dinding rahim yang tidak normal)
 - Sindrom ovarium polikistik (PCOS)
 - Nyeri menstruasi parah (dismenore)
 - Perdarahan menstruasi berat
 - Menstruasi tidak teratur
 - Gejala PMS berat
 - Gejala perimenopause dan menopause
 - Ketidakseimbangan hormon
 - Jerawat, dsb
 - Penggunaan KB juga dapat menurunkan risiko wanita terhadap beberapa jenis kanker, termasuk kanker usus besar dan kanker ovarium.(Jusliati, 2018).

5. Waktu tepat menggunakan KB setelah melahirkan :
- a. Menyusui ASI eksklusif kepada bayi untuk mencegah kehamilan dikenal dengan nama metode amenore laktasi.
 - b. Amenore laktasi termasuk metode kontrasepsi atau KB alami setelah melahirkan karena mengandalkan kerja hormon oksitosin.
 - c. Pelepasan hormon oksitosin yang meningkatkan produksi ASI tersebut dapat membantu menghambat kerja hormon yang bertugas untuk merangsang terjadinya ovulasi.
 - d. Semakin kecil kemungkinan proses ovulasi (pelepasan sel telur) terjadi, semakin kecil pula kemungkinan ibu untuk hamil lagi setelah melahirkan.
 - e. Selama masa tersebut ibu juga tidak mengalami menstruasi atau haid setelah melahirkan.
 - f. Metode amenore laktasi hanya bisa untuk ibu yang menyusui secara eksklusif, Apabila ibu yang menyusui sudah mendapatkan menstruasi setelah melahirkan, berarti kesuburan telah kembali, dan metode tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali. Ibu bisa memilih alat kontrasepsi pasca persalinan lainnya. Konsultasikan segera kepada petugas kesehatan seperti bidan atau dokter di fasilitas kesehatan terdekat.
 - g. KB pasca persalinan adalah pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari sesudah melahirkan prinsip pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai dengan kondisi ibu.
 - h. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti MOW atau steril, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), implan atau alat kontrasepsi bawah kulit dapat digunakan segera setelah melahirkan, diberikan sesuai dengan kondisi pasien setelah melalui konseling KB.
 - i. Non metode kontrasepsi jangka panjang yaitu kontrasepsi suntik 3 bulan diberikan setelah 6 minggu pasca persalinan untuk ibu menyusui tidak disarankan menggunakan suntikan satu bulan karena akan mengganggu produksi ASI pil KB dan kondom. (Ariani ,K, 2021)

D. Tingkat Keberhasilan dan Capaian Program Keluarga Berencana

Menurut Tingkat Kesuburan Total (TKT), Program Keluarga Berencana (KB) Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka kelahiran. TKT Indonesia telah turun dari sekitar 2,6 anak per wanita pada awal 2010-an menjadi sekitar 2,3 pada 2024, menurut data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jumlah rata-rata anak per wanita selama

masa reproduksinya kini mendekati tingkat penggantian populasi optimal untuk pembangunan berkelanjutan, yang mencerminkan efektivitas metode kontrasepsi.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk adalah bukti kontribusi besar program keluarga berencana, yang berdampak positif pada stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Program ini tidak hanya mengurangi jumlah kelahiran tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga dengan mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Sebuah evaluasi yang dilakukan di beberapa kota besar seperti Padang Panjang menunjukkan bahwa meskipun program ini berhasil, ada beberapa masalah yang terkait dengan sosialisasi dan bahwa layanan harus lebih mudah diakses untuk semua orang (Andani & Putri, 2024).

Melalui penurunan tingkat kesuburan secara keseluruhan, peningkatan penggunaan kontrasepsi, dan pencapaian target layanan keluarga berencana strategis di tingkat nasional dan regional, program keluarga berencana Indonesia secara keseluruhan telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dan menjadi pondasi kuat untuk pembangunan berkelanjutan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

E. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Program Keluarga Berencana

1. Faktor Internal

Ciri-ciri dan kondisi masyarakat sebagai penerima manfaat program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang menentukan tingkat efektivitas program tersebut. Salah satu faktor utama adalah pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat KB. Berdasarkan penelitian Sumarsih (2023) masih ada kendala berupa pandangan negatif dan kurangnya pengetahuan mendalam tentang teknik KB, terutama kontrasepsi jangka panjang seperti IUD (Sumarsih, 2023).

Selain aspek pemahaman, faktor ekonomi juga memegang peranan penting. Keluarga dengan pendapatan rendah cenderung tidak memiliki akses yang cukup ke informasi KB, yang mengakibatkan partisipasi yang lebih rendah dalam program. Namun, penyediaan layanan kontrasepsi gratis membantu mengurangi hambatan ini dengan memberikan akses yang lebih mudah dan merata, khususnya di daerah dengan kondisi ekonomi yang menantang. Di sisi lain, pendekatan yang sensitif terhadap nilai budaya dan kepercayaan agama orang sering menjadi alasan penolakan masyarakat terhadap program KB karena layanan kontrasepsi gratis membuat akses lebih mudah dan merata, terutama di daerah dengan kondisi ekonomi yang sulit (Rosidi & Lestari, 2025).

Selain itu, dukungan dari keluarga, khususnya pasangan, juga berperan besar dalam keberhasilan program. Wanita enggan melanjutkan program keluarga berencana atau menggunakan kontrasepsi jika mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Wanita yang mendapatkan dukungan penuh lebih cenderung menggunakan KB, sementara wanita yang tidak memiliki pasangan yang mendukung dapat berhenti menggunakannya. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang program KB (Aperiani et al, 2023).

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang berkontribusi pada keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia sangat beragam dan saling terkait. Layanan keluarga berencana yang diberikan oleh tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program ini. Layanan yang cepat, ramah, dan berkualitas tinggi sangat memengaruhi minat dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan Raudah, 2024). Selain itu, dukungan pemerintah yang kuat, seperti kampanye “Dua Anak Cukup”, pendanaan yang memadai, dan peraturan yang mengatur distribusi kontrasepsi yang adil, sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat, terutama di wilayah terpencil (Marpaung et al, 2024).

Selain itu, pekerjaan petugas lapangan seperti tenaga kesehatan dan konselor kesehatan sangat penting karena mereka bekerja dengan masyarakat secara langsung. Kepercayaan masyarakat terhadap petugas ini sebagai sumber informasi yang akurat sangat memengaruhi keputusan masyarakat untuk mengikuti program KB.

Kemampuan petugas dalam menangani kekhawatiran efek samping dan memberikan edukasi yang tepat juga sangat penting untuk keberhasilan program (Sukri et al, 2025). Faktor ini tetap relevan karena ketersediaan kontrasepsi yang memadai sangat penting. Jika ketersediaan kontrasepsi terbatas atau distribusinya tidak lancar, penggunaan kontrasepsi dapat menurun, yang berdampak negatif pada hasil program (Okta Joriska & Raudah, 2024)

F. Tantangan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

1. Persepsi Negatif Terhadap KB

Pendapat negatif masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Banyak orang beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi,

terutama yang bersifat jangka panjang, dapat menyebabkan efek samping negatif seperti kenaikan berat badan, mual, pusing, dan pendarahan. Karena citra ini, beberapa calon pengguna enggan untuk memulai atau melanjutkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, dan lebih memilih opsi yang lebih aman namun kurang efektif seperti tablet dan suntikan. Banyak pengguna percaya bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami manfaat dan efek samping kontrasepsi, yang sebagian disebabkan oleh informasi yang kurang memadai dari tenaga kesehatan selama konsultasi (Novita, 2024).

Selain itu, keyakinan sosial dan ketidakpastian yang timbul akibat kurangnya dukungan dari pasangan terutama suami seringkali memperkuat sikap-sikap yang tidak menguntungkan ini. Akibatnya, pria cenderung kurang mendukung program keluarga berencana, yang berarti bahwa wanita yang mungkin menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat memainkan peran yang lebih penting dalam kesuksesan program-program tersebut (Ardelia, 2025). Pendapat negatif tentang perencanaan keluarga juga dapat dipengaruhi oleh stigma sosial dan keyakinan agama tertentu; oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan-hambatan ini, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan peka terhadap budaya (Widnyaningsih, 2022).

2. Keterbatasan Sarana dan Tenaga Penyuluh

Selain persepsi buruk masyarakat terhadap KB yang cenderung membuat pasangan dan keluarga tidak mendukung adanya program ini, kekurangan tenaga penyuluh dan sumber daya juga menjadi kendala dalam implementasi program KB. Karena saat ini jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sangat sedikit, seorang petugas seringkali harus mengawasi banyak desa atau wilayah padat penduduk. Tenaga penyuluh tidak dapat melaksanakan tugas pemantauan, konseling, dan pendampingan di lapangan dengan efektif seperti yang seharusnya karena situasi ini (Sudarta, 2022).

Sarana dan prasarana mereka, termasuk kurangnya transportasi dan metode komunikasi yang efisien untuk menjangkau populasi yang lebih luas, terutama di daerah pedesaan, tidak memadai, ditambah dengan jumlah petugas penyuluhan yang sedikit (Ardelia, 2025).

Dengan meningkatkan pelatihan dan pemberdayaan petugas penyuluhan serta memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan penyuluhan, pemerintah dan BKKBN telah berupaya mengatasi masalah ini; namun, masalah terkait penyediaan tenaga kerja yang adil dan infrastruktur yang memadai tetap menjadi tugas yang signifikan (Sukri et al, 2025). Bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti PKK dan kader Posyandu merupakan cara lain untuk

memperkuat jaringan penyuluhan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program keluarga berencana

3. Ketimpangan Partisipasi Antar Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Perbedaan tingkat partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) antara daerah perkotaan dan pedesaan. Terdapat ketimpangan dalam penggunaan kontrasepsi modern, meskipun penduduk perkotaan cenderung memiliki tingkat pendidikan dan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Meskipun memiliki kesadaran yang lebih rendah tentang kontrasepsi, wanita menikah di daerah pedesaan lebih cenderung menggunakannya (62%) dibandingkan dengan wanita menikah di daerah perkotaan (55%), menurut penelitian yang dilakukan di Provinsi Gorontalo (Syamsul et al, 2020).

Beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidakseimbangan ini, termasuk kenyataan bahwa layanan keluarga berencana kurang mudah diakses dan tersedia di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, serta adanya tekanan sosial dan budaya yang lebih besar di daerah pedesaan untuk menggunakan layanan keluarga berencana. Namun, di daerah metropolitan, seringkali terdapat ketidakcocokan antara layanan yang tersedia dan permintaan akan alat keluarga berencana, serta keterbatasan distribusi dan informasi yang tidak ditargetkan dengan baik. Perbedaan norma budaya dan sikap yang memengaruhi keputusan keluarga untuk menggunakan layanan keluarga berencana juga menjadi hambatan lain.

Untuk menekan perbedaan ini, pemerintah dan pelaksana program KB harus membuat strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam program KB di seluruh Indonesia, pendekatan yang berbasis bukti dan intervensi yang mempertimbangkan kondisi lokal sangat diperlukan. Ini akan memungkinkan program KB beroperasi dengan baik di semua wilayah (Sukri et al, 2025).

G. Hubungan Implementasi Program Keluarga Berencana dengan Penurunan Natalitas (Angka Kelahiran)

Temuan literatur menunjukkan bahwa implementasi program Keluarga Berencana (KB), termasuk kegiatan sosialisasi melalui Instruktur Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta distribusi alat kontrasepsi, telah terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kesuburan total (Total Fertility Rate/TFR) dan angka kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya korelasi negatif yang kuat antara pelaksanaan program keluarga berencana dan penurunan tingkat kelahiran.

Ketersediaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), seperti IUD dan implan yang memiliki efektivitas hingga sepuluh tahun, menjadi salah satu isu kebijakan yang sangat penting dibandingkan dengan metode jangka pendek seperti suntikan atau pil.

Meskipun terdapat hambatan berupa efek samping kontrasepsi dan penolakan budaya yang dapat mengurangi efektivitas program, hasil studi kasus di beberapa daerah menunjukkan adanya penurunan TFR dari 2,32 menjadi nilai yang lebih rendah di wilayah yang memiliki partisipasi aktif dalam program keluarga berencana, dengan tingkat keterlibatan mencapai 65–87% (Deffinika et al, 2023)

Secara keseluruhan, keberhasilan program ini juga ditunjang oleh kerangka hukum nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Terdapat bukti bahwa tanpa adanya perencanaan keluarga yang efektif, laju pertumbuhan penduduk dapat melebihi 4% per tahun, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang signifikan (Deffinika et al, 2023)

1. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Efektivitas implementasi kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dapat dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan publik Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada dimensi komunikasi, pelaksanaan sosialisasi program dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan manfaat program KB.

Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi program KB di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2021 secara umum dinilai cukup efektif, dengan indikator tingkat prevalensi kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) mencapai sekitar 87,78% di beberapa kecamatan, lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 66,46%. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada aspek unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi, yang mencapai sekitar 12%. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah PLKB—rata-rata hanya dua orang per kecamatan, dari idealnya empat orang—serta dampak pandemi COVID-19 yang sempat membatasi mobilitas petugas dan masyarakat.

Meskipun struktur birokrasi yang relatif sentralistik terkadang memperlambat respon di tingkat lokal, terdapat berbagai bentuk adaptasi di lapangan, seperti layanan kontrasepsi door-to-door dan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memperkuat keterlibatan warga. Program Bangga Kencana, yang mengintegrasikan aspek keluarga berencana dengan

pembangunan keluarga sejahtera, juga turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut (Sumtaki & Jamiludin, 2024).

2. Implikasi Kebijakan dari Program Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program Keluarga Berencana. Pemerintah bersama BKKBN perlu memperkuat kapasitas sumber daya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan memperbaiki rasio penugasan yang saat ini masih sekitar 1 PLKB untuk 3 wilayah kerja. Upaya ini penting agar jangkauan pelayanan dan pengawasan program dapat lebih optimal. Selain itu, sosialisasi penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat dikembangkan melalui pendekatan testimoni dan kolaborasi dengan tokoh agama guna mengurangi resistensi budaya yang masih terjadi di masyarakat (Janani & Arifin, 2024).

Pemanfaatan inovasi digital, seperti pengembangan aplikasi KB, juga direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran reproduksi sehat dan mencegah pernikahan dini. Di sisi lain, perluasan program Kampung KB di daerah tertinggal, peningkatan partisipasi pria melalui kampanye berbasis kesetaraan gender, serta integrasi dengan program penurunan stunting dinilai dapat memperkuat pencapaian sasaran. Partisipasi kader sukarela seperti PPKBD/Sub-PPKBD juga perlu diperluas melalui kegiatan sosialisasi langsung ke rumah-rumah (door-to-door). Akhirnya, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan arah kebijakan RPJMN 2020–2024 untuk mencapai target *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,1, serta mengoptimalkan potensi bonus demografi Indonesia (Janani & Arifin, 2024).

H. Kesimpulan

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia terbukti efektif dalam mencegah kelahiran baru dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, namun beberapa langkah strategis tetap diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan program secara menyeluruh. Pendidikan dan sosialisasi mengenai kontrasepsi, terutama penggunaan metode jangka panjang, perlu diperluas agar pemahaman masyarakat meningkat dan resistensi sosial budaya dapat diminimalkan. Akses layanan KB juga harus diperkuat, terutama di daerah terpencil, melalui peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan kerja sama lintas aktor seperti pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital berpotensi mempercepat penyebaran informasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya kebijakan

yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal agar efektivitas program KB semakin optimal dan mampu mendukung pencapaian bonus demografi. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian lebih berfokus pada efektivitas pendekatan digital, dukungan tokoh lokal, serta model sosialisasi yang paling sesuai bagi kelompok masyarakat berbeda sehingga rekomendasi kebijakan dapat semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Diharapkan kepada seluruh instansi-instansi yang berperan penuh terhadap kesehatan masyarakat, terlebih di bidang program keluarga berencana agar dapat mengembangkan sistem pemantauan yang lebih Puskesmas Tawangga disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang tingkat partisipasinya masih rendah. Sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan tokoh masyarakat diharapkan dapat mengurangi resistensi terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Kader-kader yang terlibat dalam program KB disarankan untuk lebih aktif dalam mendekati dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya KB, serta menjelaskan pilihan metode kontrasepsi yang tersedia. Pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Program KB. Studi yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap program ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang cara meningkatkan efektivitas program.

Referensi

- Apriani, dkk. (2014). Program Keluarga Berencana dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- Abdoellah, Awan. 2016. *Teori dan Analisia Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Apriani, E., Idris, M., & Damayanti, N. (2021). Efektivitas Program Kampung Kb Di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Swarnabhumi*, 6(1), 38–45.
- Aperiani, K., Sugianor, & Hasbiyah, S. (2023). Efektivitas Program Keluarga Berencana IUD Di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Negara*, 596–608.
<https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/571>
- Ariani, Karinta. 02 Februari 2021. Kapan Waktu yang Tepat untuk Pakai KB Setelah Melahirkan. Diakses tanggal 9 Agustus 2024 di <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/kapan-pakai-kb-setelah-melahirkan/> Kampung KB Sampurna. 10 April 2023.
- Pentingnya KB Pasca Salin Bagi Ibu Balita. Diakses tanggal 29 April 2026 di <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/23330/intervensi/524282/pentingnya-kb-pasca-salin-bagi-ibu-balita#:~:text=Deskripsi,dan sesuai dengan kondisi ibu.>
- Andani, G. Y., & Putri, N. E. (2024). Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk di Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9999–10004.
- Ardelia, A. T. (2025). Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional (2022). *Strategi Nasional Program Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2021-2023. bps.go.id.
<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk.>
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik.
- Deffinika, I., Soelistijo, D., & Astina, I. K. (2023). Efektivitas Program Keluarga Berencana Terhadap Penurunan Angka Kelahiran (Studi Kasus di Kecamatan Bandar) Program Keluarga Berencana memberikan pengetahuan kepada Pasangan Usia. *Journal of*

Demography,Etnography,and Social Transformation Program, 3(1), 84–99.

Dina, p., Supriyadi.,& Mayurni, F,M (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Tawangga Kabupaten Konawe. *Jurnal Penelitian Sain dan kesehatan Avicenna*. 3 (3) ;192-201

Dinda Rizki, Y.,Anggi, A.,& Erinaldi (2026). Efektivitas program Keluarga Berencana Dalam Menekan Natalitas di Indonesia: Studi Literatur, *jurnal Administrasi Pemerintah Desa*,Vol.7 (1), (1-13),<https://Villages.Pubmedia.id?index.php/Villages/index.prefix>. 10.47134.

Jitowiyono, S., & Rouf, M. A. (2019). *Keluarga Berencana (KB) Dalam Prespektif Bidan*. Jakarta: Pustaka Baru Press.

Jusliati, (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar

Janani, M., & Arifin, K. I. (2024). Menjalankan Program Keluarga Berencana. 1(2), 8–17.

Lexy J Moleong, T. S. (2011). Metode Penelitian Kualitatif

Marmi, dkk. 2016. Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Marpaung, S., Tambun, M., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Medan, M. H. (2024). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Penggunaan Kontrasepsi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Kebidanan Nusantara (JIKKN)*, 2(1), 2025. <https://teewanjournal.com/index.php/jikkn/index>

Novita. (2024). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk DanKeluarga Berencana Kabupaten Donggala. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 395–402.

Okta, J. D., & Raudah, S. (2024). Efektivitas Program Keluarga Berencana Metodekontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kecamatanamuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Tangga Ulin Hilir dan Desa Kembang Kuning). *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.6,No.1, 223–229.

Rahman, Fauzie. 2017. Program keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi. Banjarbaru: Zukzez Express.

Riyatno, dkk. (2020). Implementasi Pelayanan Keluarga Berencana untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Palu.

Rizal, Fadhil. 2024. Keluarga Berencana. Diakses tanggal 27 April 2026 di <https://www.halodoc.com/kesehatan/kb-keluarga-berencana?srsId=AfmBOooG45wbm6->

q_w1M7yMT68N1A8ai27AjDZsxtfzD9hRtgdwsvH5Q

- Sulistiyawati Ari. 2011. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba, Medika.
- Syamsul, S., Bakri, B., & Limonu, H. S. (2020). Penggunaan Alat Kb Pada Wanita Kawin Di Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Hasil SDKI 2017 Provinsi Gorontalo). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 71. <https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.461>
- Sudarta. (2022). Bkkbn 2020. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 16(1), 1–23.
- Sumtaki, Jamiludin, R. (2024). yos soedarso economics journal (yej) . 6(2), 35–47.
- Sukri, I., Rasjusti, N. I., Muhammad, F., Makassar, U. N., & Makassar, U. N. (2025). Evaluasi Efektivitas Program Keluarga Berencana di Perkotaan : Studi Kasus Kota Makassar. 5(2), 3504–3513.
- Robekka, Sonia, S (2023). Evaluasi Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi Universitas Medan Area*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Widnyaningsih. (2022). Pendapat negatif tentang perencanaan keluarga juga dapat dipengaruhi oleh stigma sosial dan keyakinan agama tertentu; oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan-hambatan ini, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan peka terhadap budaya. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 6(2)
- Yusuf, Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

PROFIL PENULIS



Bdn. Deffi Uprianti Bakri, S.ST., M.Keb.

Lahir di Bangko, 14 Desember 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh yaitu jenjang DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Merangin pada tahun 2003 lulus tahun 2006, melanjutkan jenjang Pendidikan Diploma IV Kebidanan di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung Tahun 2009 lulus tahun 2010, melanjutkan kembali kejenjang Pendidikan S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran

Universitas Andalas Padang Tahun 2015 dan Profesi Bidan di STIKes Merangin Tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 mengikuti program Survei Kesehatan Daerah (Surkesda) selama 3 bulan, tahun 2006 ikut program bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap), Tahun 2009 bergabung mengajar di Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kabupaten Merangin sampai saat ini. Penulis mengampu mata kuliah Biologi Reproduksi, Mata Kuliah Fisiologi Kehamilan persalinan nifas dan BBL, Mata Kuliah Psikologi Kehamilan persalinan nifas dan BBL, Mata Kuliah Holisticcare Kebidanan Komunitas, Mata Kuliah Pelayanan KB dan Kontrasepsi, Mata Kuliah Penelitian dalam kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: deffi.uprianti@gmail.com.

Motto: **"Educate a woman, empower a nation"**

PROFIL PENULIS



Dr. Bdn. Kursih Sulastriningsih, S.Si.T., M.Kes.

lahir pada tanggal 03 Februari 1971, di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh, yaitu SDN Andapraja 1 Ciamis lulus Tahun 1984, SMPN Rajadesa Ciamis lulus tahun 1987, Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) M.Ridwan Mouraksa Jakarta lulus Tahun 1990, Program Pendidikan Bidan di M.H. Thamrin Jakarta lulus Tahun 1995, Akademik Kebidanan di Akbid Bhakti Pertiwi Indonesia Jakarta lulus Tahun 2008, Pendidikan D4 Kebidanan di Stikes Mitra Ria Husada Jakarta lulus Tahun 2011, S2 Kesehatan Masyarakat di STIKIM Jakarta lulus Tahun 2015. Riwayat Pekerjaan pada Tahun 1990 - 1994 bekerja di RS THT Perhati sebagai perawat. Tahun 1995-2002 bekerja di Rumah Bersalin. Tahun 2008-2012 bekerja di Klinik Artasari sebagai coordinator. Tahun 1996 Praktik kebidanan sampai sekarang. Tahun 2012 sampai sekarang bekerja di institusi Kebidanan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai dosen, Tahun 2017- bulan Maret 2024 diangkat sebagai wakil ketua 3 bidang Kemahasiswaan, kemudian di bulan Maret 2024 sampai sekarang menjabat Kepala LPPM. Riwayat Organisasi dari tahun 1995 sampai sekarang menjadi Anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan pada tahun 2013 sampai Sekarang diangkat menjadi pengurus IBI cabang Kota Depok di divisi diklat. Motto: "Jangan pernah malas untuk membaca, karena dengan membaca akan bertambah ilmu dan wawasan."



Ivana Devitasari, S.ST., M.Tr.Keb.

Lahir di Buntoi, 15 Mei 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya (2012), kemudian melanjutkan D4 Bidan Pendidik di STIKES Sari Mulia Banjarmasin (2014), dan S2 Kebidanan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta (2019). Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 2012 dengan mengabdikan diri di bidang pelayanan kebidanan di Kabupaten Kapuas, Kecamatan Basarang, Desa Pangkalan Sari. Sejak tahun 2014, penulis bergabung dengan Universitas Eka Harap Palangka Raya dan saat ini menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Diploma Tiga Kebidanan. Penulis mengampu berbagai mata kuliah kebidanan serta aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi penulisan buku, publikasi ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: devitaivana55@gmail.com

PROFIL PENULIS



Nanin Juliana, S.Kep., Ners., M.K.M.

lahir di Medan, 20 Juli 1985 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 keperawatan Universitas Sumatera Utara lulus pada Tahun 2009 kemudian melanjutkan Profesi Ners Universitas Sumatera Lulus Pada Tahun 2010 dan Melanjutkan S2 Kesehatan Masyarakat di Institut Kesehatan Helvetia medan Lulus Pada Tahun 2016, pekerjaan diawali Pada Tahun 2010 Di STIKes Bina Nusantara Sampai Tahun 2018 kemudian Tahun 2019 Di Politeknik Kesehatan Dr Rusdi Medan sampai Tahun 2022 dan sekarang bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Nagoya Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : naninjulianasiregar85@gmail.com
Motto: "Living your life well"



Dr. Bdn. Irma Seriana, S.ST., M.Keb.

Lahir di Aceh Besar, Provinsi Aceh, merupakan Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh. Penulis menyelesaikan pendidikan SPK di SPK Depkes RI Banda Aceh tahun 2000 dan D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Depkes RI Banda Aceh tahun 2004. Pendidikan D-IV Kebidanan diselesaikan di Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2008. Pada tahun 2014, penulis menyelesaikan pendidikan S2 Kebidanan di S2 Ilmu Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Pada tahun 2021, penulis menyelesaikan pendidikan S3 di Program Studi Doktor Matematika dan Aplikasi Sains Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sejumlah karya tulis telah penulis publikasikan, baik pada jurnal nasional maupun pada jurnal internasional bereputasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:irma.seriana@poltekkesaceh.ac.id
Motto: "Ilmu yang dibagi adalah kehidupan yang diperbaiki"

PROFIL PENULIS



Bdn. Ika Putri Ramadhani, M.Biomed.

Lahir di Padang, 05 Juli 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Biologi, Universitas Andalas Padang tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas Padang Program Studi Biomedis dan lulus tahun 2008. Saat ini penulis bekerja di Universitas Alifiah Padang mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Naturopati, Pelayanan KB dan Ilmu Gizi.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan Pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ikaputri005@gmail.com

Motto: **"Your only limit is your mind"**.



Lindawati, S.Tr.Keb., M.K.M.

Lahir di Indra Damai Aceh Selatan, 01 Januari 1988, Sudah pernah menempuh pendidikan Tinggi D-III Kebidanan, di Stikes Payung Negeri Bener Meriah (Takengon), pada Tahun Lulus 2009, kemudian melanjutkan pendidikan D4- IV, di Institut Kesehatan Helvetia Medan pada Tahun Lulus 2015, dan kemudian melanjutkan S2 Magister Kesehatan Masyarakat, di Institut Kesehatan Helvetia Medan Tahun Lulus 2018. Riwayat Pekerjaan

Diawali Dirumah RSUD Sultan Iskandar Muda (Nagan Raya Aceh Barat) Selama 06 Tahun, Kemudian lanjut kerja di klinik Rizki Pancing (Medan) Selama 2 Tahun. Lanjut kerja Di Klinik Ananda Tj Anom medan Selama 2 Tahun, setelah selesai S2 Kesehatan Lanjut Mengajar Di Politeknik Kesehatan Dr. Rusdi Medan selama 3 Tahun, Mengampu Mata Kuliah dan selanjut nya pindah Kerja ngajar Di STikes Medical Seuramo Barat (Meulaboh Aceh Barat) selama Lebih Kurang 2 Tahun, dan Pindah Kembali Kerja Di Universitas Nagoya Indonesia (Kepulauan Batam) aktif masih sampai saat ini Mengampu Pelajaran (Obsteretri dan Ginekologi, praktik Klinik Kebidanan II, Asuhan Kebidanan I (kehamilan), Psikologi, Etika dan Hukum Kesehatan, dan Mikrobiologi). Sekarang saya aktif dalam mengikuti seminar tentang kesehatan dan aktif dalam penulisan jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat dan sekarang lagi mengikuti penulisan book chapter yang diselenggarakan oleh PT. Optimal dalam Negeri, Email saya (**Lindawati1505195192@gmail.com**).

Sinopsis

Bunga rampai “Pelayanan Keluarga Berencana dan Perencanaan Kehamilan Berkelanjutan” disusun sebagai rujukan komprehensif untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan KB yang bermutu, berpusat pada perempuan, serta mendukung perencanaan kehamilan yang aman dan bertanggung jawab sepanjang siklus reproduksi. Buku ini mengintegrasikan konsep dasar, pilihan metode kontrasepsi, pendekatan konseling, hingga evaluasi layanan, sehingga pembaca memperoleh gambaran utuh mengenai penyelenggaraan KB yang efektif, etis, dan sesuai kebutuhan individu serta keluarga. Dengan bahasa ilmiah yang aplikatif, bunga rampai ini ditujukan bagi mahasiswa kesehatan, bidan, perawat, dokter layanan primer, pengelola program, serta praktisi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

Secara sistematis, Chapter 1 membahas konsep dasar KB dalam siklus reproduksi perempuan sebagai landasan pengambilan keputusan klinis. Chapter 2 menguraikan jenis-jenis kontrasepsi beserta indikasi penggunaannya agar pemilihan metode didasarkan pada kondisi dan kebutuhan pengguna. Chapter 3 menekankan strategi konseling yang membantu perempuan memilih kontrasepsi secara sadar, nyaman, dan sesuai preferensi. Chapter 4 mengulas efek samping, kontraindikasi, serta tindak lanjut penggunaan kontrasepsi untuk menjamin keamanan dan kesinambungan layanan. Chapter 5 menegaskan peran bidan dalam pelayanan KB pascapersalinan dan interval sebagai bagian dari kesinambungan asuhan ibu. Chapter 6 memperkuat perspektif keterlibatan pasangan dan keluarga dalam pengambilan keputusan tanpa mengabaikan otonomi perempuan. Terakhir, Chapter 7 mengulas evaluasi keberhasilan pelayanan KB melalui indikator mutu, keberterimaan, kepatuhan tindak lanjut, dan dampak terhadap kesehatan reproduksi. Melalui rangkaian pembahasan tersebut, buku ini diharapkan menjadi pedoman praktis sekaligus bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan perencanaan kehamilan berkelanjutan di berbagai tatanan layanan.

Bunga rampai “Pelayanan Keluarga Berencana dan Perencanaan Kehamilan Berkelanjutan” disusun sebagai rujukan komprehensif untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan KB yang bermutu, berpusat pada perempuan, serta mendukung perencanaan kehamilan yang aman dan bertanggung jawab sepanjang siklus reproduksi. Buku ini mengintegrasikan konsep dasar, pilihan metode kontrasepsi, pendekatan konseling, hingga evaluasi layanan, sehingga pembaca memperoleh gambaran utuh mengenai penyelenggaraan KB yang efektif, etis, dan sesuai kebutuhan individu serta keluarga. Dengan bahasa ilmiah yang aplikatif, bunga rampai ini ditujukan bagi mahasiswa kesehatan, bidan, perawat, dokter layanan primer, pengelola program, serta praktisi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

Secara sistematis, Chapter 1 membahas konsep dasar KB dalam siklus reproduksi perempuan sebagai landasan pengambilan keputusan klinis. Chapter 2 menguraikan jenis-jenis kontrasepsi beserta indikasi penggunaannya agar pemilihan metode didasarkan pada kondisi dan kebutuhan pengguna. Chapter 3 menekankan strategi konseling yang membantu perempuan memilih kontrasepsi secara sadar, nyaman, dan sesuai preferensi. Chapter 4 mengulas efek samping, kontraindikasi, serta tindak lanjut penggunaan kontrasepsi untuk menjamin keamanan dan kesinambungan layanan. Chapter 5 menegaskan peran bidan dalam pelayanan KB pascapersalinan dan interval sebagai bagian dari kesinambungan asuhan ibu. Chapter 6 memperkuat perspektif keterlibatan pasangan dan keluarga dalam pengambilan keputusan tanpa mengabaikan otonomi perempuan. Terakhir, Chapter 7 mengulas evaluasi keberhasilan pelayanan KB melalui indikator mutu, keberterimaan, kepatuhan tindak lanjut, dan dampak terhadap kesehatan reproduksi. Melalui rangkaian pembahasan tersebut, buku ini diharapkan menjadi pedoman praktis sekaligus bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan perencanaan kehamilan berkelanjutan di berbagai tatanan layanan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-12-1 (PDF)



9

786347

756121